

พว.วรารัตน์ บุญนสะ (Wararat Boonnasa RN, MA)



ตำแหน่งปัจจุบัน

พยาบาลผู้ชำนาญการและ พยาบาลประสานงานพัฒนาคุณภาพ

สถานที่ทำงาน

หน่วยพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2539

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2549

หลักสูตรการสอนเฉพาะทางคลินิก ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ปี 2553

ประสบการณ์การทำงาน

2539 – 2557

พยาบาลหน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิกส์

2557 – 2558

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิกส์

2545 – ปัจจุบัน

AO Educator Nurse (2543-ปัจจุบัน)

พยาบาลประสานงานพัฒนาคุณภาพภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด

ผู้เยี่ยมชมสำรวจของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Nurse Organizer Siriraj Hip Fracture Liaison Service

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- พฤษภาคม 2556 วิทยากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional Faculty) หัวข้อ Ankle Fracture ในการอบรม AO Principle Course for ORP in Auckland New Zealand 15th- 17th May 2013
- ปี 2556 ได้รับรางวัลผู้มีวัฒนธรรมศิริราช ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
- ปี 2559 ผู้เยี่ยมชมสำรวจโรงพยาบาลของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงาน Siriraj Hip Fracture Liaison Service ได้รับรางวัล Gold Level criteria of the Capture the Fracture program from International Osteoporosis Foundation
- ปี 2564 Committee Special interest group(Secondary fracture prevention) for Fragility Fracture Network

ที่มา: ภาพประกอบในสไลด์จาก

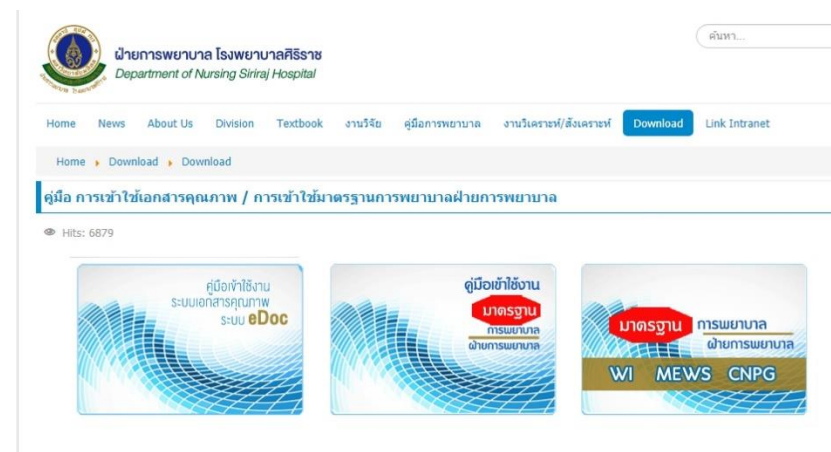
➤ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล



➤ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด



➤ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช



การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการรับรองเฉพาะโรค (พยศศ 507)

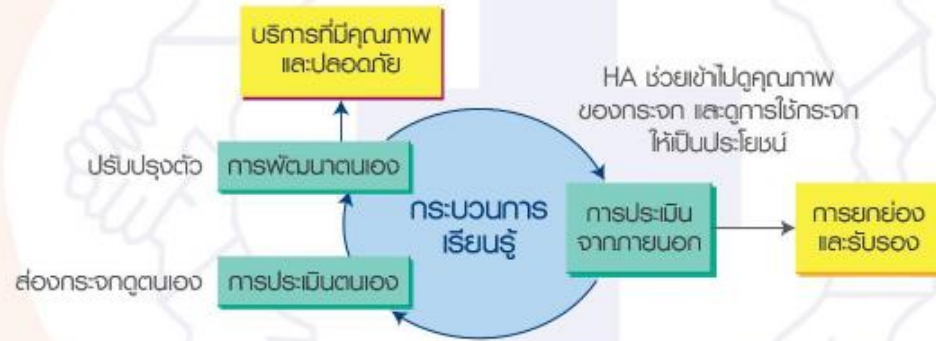
พว.วรรัตน์ บุญณะ
หน่วยพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

Wisdom of the Land



สสว. คือ ผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมคุณภาพ Change Catalyst



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดย สสว. มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ" (change catalyst)

พันธกิจ (Mission)

"ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ โดยใช้การประเมินตนเอง การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลไกกระตุ้น"

Accreditation is an Educational Process

ส่งผลกระทบ
เพื่อพัฒนาตนเอง

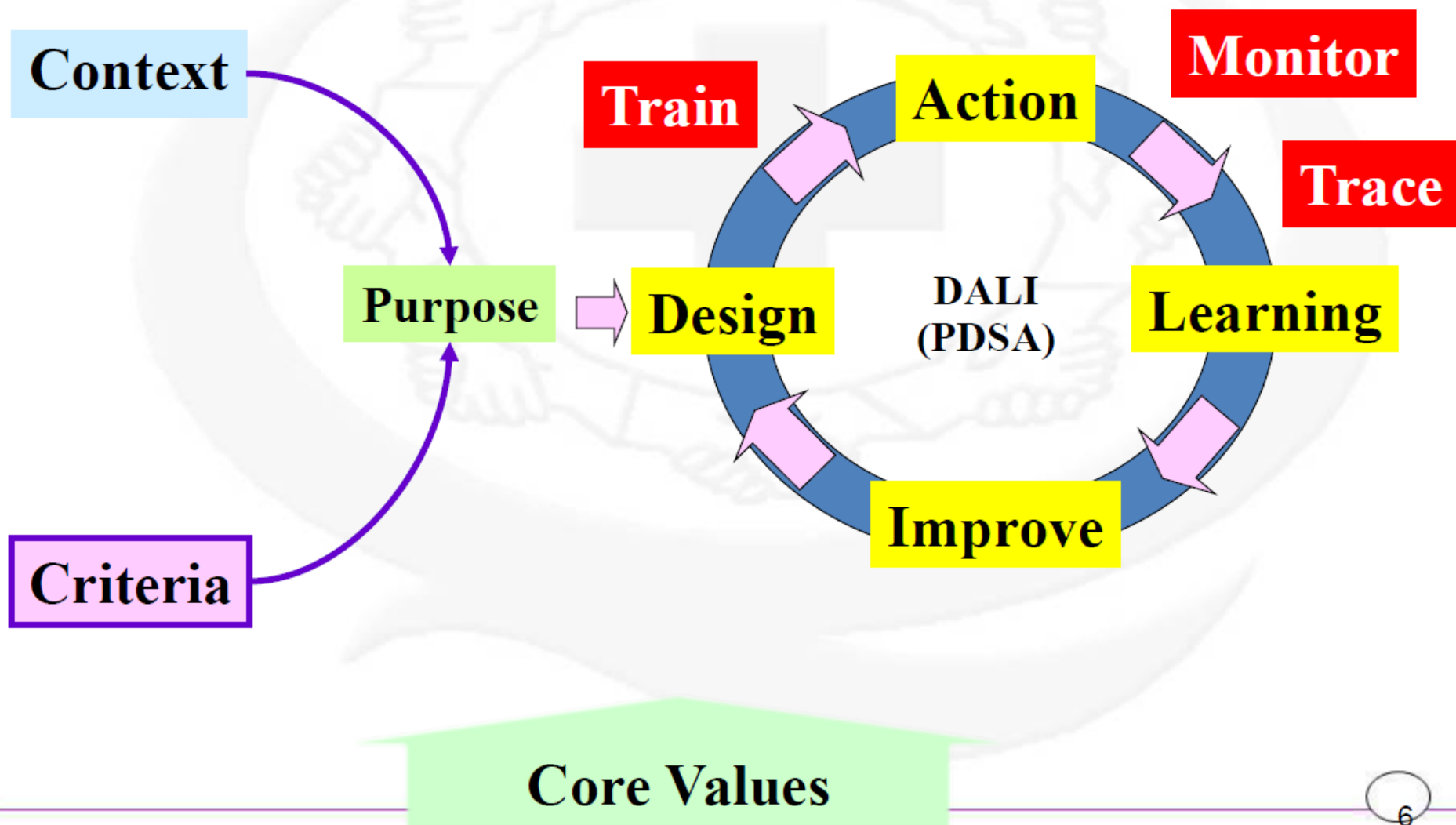


- 1) HA คือกระบวนการเรียนรู้มิใช่การตรวจสอบ
- 2) การเรียนรู้สำคัญเกิดจากการประเมินและพัฒนาตนเองในโรงพยาบาล
- 3) เป้าหมายของ HA คือการส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
- 4) ผู้เยี่ยมชมสำรวจเป็นผู้แทนของ สรพ. เป็นแขกรับเชิญของโรงพยาบาล เป็นกัลยาณมิตร มิใช่ผู้พิพากษา มิใช่ผู้ตรวจสอบ
- 5) การเยี่ยมชมสำรวจคือการยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลและการกระตุ้นให้เห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กว้างขึ้น
- 6) ความสำเร็จของการเยี่ยมชมสำรวจคือความสุขของผู้ได้รับการเยี่ยมชมสำรวจ แม้ว่าจะมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 7) การรับรองคือการให้กำลังใจในการทำดีและส่งเสริมให้ทำดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิใช่การตัดสินได้ตก

Cycle of Learning & Improvement



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

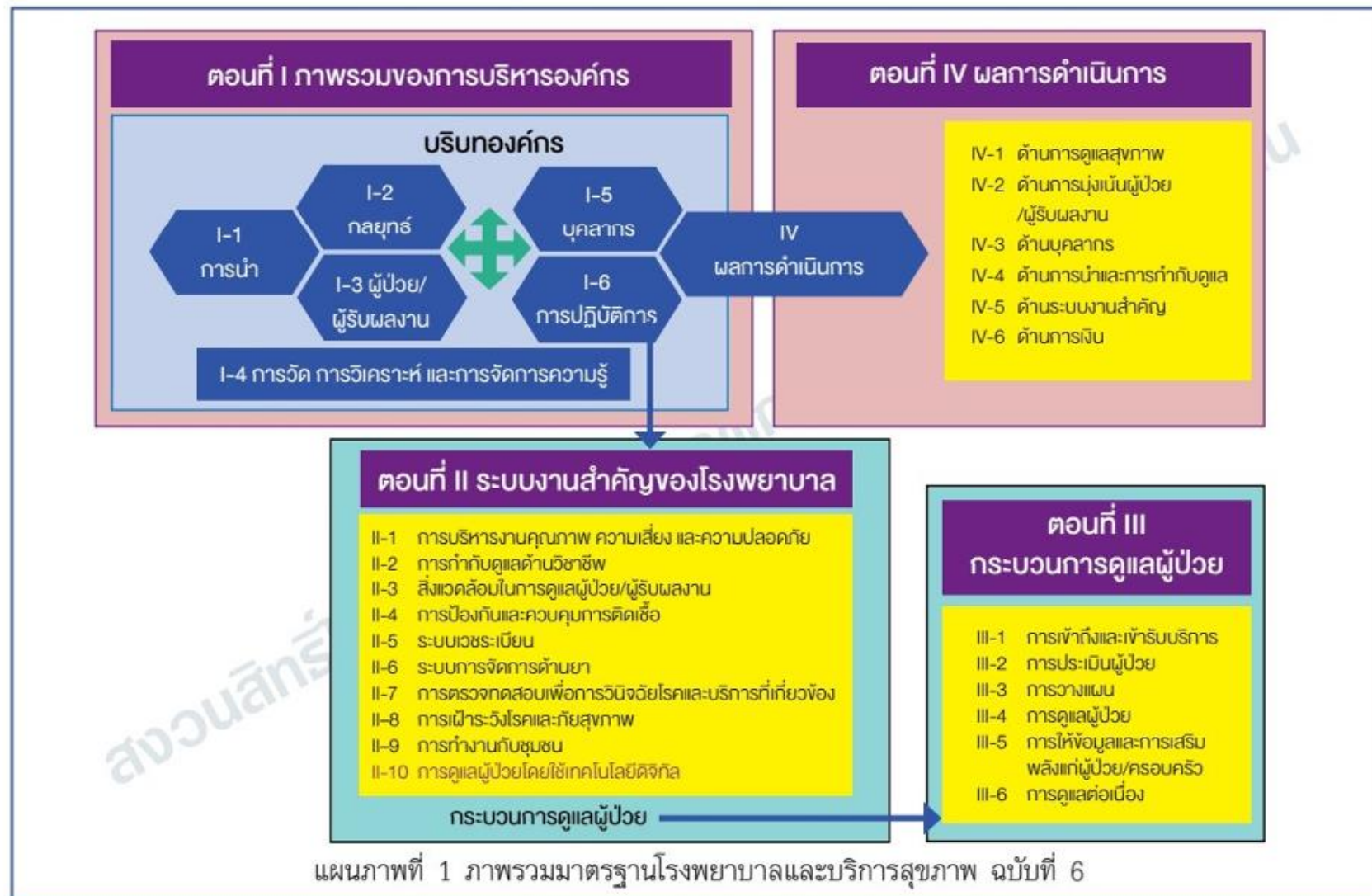




เริ่มใช้ฉบับที่ 6 วันที่ 1 ตุลาคม 2569



แนวทางการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 6



3P : Basic Building Block

Purpose → Process → Performance

จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร

3P ในงานประจำวัน

3P ในโครงการพัฒนาคุณภาพ

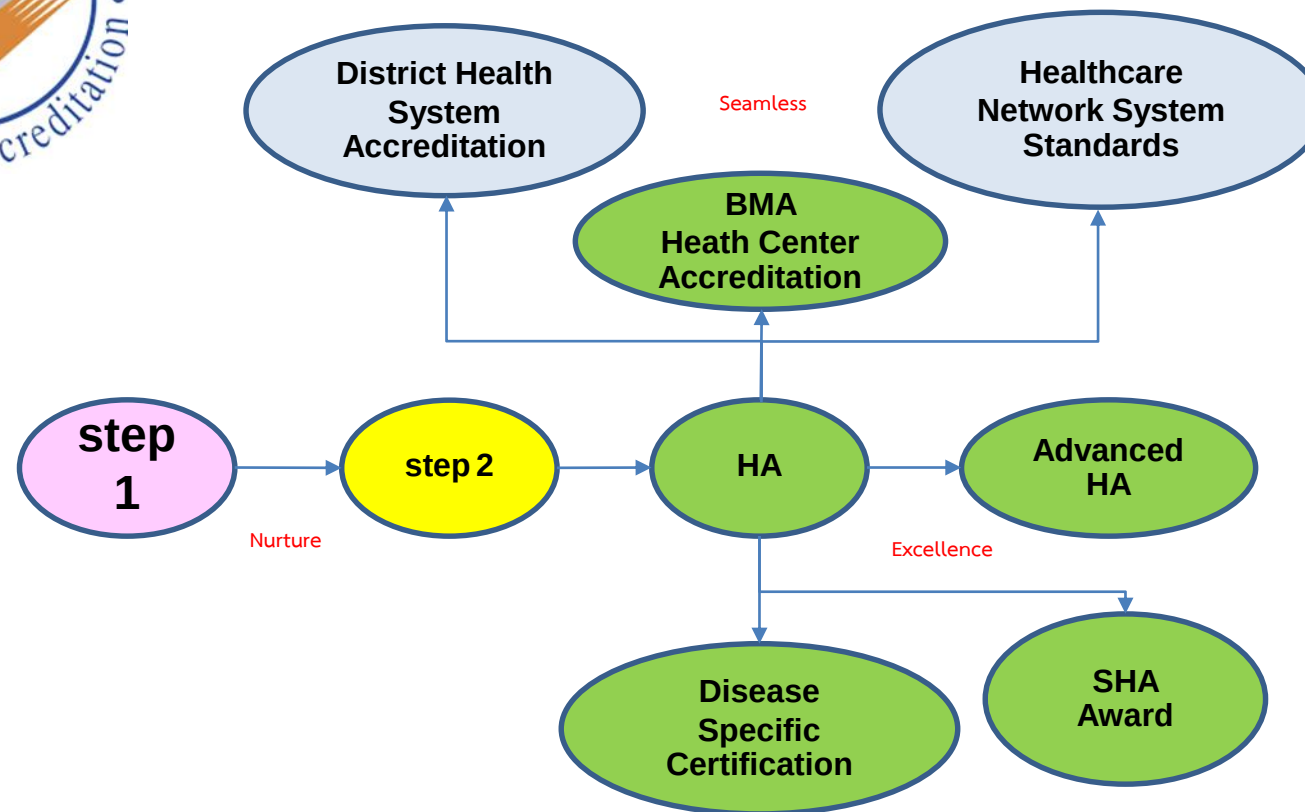
3P ในระดับหน่วยงาน (service profile)

3P กับการพัฒนาระบบงาน

3P กับการดูแลผู้ป่วย (clinical tracer)

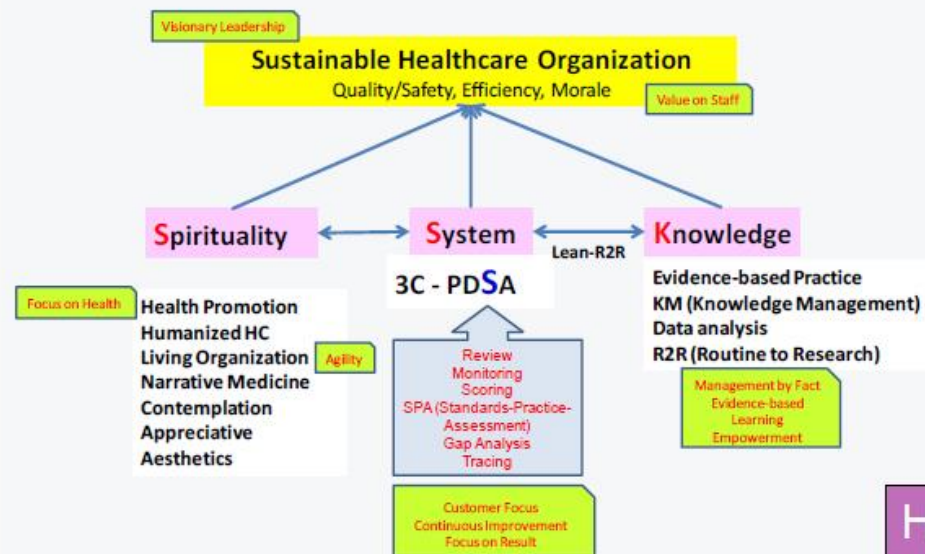
3P กับการบริหารองค์กร (strategic management)

โปรแกรมการรับรองของ สรพ.





Spirituality in Healthcare Journey



Self: Awareness

Team: Deep listening & productive discussion

Patient: Humanized Healthcare, empowerment

Org.: Living Organization

Env: Healing Environment

Survey: Appreciation

Tool: Narrative/storytelling



PDSC-SHA

Spirituality in Healthcare

Humanized Healthcare

Health Promoting Hospital (HPH)

Hospital Accreditation (HA)

Quality Improvement/Quality Management

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22





แนวคิดและหลักการของ DSC

- ส่งเสริมให้สถานพยาบาลพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค / เฉพาะระบบ (DSC)
- ช่วยยกระดับการพัฒนาของระบบการดูแลผู้ป่วย รายโรคหรือระบบเฉพาะ ให้มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นระบบการดูแล ผู้ป่วย รายโรคหรือระบบเฉพาะ
- เมื่อรวบรวมได้หลายโรค/หลายระบบ จะก้าวสู่การขอรับรอง Advanced HA

วัตถุประสงค์ของ DSC

- ค้นหาและยกย่อง Clinical Excellence
- ส่งเสริมการใช้แนวคิด continuous improvement ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง
- เป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้เรียนรู้

คุณสมบัติพื้นฐานของสถานพยาบาล

- 1.1. สถานพยาบาลต้องผ่านการรับรองคุณภาพ HA ชั้น 2 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- 1.2. สถานพยาบาลต้องสามารถแสดงให้เห็นกระบวนการการดูแล การออกแบบการบริการและ ผลลัพธ์ระดับแนวหน้าของประเทศ หรือนานาชาติ
- 1.3. มีการนำแนวคิดคุณภาพและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

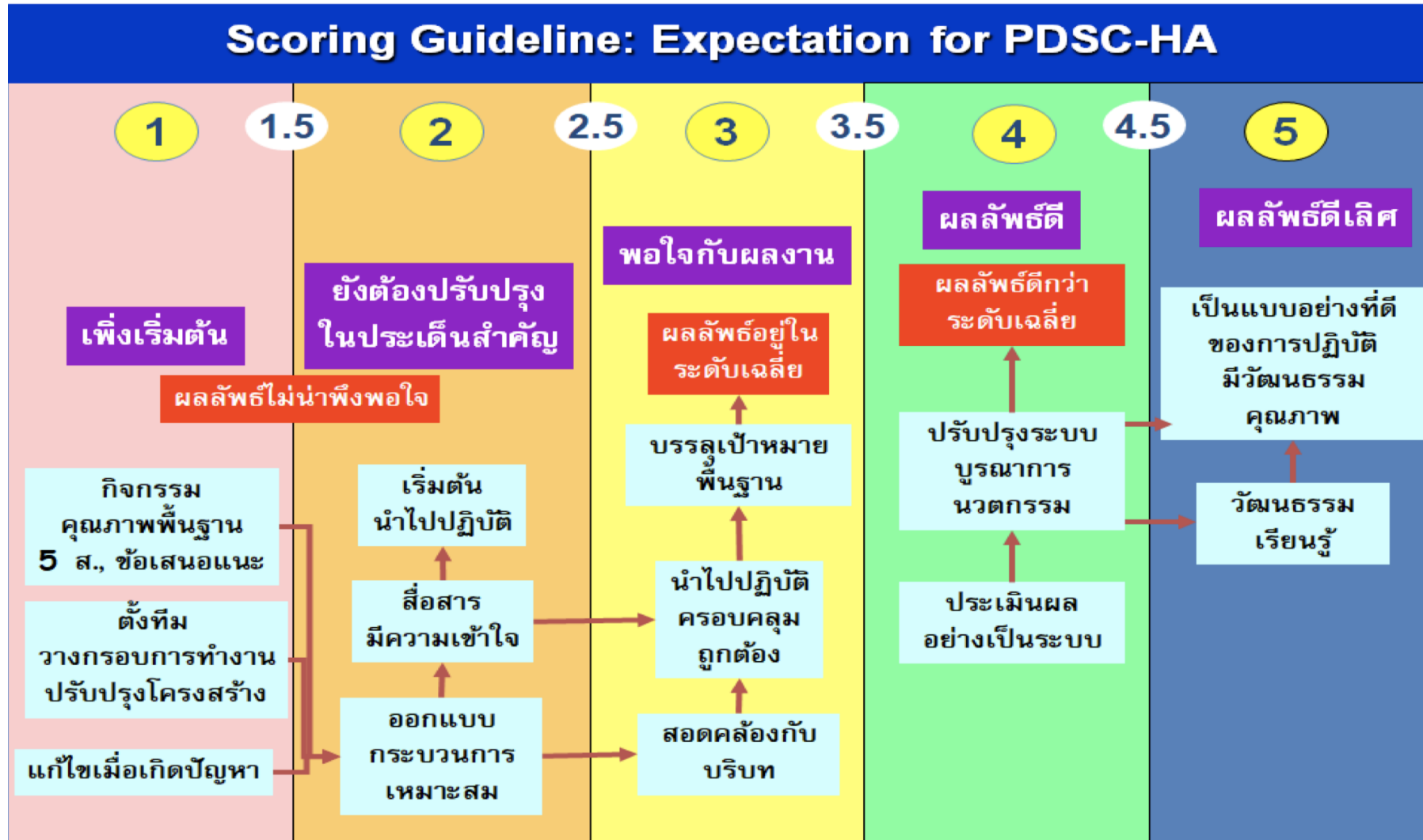


1.Process Management แสดงให้เห็นการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบกับกระบวนการสำคัญที่ครอบคลุม

2. Result แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีถึงดีมากและแนวโน้มที่ดีขึ้น มีการใช้ข้อมูลเทียบเคียงที่ทำหาย อย่างเป็นรูปธรรม

3. Learning (Evaluation & Improvement, Integration, Innovation) แสดงให้เห็นการประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เฉพาะโรค/ระบบที่ขอรับการรับรอง โดยระบบงานมีการบูรณาการ การสร้างนวัตกรรม และ/หรืองานวิจัยจากงานประจำหรือการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญ

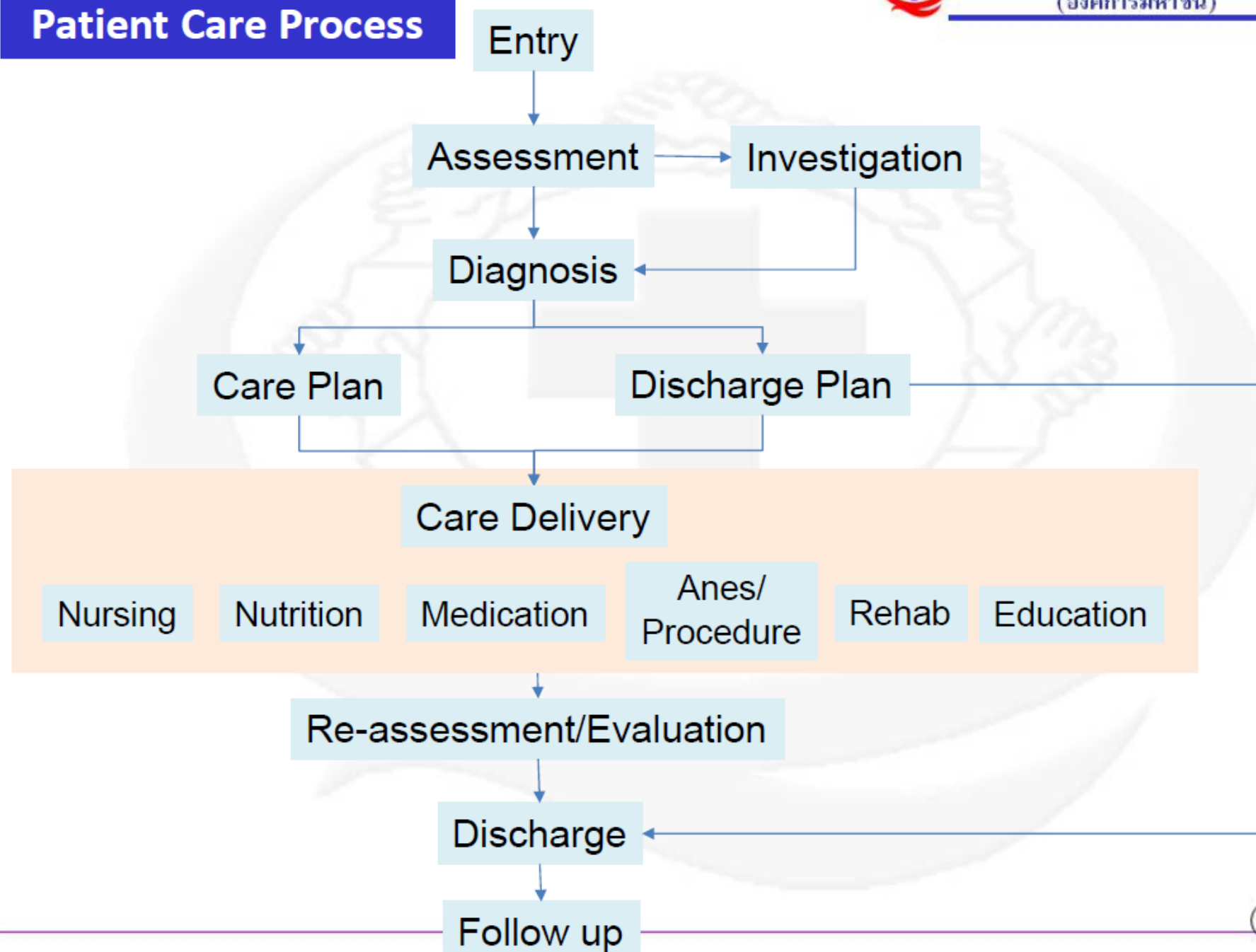
4. Quality Concepts แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาที่ขจัดความสูญเปล่า ป้องกันความเสี่ยงใช้ หลักฐานทางวิชาการรวมถึง การสร้างเสริมสุขภาพและมิติด้านจิตวิญญาณ (Waste, Safety, Standard, Spiritual, Health Promotion)



Patient Care Process



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)



ทำไมต้อง Clinical Tracer

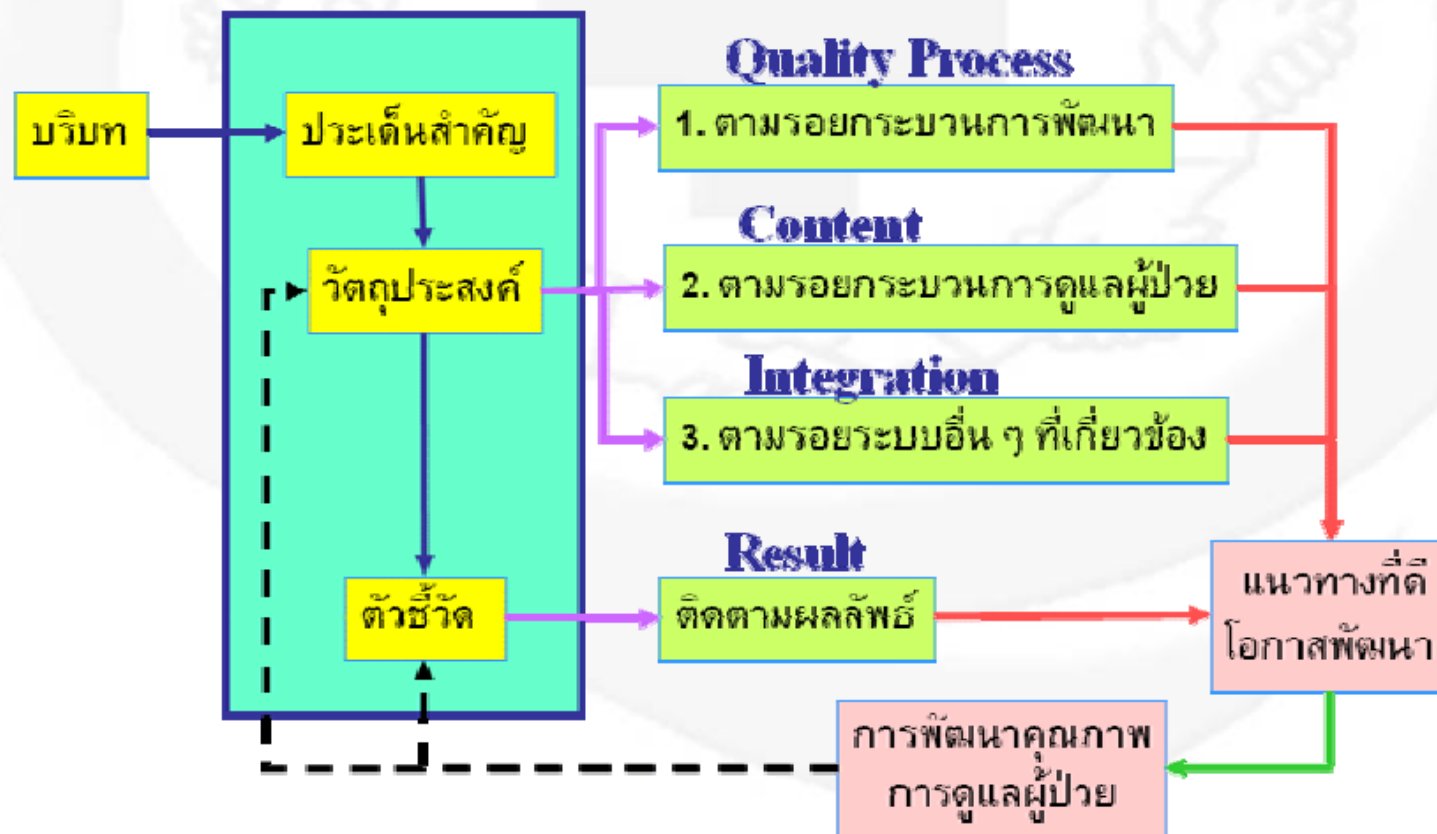


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)



เพื่อทบทวนการดูแลผู้ป่วยแต่ละโรคในภาพรวม ในทุก
องค์ประกอบ ทบทวนทั้งข้อมูลสถิติ และการปฏิบัติจริงใน
พื้นที่

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น





Clinical tracer

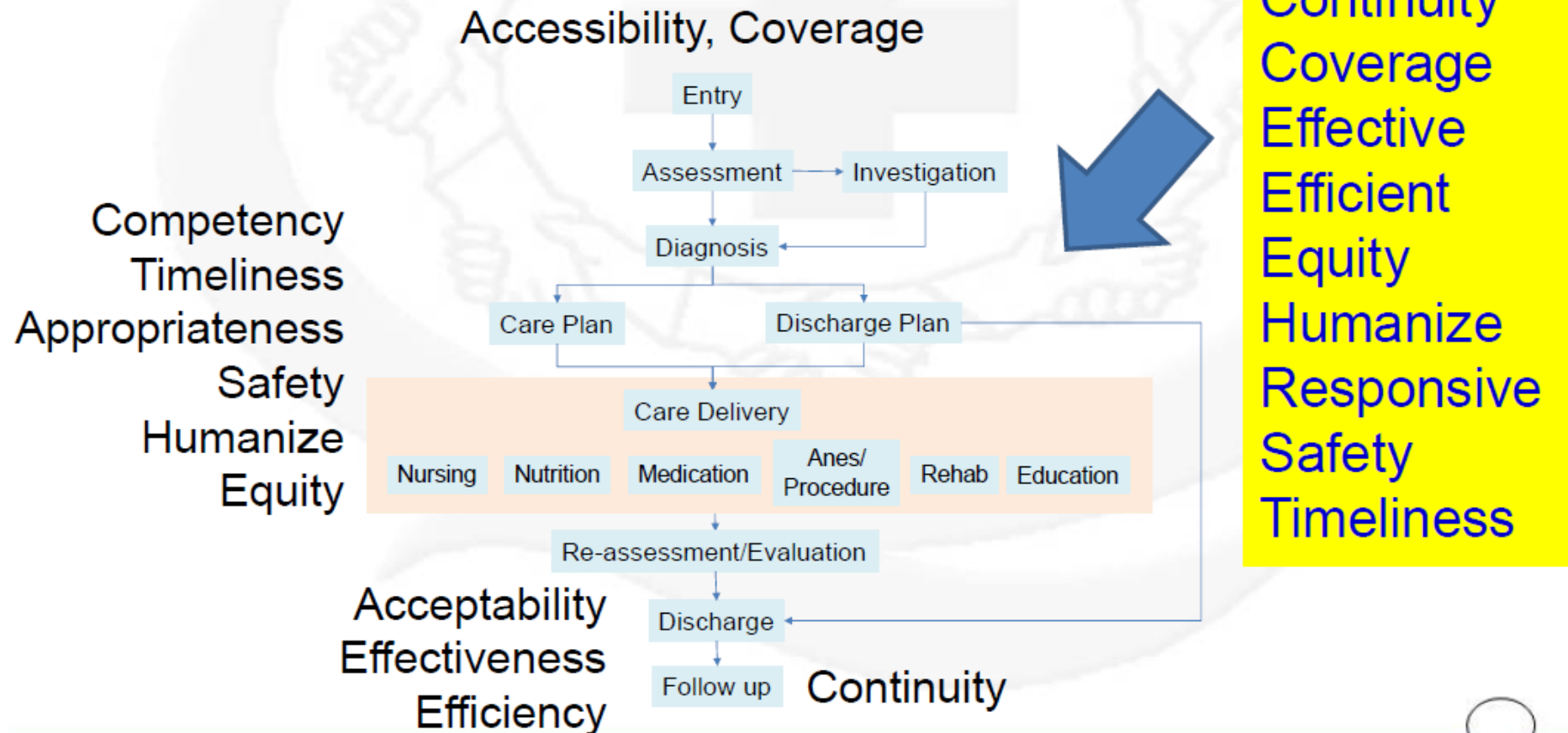
การตามรอยทางคลินิก เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมีการตามรอยหรือทบทวนในสี่ประเด็น

- (1) กระบวนการดูแลผู้ป่วย
- (2) ผลงานที่เกิดขึ้น
- (3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
- (4) การเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้อง การตามรอยนี้จะทำให้เห็นวิธีการปฏิบัติที่ดี
หรือโอกาสพัฒนา เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมดูแลผู้ป่วย

Opportunity for Quality Improvement



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

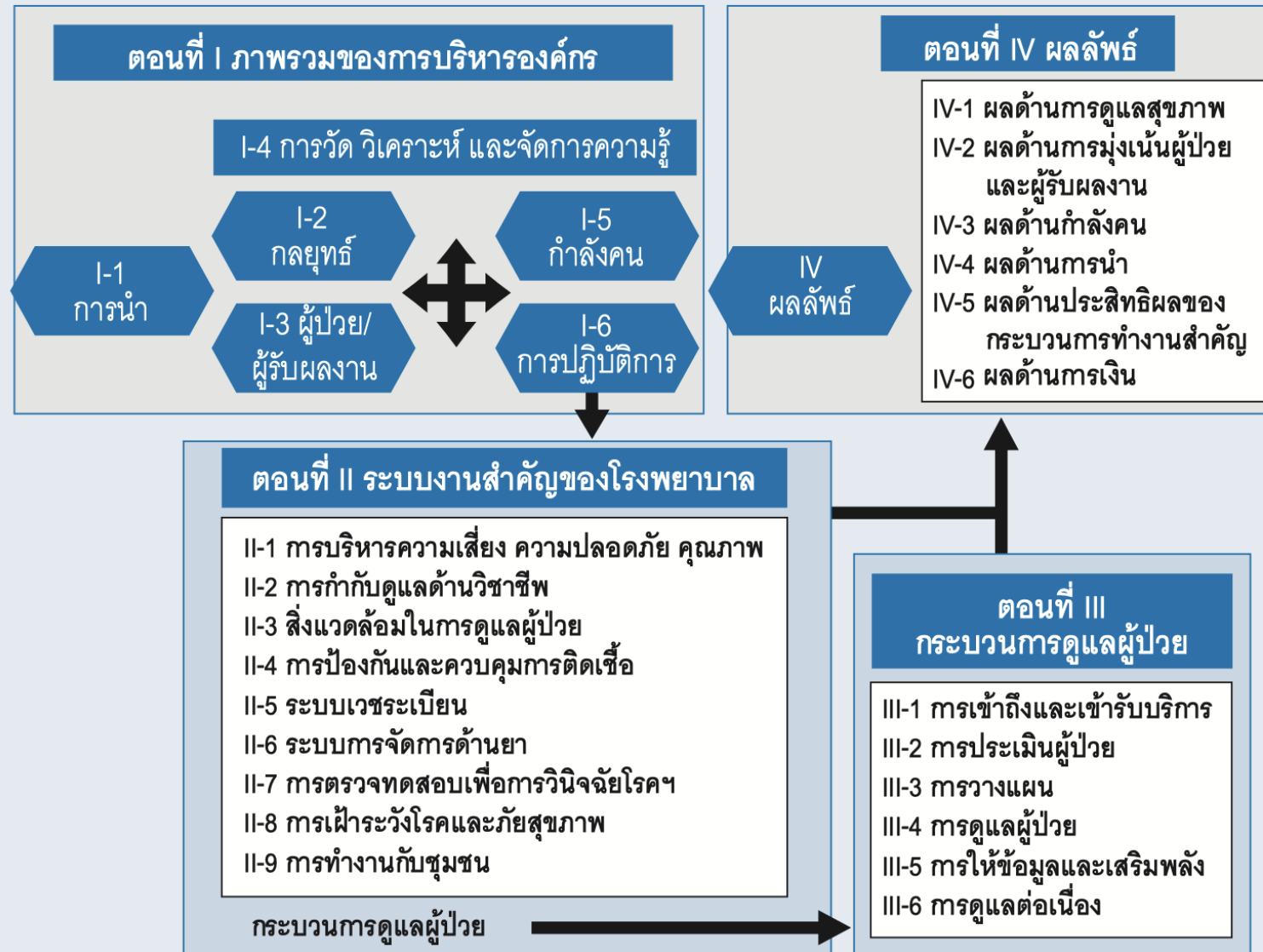


การแสดงให้เห็นผลลัพธ์ทางด้านคลินิกที่ดีขึ้น



- เลือกโรคสำคัญมาได้ครอบคลุม
- วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและมีคุณภาพที่สำคัญของโรคได้อย่างเหมาะสม
- มีการจัดการกับความเสี่ยงและประเด็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม มีการรับรู้และเข้าใจในทีมงานอย่างทั่วถึง
- มีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคนั้น ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้จากการทบทวนเวชระเบียน
- มีการวัดผลที่เหมาะสมทั้งด้าน process & outcome
- ผู้รับบริการและผู้เยี่ยมสำรวจสามารถสัมผัสถึงคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้จริง

ขอบเขตมาตรฐานเฉพาะโรค



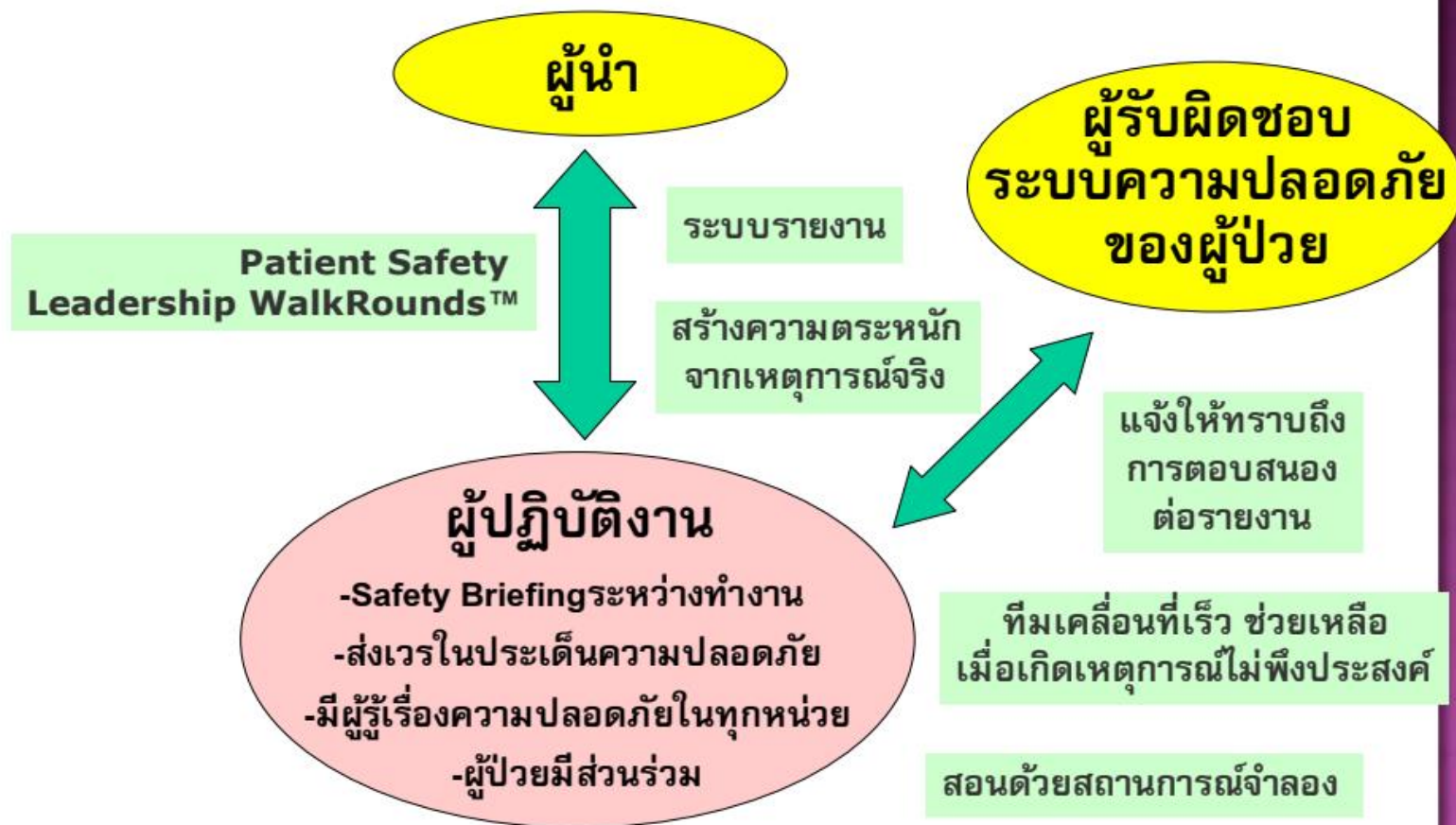


Part I

การบริหารจัดการทั่วไป

ภาพรวมของการบริหารองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

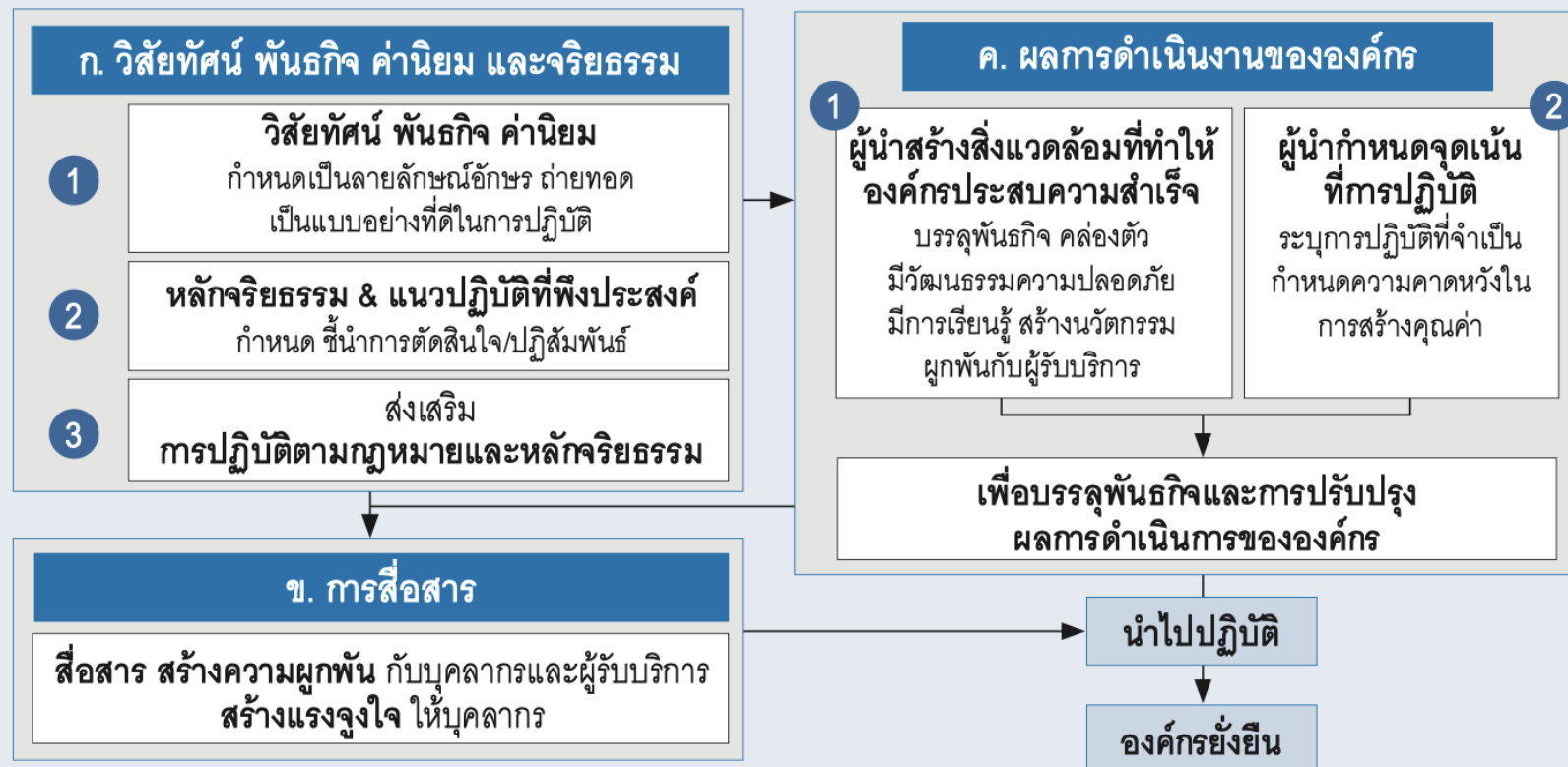


การบริหารจัดการทั่วไป

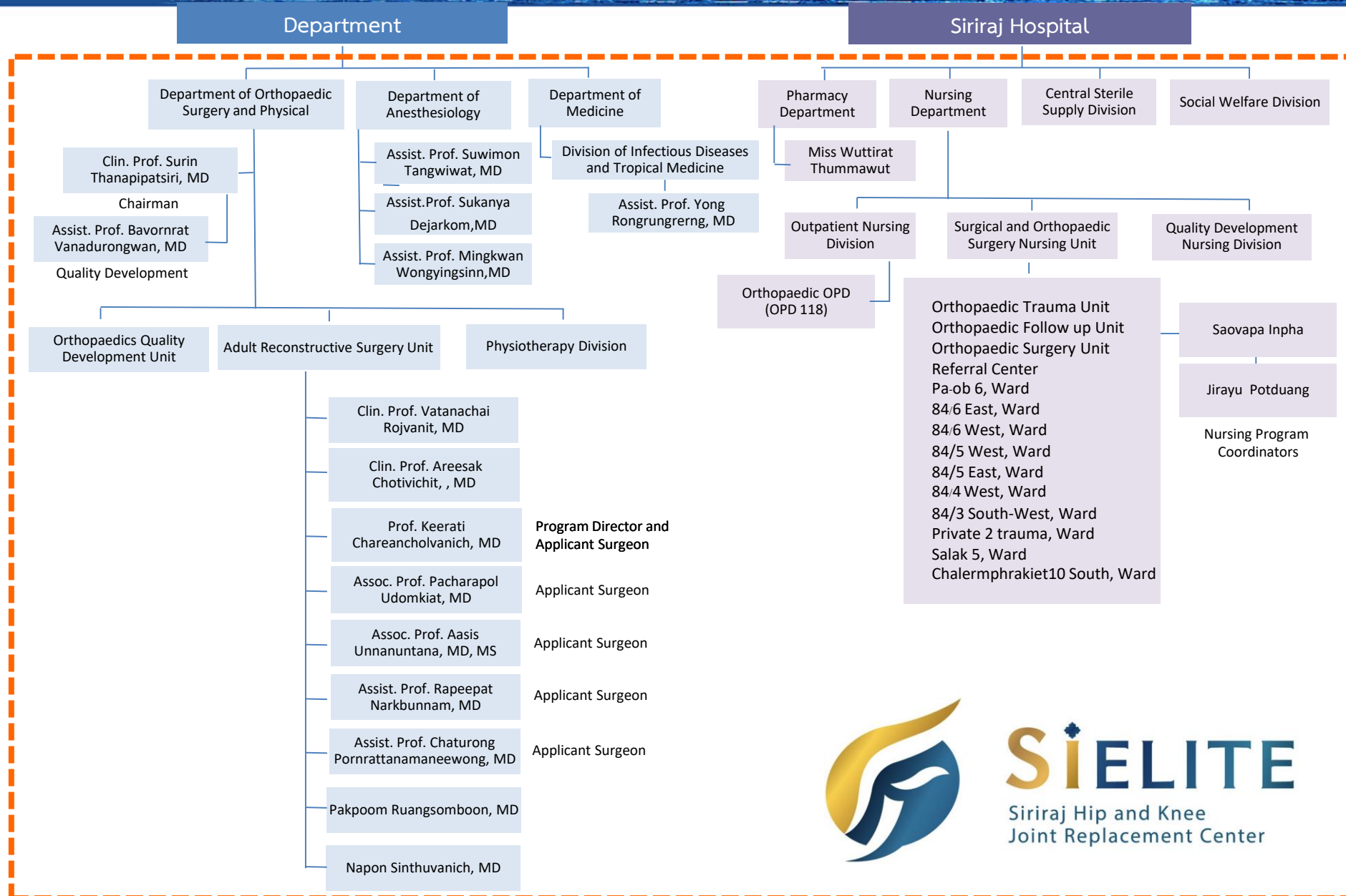
I-1 มรณำ (LED)

I-1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง (Senior Leadership)

การกระทำของผู้นำระดับสูง ชี้นำและทำให้องค์กรยั่งยืน ผ่านวิสัยทัศน์และค่านิยม การสื่อสารที่ได้ผลกับบุคลากร การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความสำเร็จและการกำหนดจุดเน้นที่การปฏิบัติ.



Faculty of Medicine Siriraj Hospital



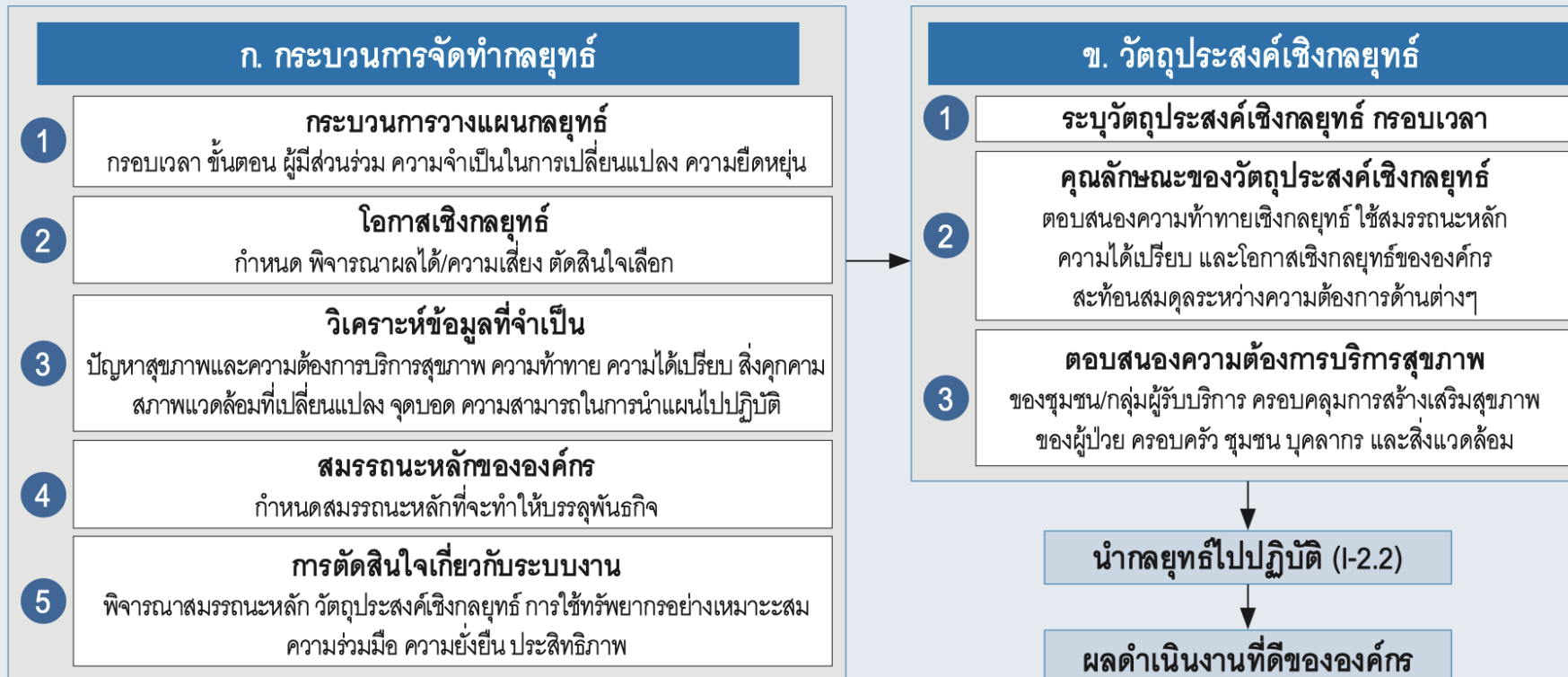
SiELITE
Siriraj Hip and Knee
Joint Replacement Center

การบริหารจัดการทั่วไป

I-2 กลยุทธ์ (STG)

I-2.1 การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development)

องค์กรวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพ ตอบสนองความท้าทาย และสร้างความเข้มแข็งให้กับ การดำเนินงานขององค์กร.





SIELITE

Siriraj Hip and Knee
Joint replacement Excellent Center

Advanced technology

Revision and complex surgery

One day surgery

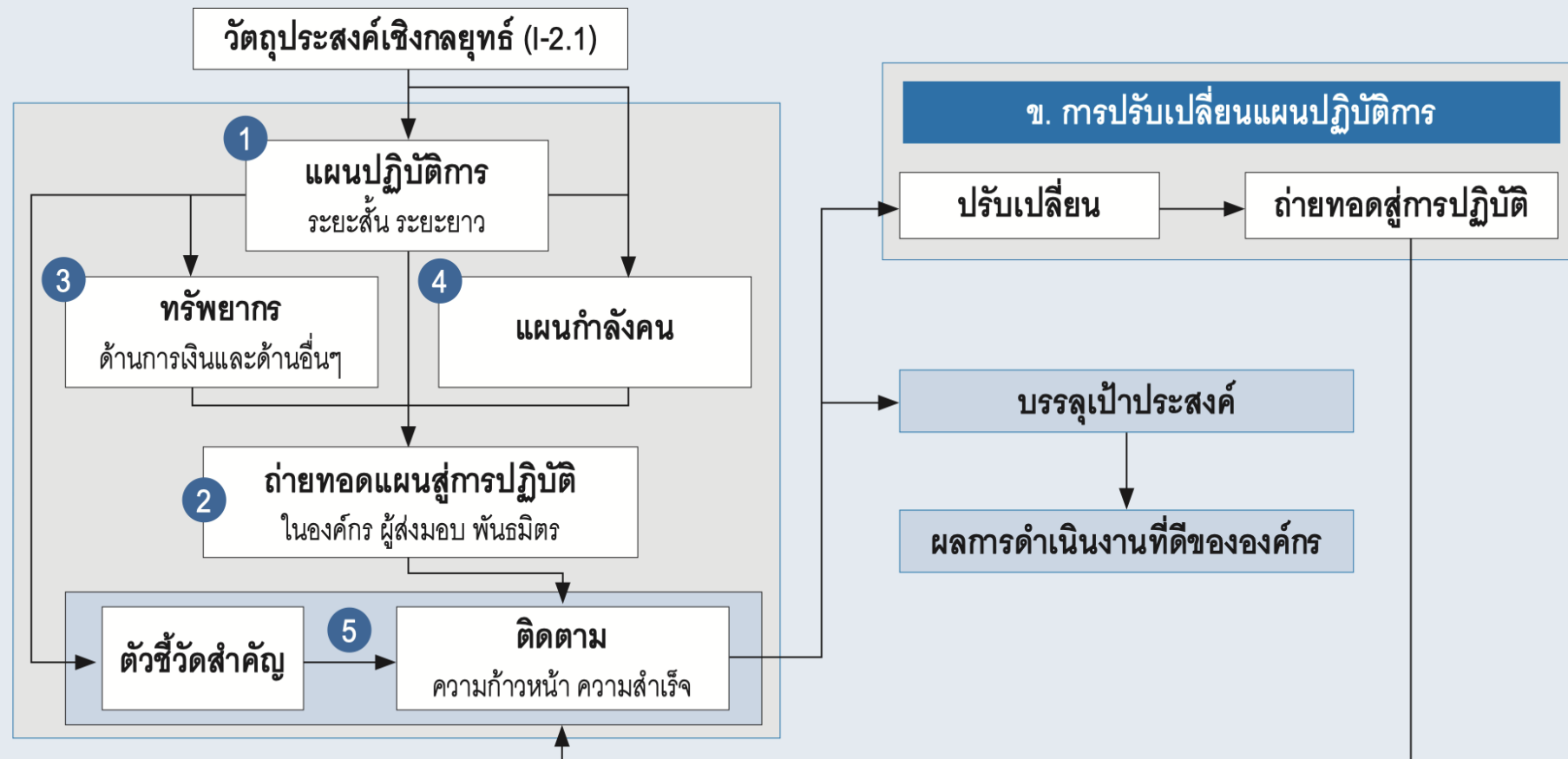
Education and training center

การบริหารจัดการทั่วไป

I-2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)

องค์กรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุเป้าประสงค์.

ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

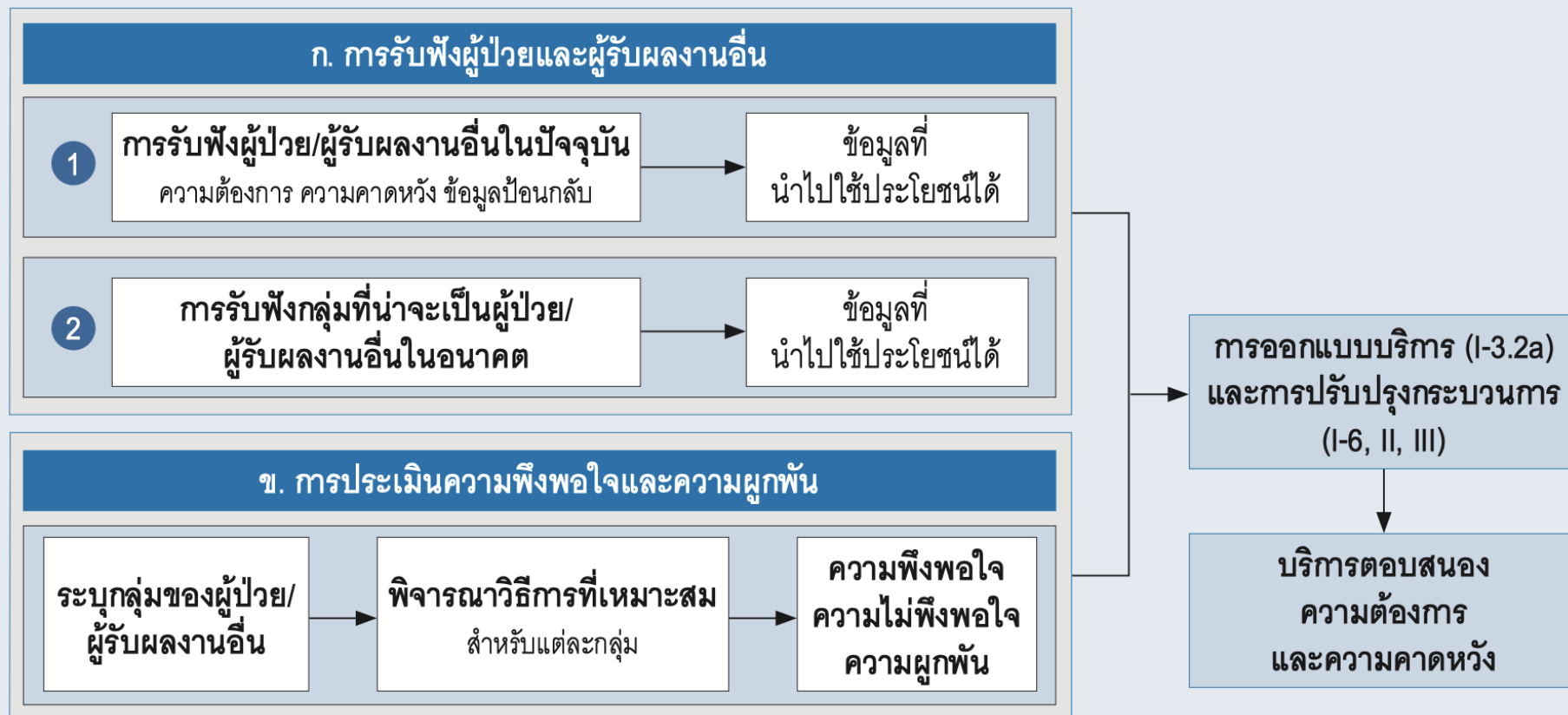


การบริหารจัดการทั่วไป

I-3 ผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (PCM)

I-3.1 เสียงของผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (Voice of Patient / Customer)

องค์กรรับฟังและเรียนรู้จากผู้ป่วย / ผู้รับผลงานอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการ / ความคาดหวัง.





โครงการความร่วมมือระหว่างสองโรงพยาบาล เพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยแขนกลหุ่นยนต์ 2 โรงพยาบาล ผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์





Collaboration center



SIELITE
Siriraj Hip and Knee
Joint Replacement Center



การบริหารจัดการทั่วไป

I-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลงานขององค์กร (Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance)

องค์กรเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม ใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลงานขององค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้.





ทีมของเรา

ประกอบด้วยศัลยแพทย์ วิชาญญแพทย์
เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด
และทีมสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งมากไปด้วยประสบการณ์
รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการรักษา
ตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในความดูแลของพวกเรา
ท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด



SIELITE
Siriraj Hip and Knee
Joint replacement Excellent Center



5 dimensions

Safety

Quality

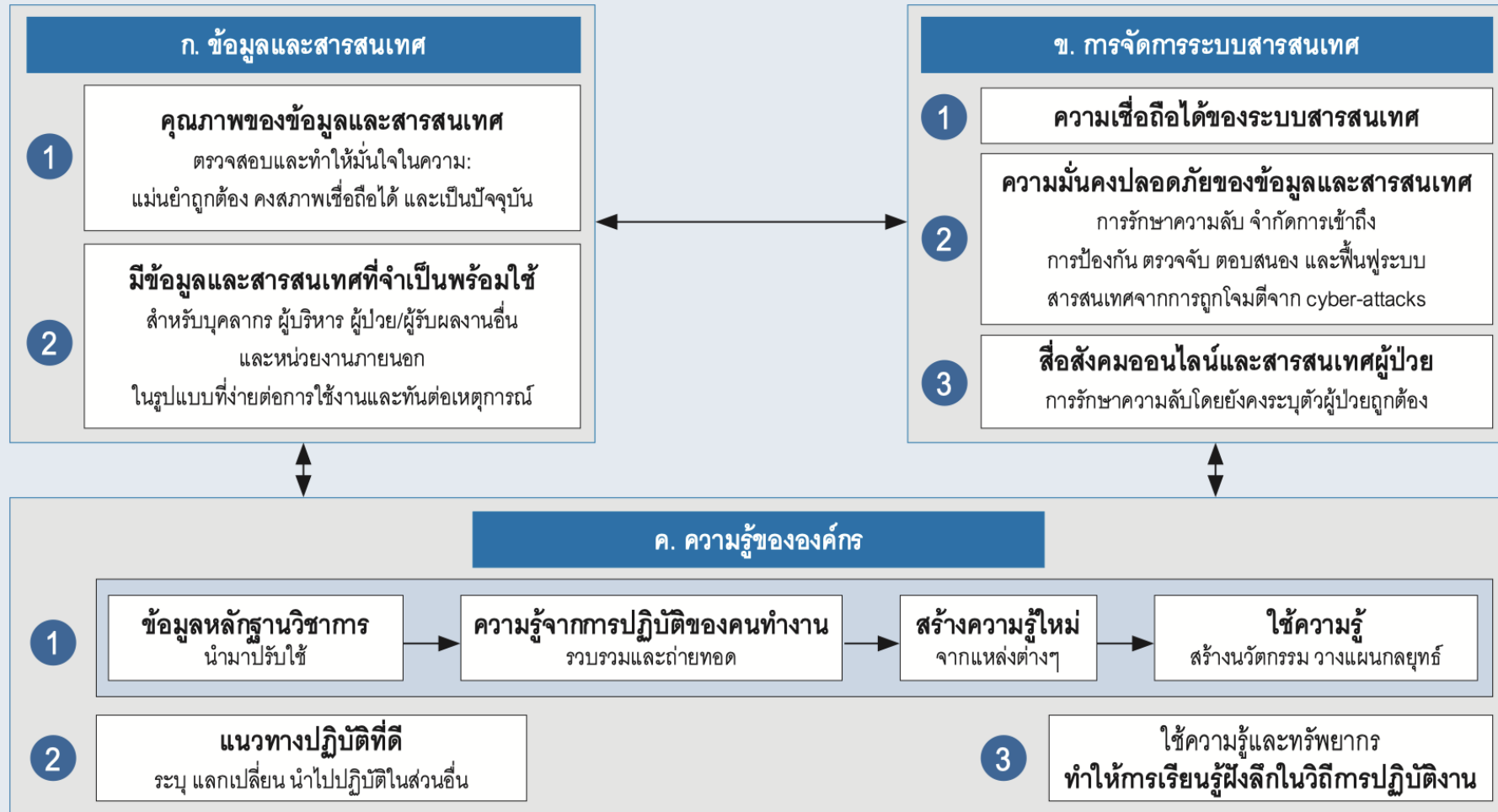
Time

Satisfaction

Cost

I-4.2 การจัดการความรู้และสารสนเทศ (Information and Knowledge Management)

องค์กรมีข้อมูล สารสนเทศ สินทรัพย์ความรู้ ที่จำเป็น ที่มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน และมีการจัดการความรู้ที่ดี มีการปลูกฝังการเรียนรู้เข้าไปในงานประจำ.

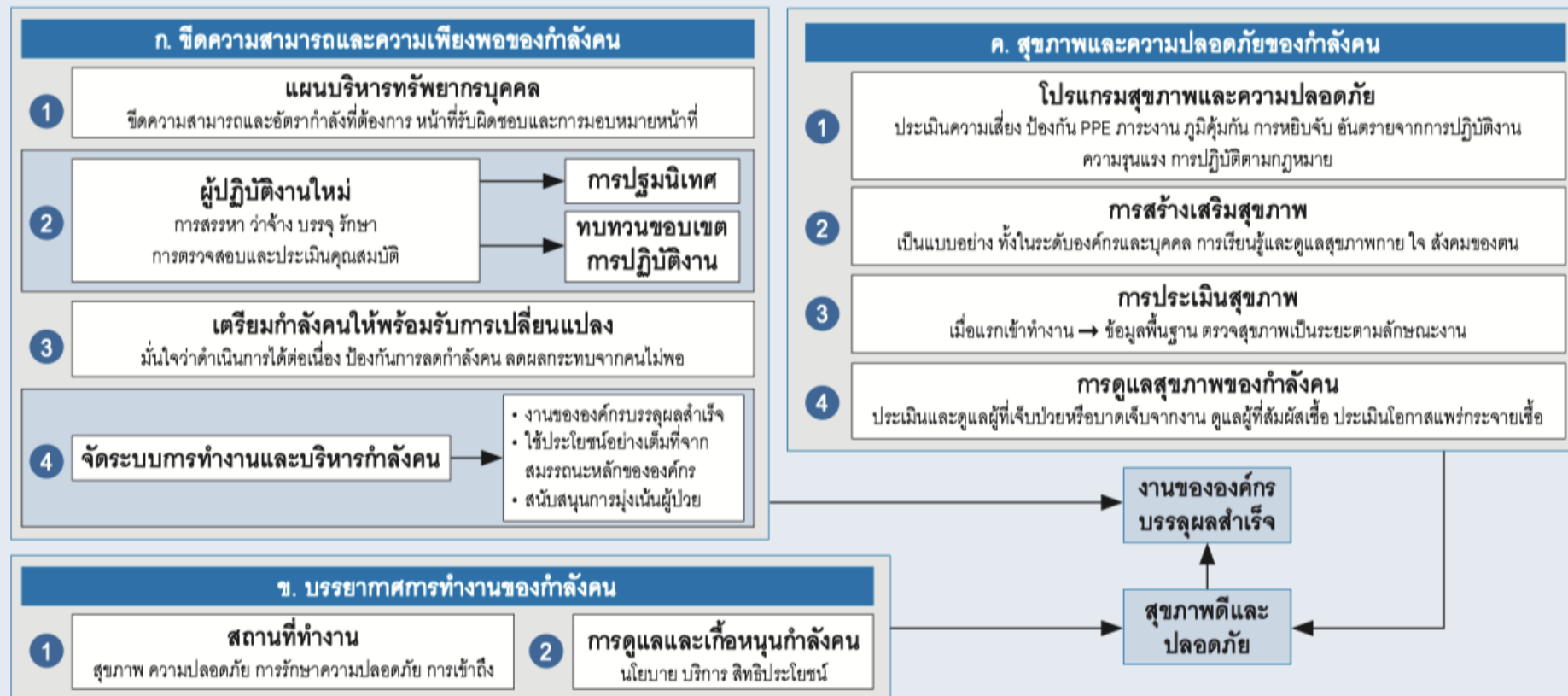


การบริหารจัดการทั่วไป

I-5 กำลังคน (WKF)

I-5.1 สภาพแวดล้อมของกำลังคน (Workforce Environment)

องค์กรบริหารขีดความสามารถและอัตรากำลัง เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ องค์กรจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบรรยากาศที่เอื้อให้กำลังคนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย.





Success mobile application: Faster, Cheaper, Better

Patients

Doctor

Nurses

OPD

IPD

OR

coordinator

Physical therapist

Admission center

Researcher

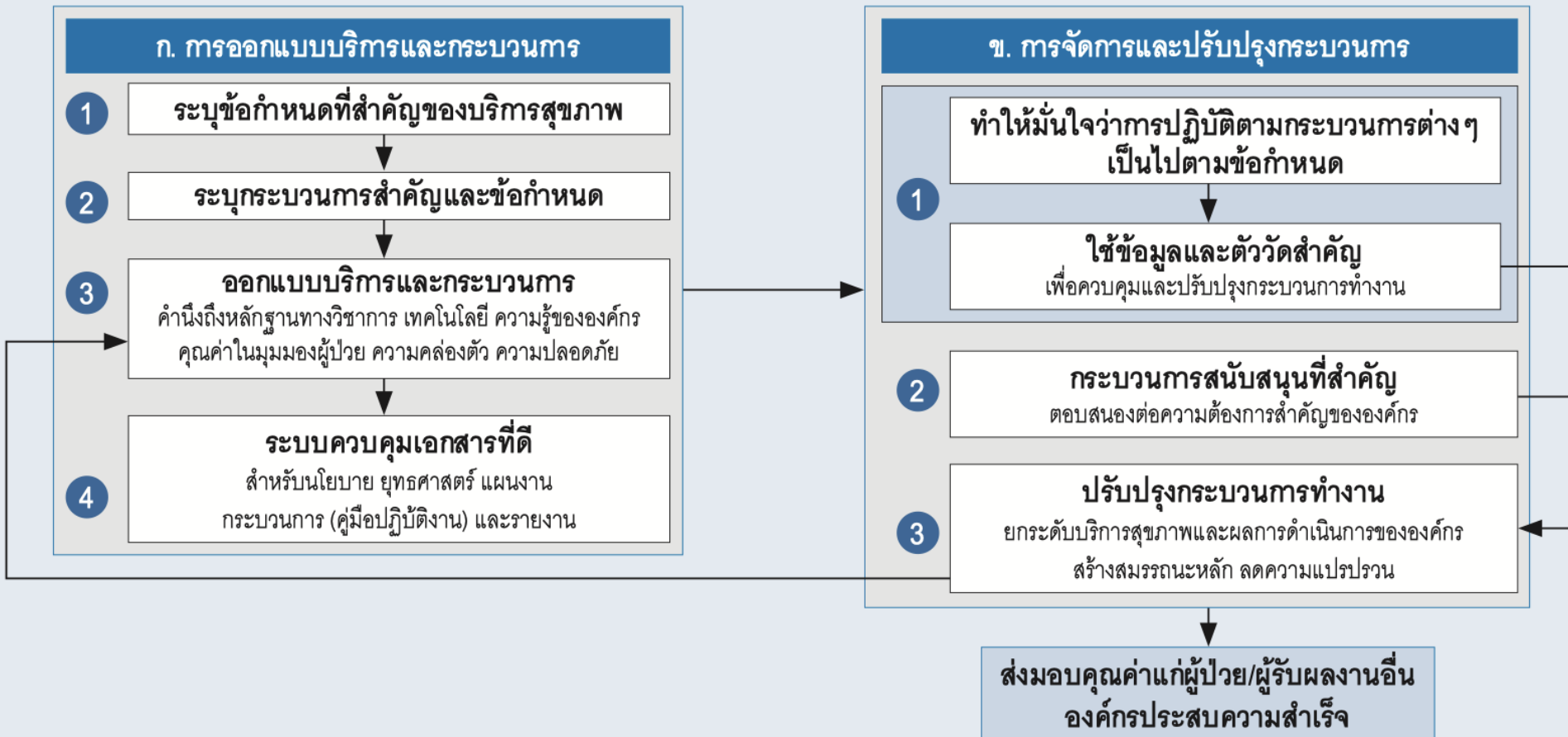
ทีมพัฒนาคุณภาพ



การบริหารจัดการทั่วไป

I-6.1 กระบวนการทำงาน (Work Processes)

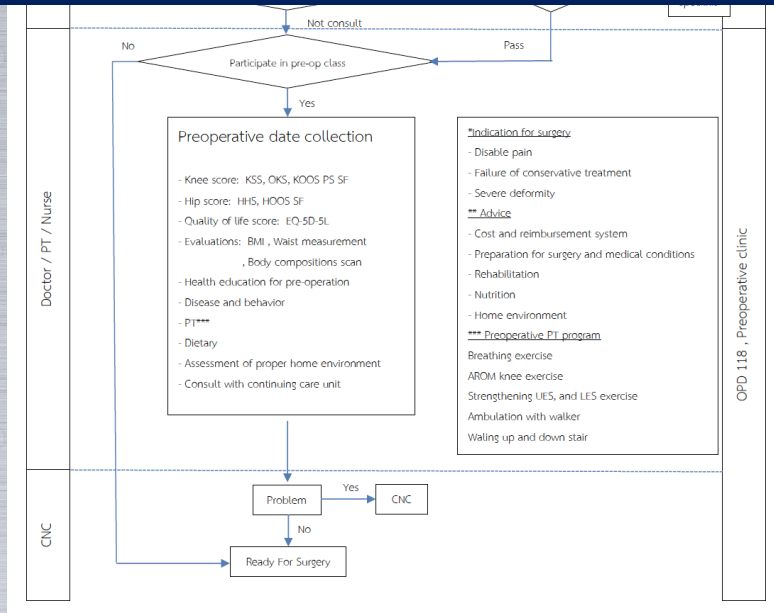
องค์กรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ / กระบวนการการทำงานที่สำคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย / ผู้รับผลงานอื่น และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ.





Siriraj Hip and Knee
Joint replacement Excellent Center

Tools for standardize important steps

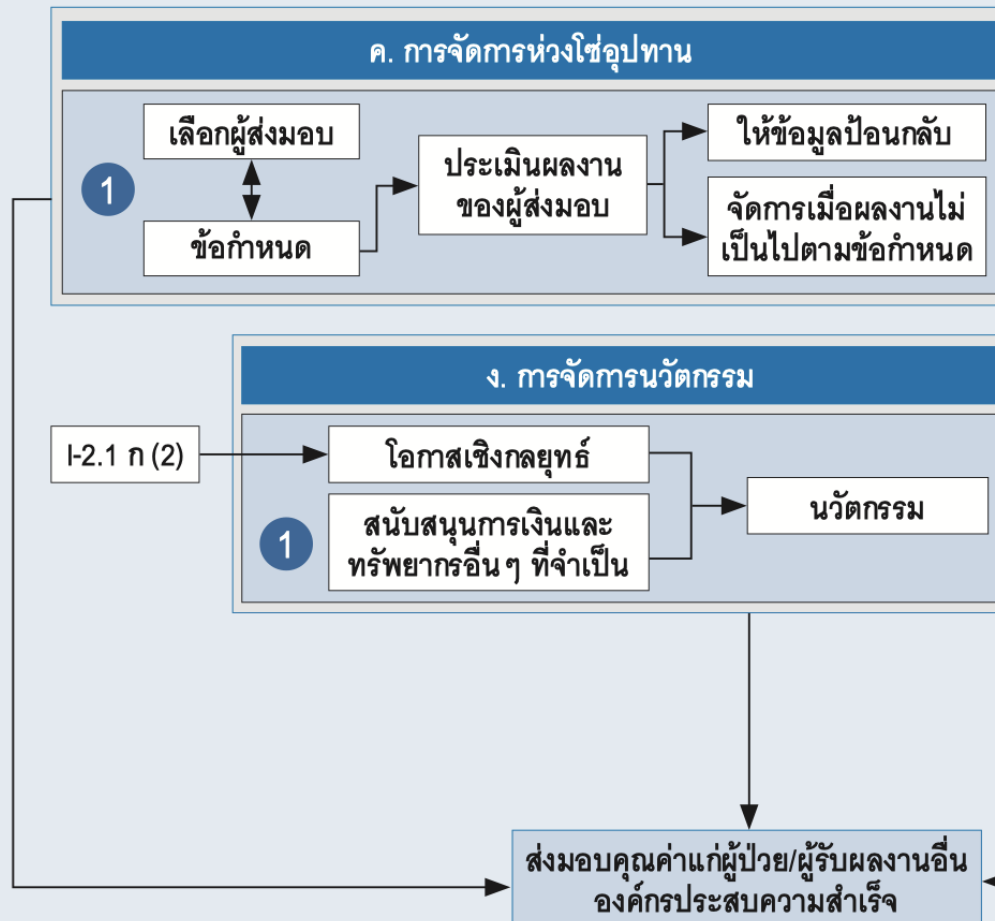


Doctor's Order Preoperative Order for Knee/Hip Replacement		 H.N.....A.N..... Name.....Age..... Physician.....Ward..... Print/Name label							
Diagnosis.....		Date..... Time.....							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Date/time</th> <th style="width: 85%;">One day order</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <u>Preoperative Order for Knee/Hip Arthroplasty</u> Procedure (Date..... Time.....) ☐ Right ☐ TKA ☐ UKA ☐ Revision TKA ☐ THA ☐ Hemiarthroplasty ☐ Revision THA ☐ Left ☐ TKA ☐ UKA ☐ Revision TKA ☐ THA ☐ Hemiarthroplasty ☐ Revision THA ☐ Promote oral fluidml at 1 day before surgery ☐ NPO date.....time..... - Antibiotics </td> </tr> </tbody> </table>	Date/time	One day order		<u>Preoperative Order for Knee/Hip Arthroplasty</u> Procedure (Date..... Time.....) ☐ Right ☐ TKA ☐ UKA ☐ Revision TKA ☐ THA ☐ Hemiarthroplasty ☐ Revision THA ☐ Left ☐ TKA ☐ UKA ☐ Revision TKA ☐ THA ☐ Hemiarthroplasty ☐ Revision THA ☐ Promote oral fluidml at 1 day before surgery ☐ NPO date.....time..... - Antibiotics	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Date/time</th> <th style="width: 85%;">Continuous order</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> * Cefazolin; recommended dose: 2 gm for BW ≤ 120 kg, 3 gm for BW > 120 kg </td> </tr> </tbody> </table>	Date/time	Continuous order		* Cefazolin; recommended dose: 2 gm for BW ≤ 120 kg, 3 gm for BW > 120 kg
Date/time	One day order								
	<u>Preoperative Order for Knee/Hip Arthroplasty</u> Procedure (Date..... Time.....) ☐ Right ☐ TKA ☐ UKA ☐ Revision TKA ☐ THA ☐ Hemiarthroplasty ☐ Revision THA ☐ Left ☐ TKA ☐ UKA ☐ Revision TKA ☐ THA ☐ Hemiarthroplasty ☐ Revision THA ☐ Promote oral fluidml at 1 day before surgery ☐ NPO date.....time..... - Antibiotics								
Date/time	Continuous order								
	* Cefazolin; recommended dose: 2 gm for BW ≤ 120 kg, 3 gm for BW > 120 kg								
Standing order									
end of infusion < 60 min before incision ☐ Vancomycin.....gm in NSS.....ml IV drip in 120 min, end of infusion < 60 min before incision ☐ Other..... - Preemptive medications ☐ Gabapentin.....mg or ☐ Pregabalin.....mg oral at time.....date..... ☐ Celecoxib.....mg oral or ☐ Etoricoxib.....mg oral at time.....date..... ☐ Other..... - Medications (bringing to OR) ☐ Tranexamic acid.....ampule (250mg/amp) ☐ 0.5% Levobupivacaine (50mg/10ml) 2 ampules for unilateral Sx, 4 ampules for bilateral Sx ☐ Ketorolac.....amp (30mg/amp) ☐ Other..... - Blood preservation**** ☐ Cross-matched PRC.....unit ☐ Type & screen ☐ Other..... - VTE prophylaxis ☐ Prepare IPCD for mechanical prophylaxis stocking size ☐ S ☐ M ☐ L ☐ Pharmacological prophylaxis; specify.....at date.....time.....	patient. Recommended dose: 30mg/kg 1 gm in BW 36-45 kg; 1 gm in NSS 100 ml BW 46-55 kg: 1.25 gm in NSS 100 ml BW 56-65 kg: 1.5 gm in NSS 250 ml BW 66-75 kg: 1.75 gm in NSS 250 ml BW > 76 kg: 2 gm in NSS 250 ml **** Recommended type of blood preservation: Unilateral TKA: type & screen Bilateral TKA: PRC 1 unit Unilateral THA: PRC 1 unit Bilateral THA: PRC 2 units Revision TKA: PRC 1 unit Revision THA: PRC 2-4 units and FFP ☐ Intra-operative peri-articular injection per operated side ☐ 0.5% Levobupivacaine (100mg/20ml).....ml ☐ Ketorolac.....mg ☐ Epinephrine 1/1000ml ☐ NSSml ☐ Other..... ☐ Intra-operative intra-articular injection with tranexamic acid.....mg per operated side								
Physician's signature..... Medical license number..... Date..... Nurse's signature..... Time.....									

การบริหารจัดการทั่วไป

I-6.1 กระบวนการทำงาน (Work Processes)

องค์กรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ / กระบวนการการทำงานที่สำคัญ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย / ผู้รับผลงานอื่น และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ.



I-6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)

องค์กรทำให้มั่นใจว่ามีการจัดการการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย / ผู้รับผลงานอื่น และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ.

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

1

ควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ
ป้องกันอุบัติการณ์ ความผิดพลาด การต้องทำงานซ้ำ
ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและทดสอบ
ปรับปรุงรอบเวลา ผลผลิตภาพ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอื่นๆ

ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

1

สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการที่ปลอดภัย
การป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ต้นเหตุ
การทำให้ฟื้นคืนสภาพ

1

การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ระบบงานและสถานที่ทำงาน;
การป้องกัน การบริหารจัดการ ความต่อเนื่องของการให้บริการ
การเคลื่อนย้าย การทำให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิม;
ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้ต่อเนื่อง

การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ

ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น
องค์กรประสบความสำเร็จ



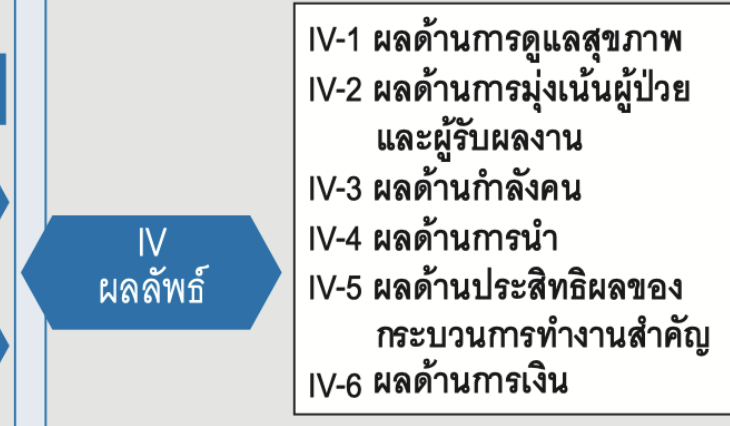
Part II

ระบบงานสำคัญ

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร



ตอนที่ IV ผลลัพธ์



ตอนที่ II ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล

- II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
- II-2 การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ
- II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
- II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- II-5 ระบบเวชระเบียน
- II-6 ระบบการจัดการด้านยา
- II-7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคฯ
- II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
- II-9 การทำงานกับชุมชน

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

- III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
- III-2 การประเมินผู้ป่วย
- III-3 การวางแผน
- III-4 การดูแลผู้ป่วย
- III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
- III-6 การดูแลต่อเนื่อง

ระบบงานสำคัญ

ตอนที่ II ระบบงานสำคัญ ให้ความสำคัญกับระบบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับระบบขององค์กร 5 ระบบ

II-1 การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง RM

II-2 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย ENV

II-3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ IC

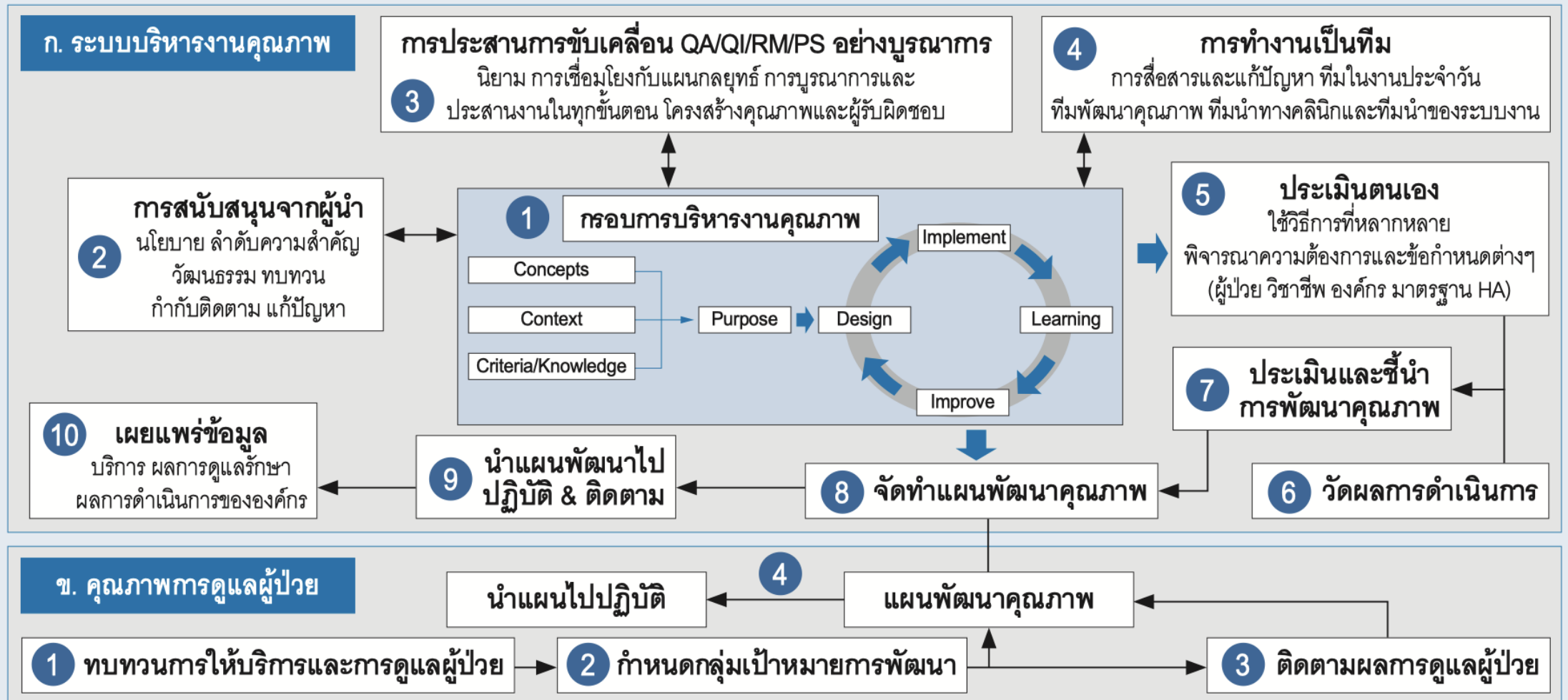
II-4 ระบบเวชระเบียน MED

II-5 ระบบการจัดการด้านยาเชิงระบบ PTC

ระบบงานสำคัญ

II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)

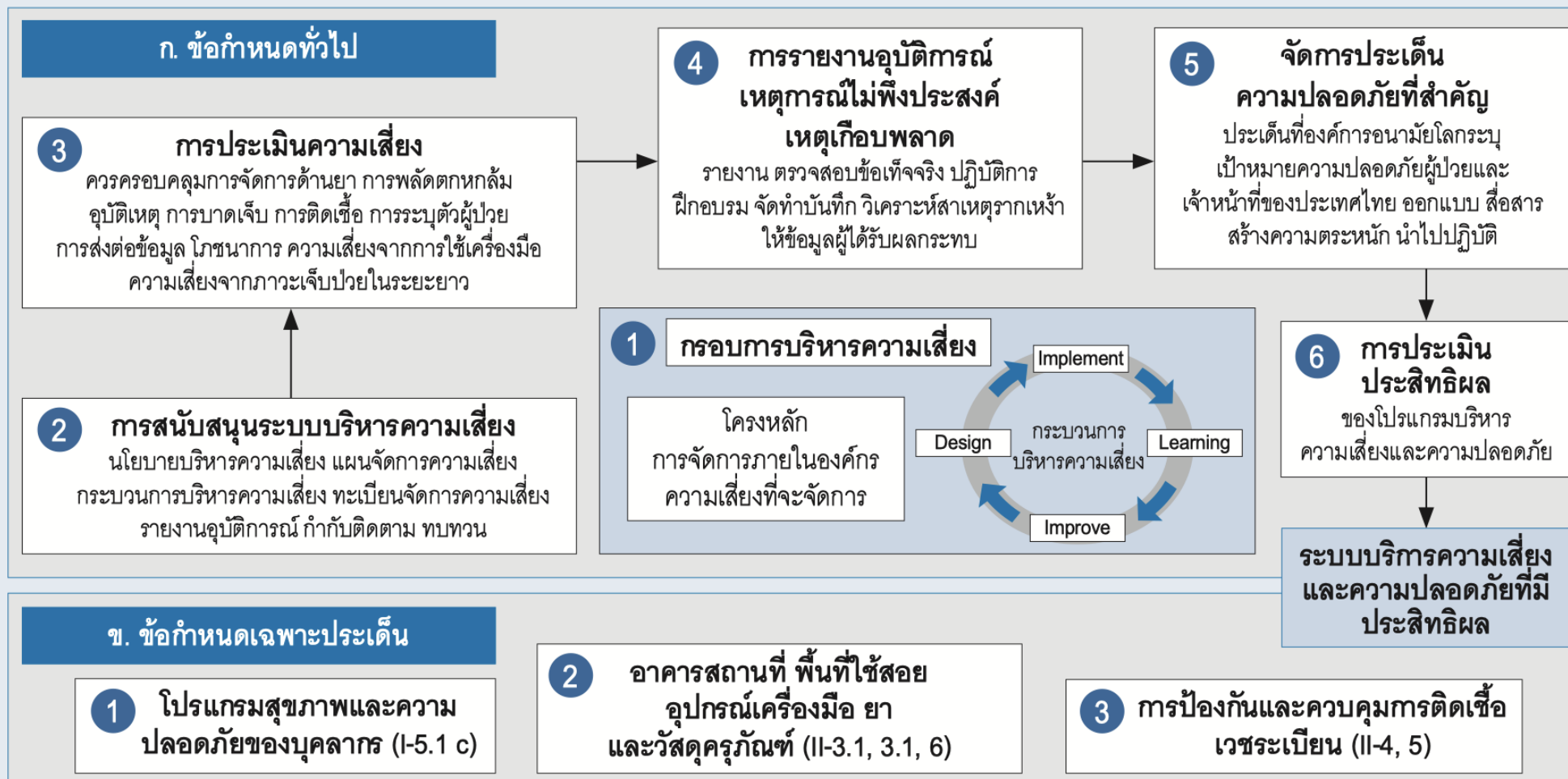
มีการบริหารงานคุณภาพ ที่ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ.



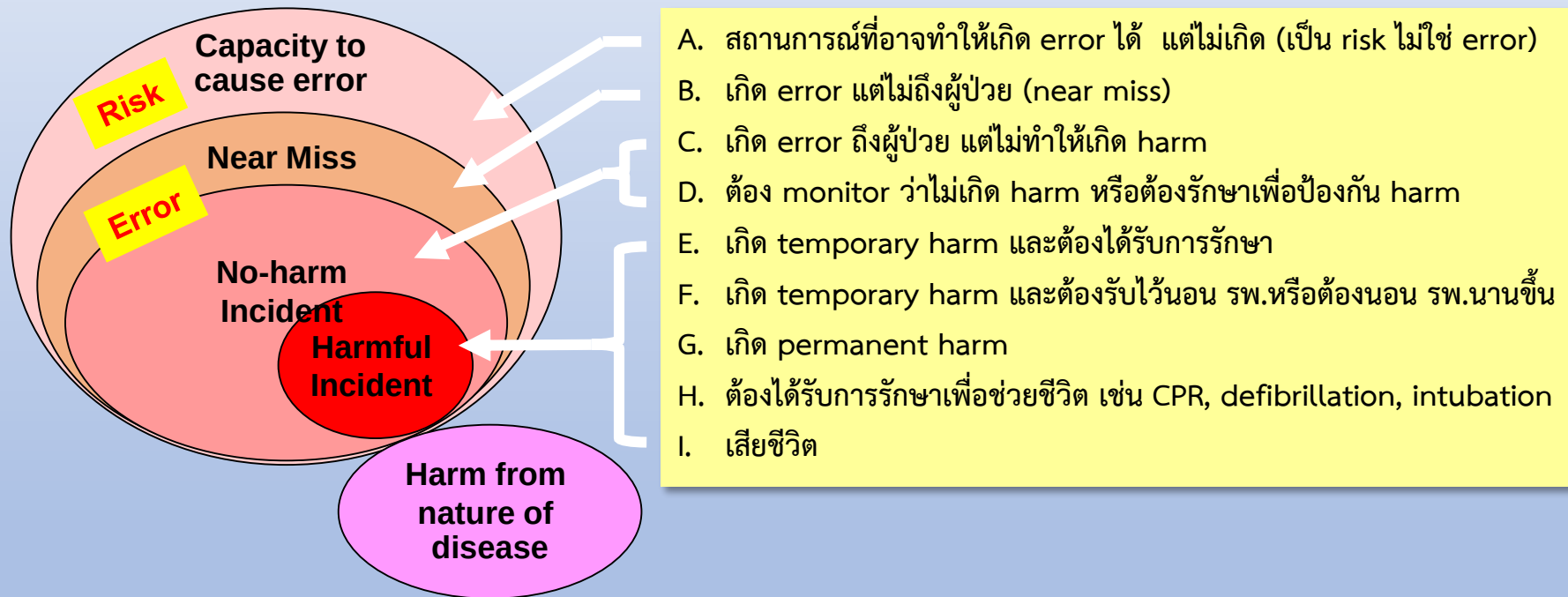
ระบบงานสำคัญ

II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน เพื่อจัดการความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาเยือน.



ทำความเข้าใจให้ตรงกัน





Clinical Lead team monthly meeting

Risk management: Infection, DVT control



- Lean
 - Direction
 - Quality
- improvement





Quality improvement & Morbidity and Mortality

To improve our patient's safety

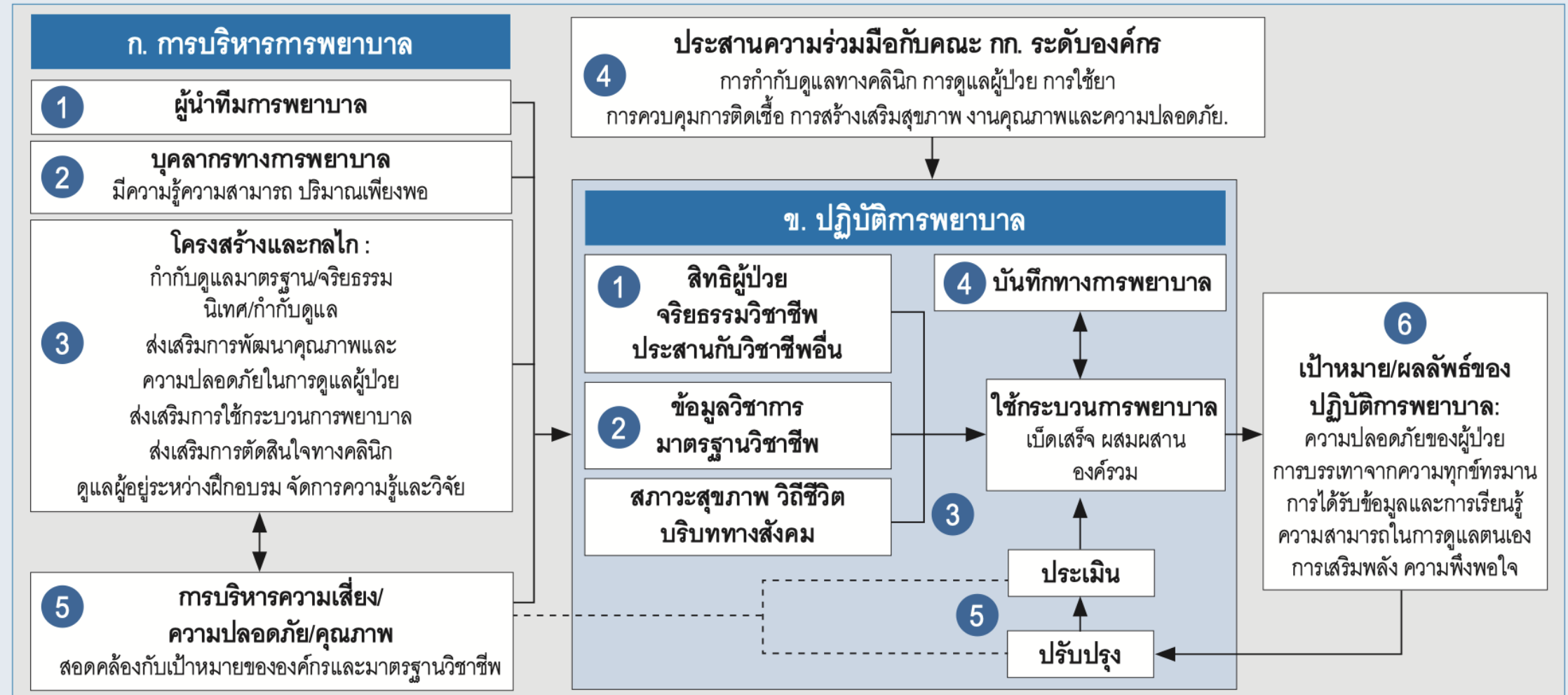
Case conference	Re-admit: Bipolar dislocation	Re-admit: PJI Lt. hip	Postpone Operation: Subacute DVT Rt. CVF
Root Cause Analysis สรุปประเด็นและโอกาสพัฒนา	- ให้ Education แก่ care giver - จัดทำนวัตกรรม Hip brace (ให้เป็น R2R โดย CNC)	- ให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลจนกระทั่งแผลผ่าตัดหายดี - เคสนี้มี Mental Retard และ Delirium ร่วมด้วย การเย็บแผลผ่าตัดไม่ควรใช้การสอย ให้เย็บแบบ continuous suture	- ไม่ได้ทำตาม Flow pre operative screening ระบบไหลเวียนเลือด - ควรส่งปรึกษา vascular เพื่อตรวจ Caprini score ในเคส high risk



ระบบงานสำคัญ

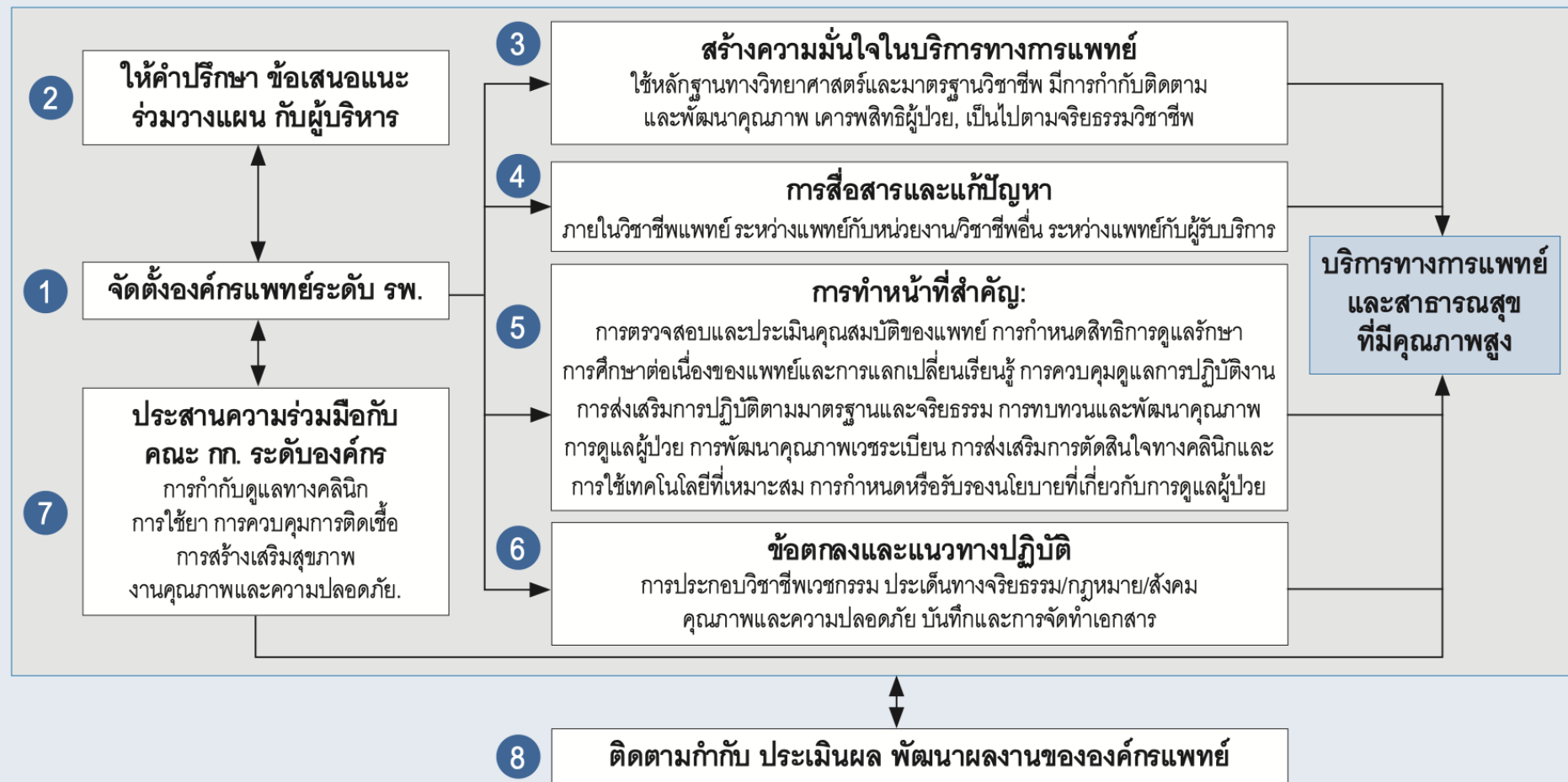
II-2.1 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล (Nursing Governance)

มีระบบบริหารการพยาบาลที่รับผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร.



II-2.2 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ (Medical Staff Governance)

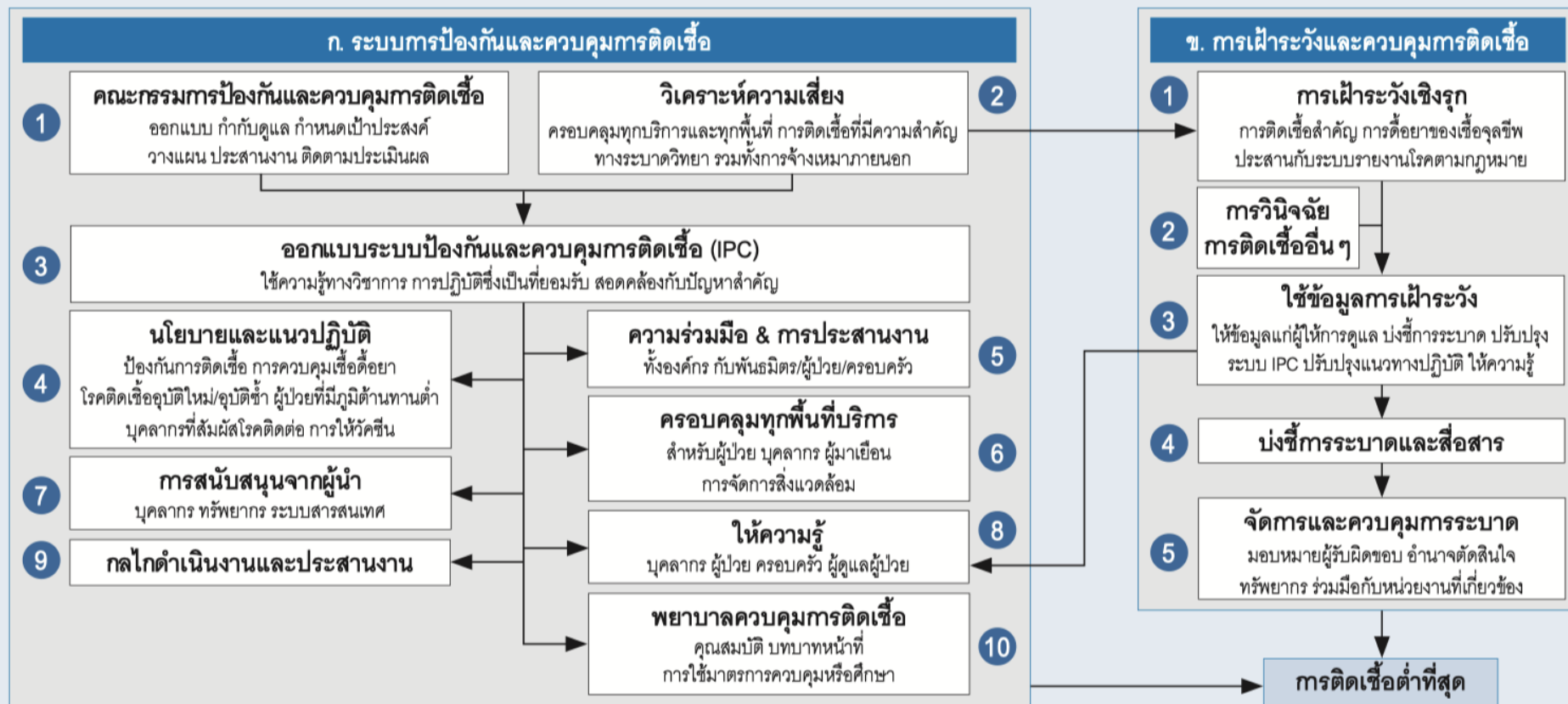
มีการจัดตั้งองค์กรแพทย์ ทำหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร.



II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)

II-4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control Program)

องค์กรจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รวมถึงระบบเฝ้าระวังและติดตาม ที่เหมาะสมกับบริบท ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี.



Antibiotic Prophylactic



- Drug administration in 5R
- Effective in plasma concentration
- Beware Adverse Drug Reaction

Table 1. Antimicrobials for Prophylaxis in Hip and Knee Arthroplasty

Antimicrobial	Dosage	Infusion Time (min)	Half-Life (h)	Redosing Interval (h)	Adverse Events
Cefazolin ^a	<80 kg: 1 g ≥80 kg: 2 g	15-60	1.8	2-5	Anaphylaxis, rash, diarrhea, eosinophilia
Cefuroxime ^a	1.5 g	15-60	1-2	3-4	Anaphylaxis, rash, diarrhea, eosinophilia
Clindamycin ^b	600-900 mg	10-60 (do not exceed 30 mg/min)	2-5.1	3-6	Pseudomembranous colitis, diarrhea
Vancomycin ^{b,c}	1 g (10-15 mg/kg)	60-120 min (≤1 g/60 min)	4-6	6-12	Infusion reactions, red man syndrome, nephrotoxicity (<1%)

^a Preferred agent.

^b Alternative agent for severe beta-lactam allergy.

^c Alternative for patient with known MRSA colonization or for institution with high (>20%) MRSA rate.

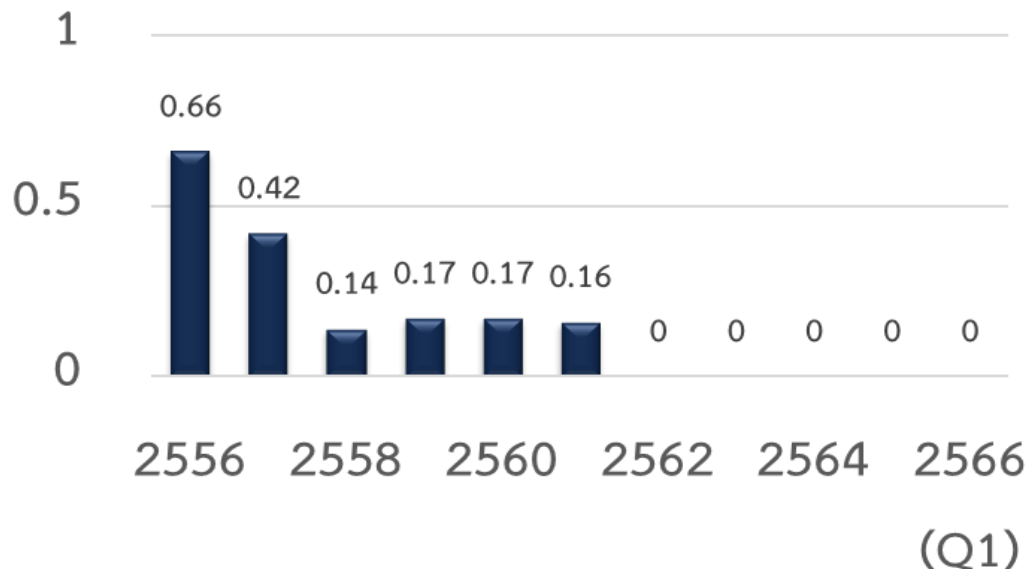
min: minute; MRSA: methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*.

Source: References 10, 11, 15.

<https://www.uspharmacist.com/article/antimicrobial-prophylaxis-in-joint-arthroplasty>

SSI Target surveillance

อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดในข้อเข่าหลังผ่าตัดขณะ Admit (%)



รายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2564

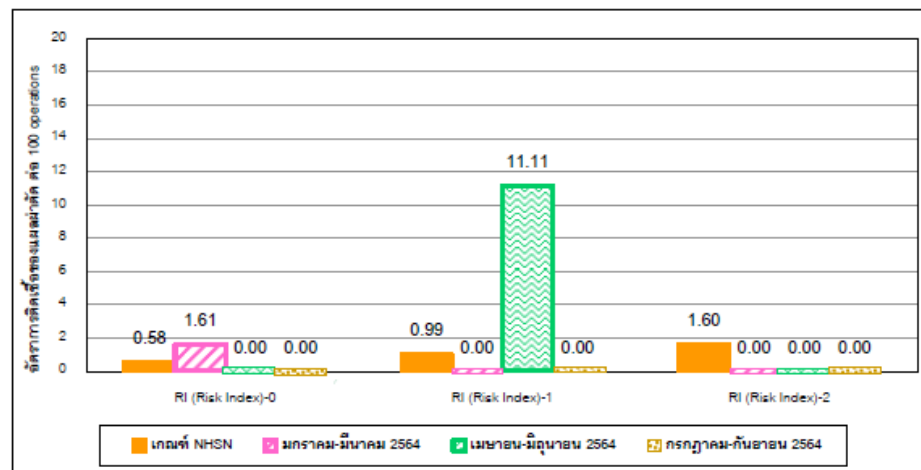
ภาควิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

E
Center

* การติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัด หักถ่วง Knee replacement

ข้อมูลตัวชี้วัด (หน่วย : ครั้งต่อ 100 operation)	เป้าหมาย	เกณฑ์ NHSN*	พ.ศ.2564								พ.ศ.2564	
			ม.ค. - มี.ค. (N=92)		เม.ย. - มิ.ย. (N=30)		ก.ค. - ก.ย. (N=16)		ต.ค. - ธ.ค. (N=)		ม.ค. - ก.ย. (N=138)	
Risk Index 0	0.58	0.58	1/62	1.61	0/18	0.00	0/11	0.00			1/91	1.10
Risk Index 1	0.99	0.99	0/28	0.00	1/9	11.11	0/5	0.00			1/42	2.38
Risk Index 2	1.60	1.60	0/2	0.00	0/3	0.00	0/0	0.00			0/5	0.00

* National Healthcare Safety Network (NHSN) System Report (AJIC December 2009 ; vol.37 No.10)



Procedure : Knee replacement

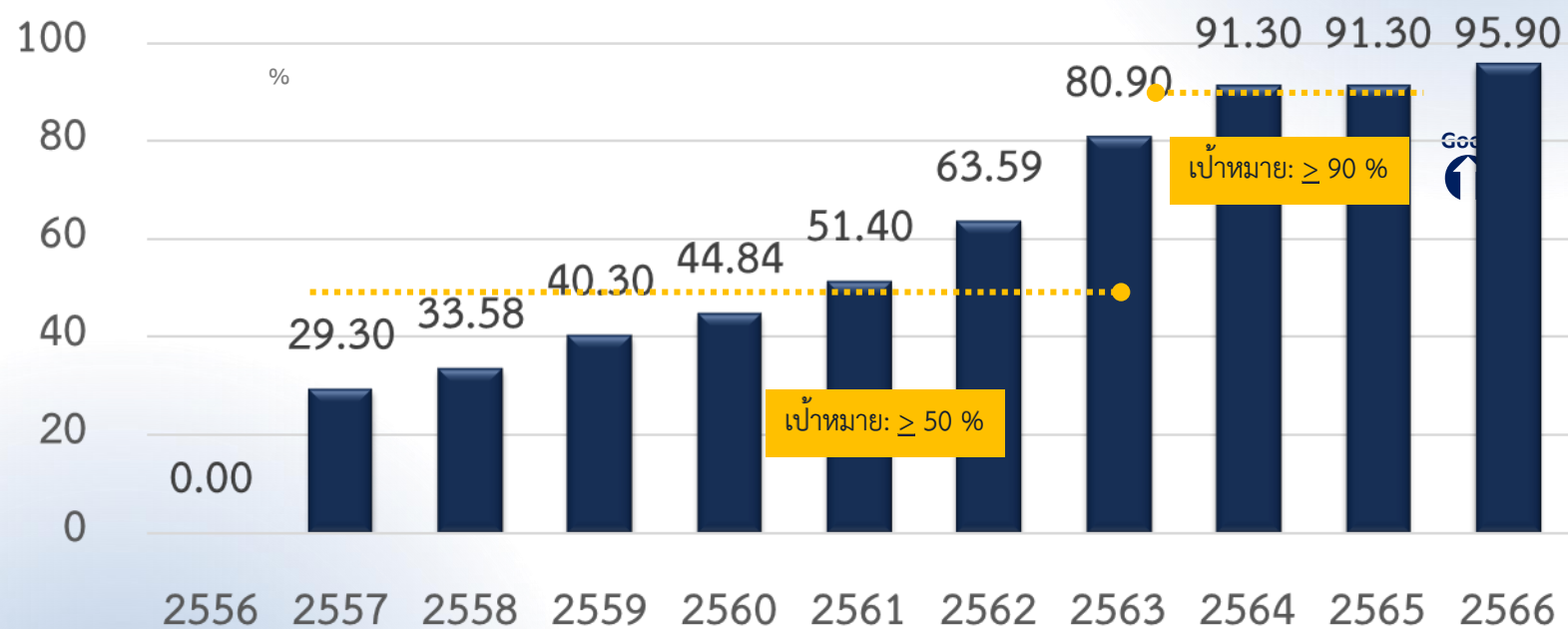
การเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดหัตถการ Knee replacement ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 มีจำนวนหัตถการ 16 ครั้ง ไม่พบการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดในทุกระดับความเสี่ยง (Risk Index ที่ 0, 1 และ 2)

หมายเหตุ

การประเมินความเสี่ยง Risk Index ของ National Healthcare Safety Network (NHSN) ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ส่วนดังนี้

1. Wound class ถ้าการผ่าตัดมี wound class เป็นประเภท clean wound และ clean-contaminated wound ให้คะแนนเท่ากับ 0 ถ้า contaminated wound และ dirty wound ให้คะแนนเท่ากับ 1
2. ASA score ถ้าผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดมี ASA score 1 และ 2 ให้คะแนนเท่ากับ 0 ถ้า score 3 4 และ 5 ให้คะแนนเท่ากับ 1
3. Duration of surgery ถ้าระยะเวลาผ่าตัด < 75th ให้คะแนนเท่ากับ 0 ถ้า ระยะเวลาผ่าตัด > 75th ให้คะแนนเท่ากับ 1

อัตราการได้ยา surgical prophylaxis ภายใน 24 ชั่วโมง (%)



(Q1)

* 2566 (Q1) หมายถึง ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565)



II-4.2 การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention Practices)

องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ.

ก. การป้องกันการติดเชื้อทั่วไป

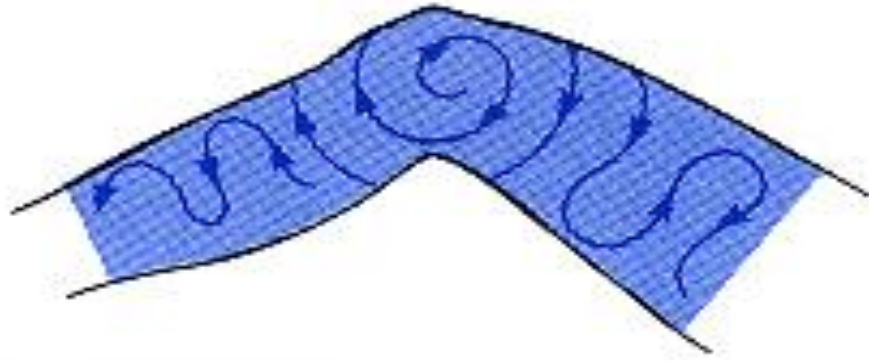
- 1** **การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ**
standard precautions, isolation precautions, sterilization, scope reprocessing, single-use devices reprocessing (if permitted)
- 2** **การควบคุมสิ่งแวดล้อม**
โครงสร้างอาคารสถานที่ การควบคุมสภาพแวดล้อมด้วย
มาตรการทางวิศวกรรมและการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ มาตรการลดความเสี่ยงระหว่างการก่อสร้าง
การแยกพื้นที่ใช้งานสะอาดออกจากพื้นที่ปนเปื้อน
- 3** **การลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ**
ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยที่มีความแออัด
ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ หน่วย
ซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง ครัว หน่วยกายภาพบำบัด ห้องเก็บศพ

ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเฉพาะ

- 1** **ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สำคัญขององค์กร**
เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
การติดเชื้อจากการให้สารน้ำ และการติดเชื้อในกระแสเลือด
- 2** **การดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ**
ผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งติดต่อได้ทางโลหิต ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
การจัดการกับการติดเชื้อดื้อยาและการติดเชื้ออุบัติใหม่
- 3** **การดูแลเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสเชื้อ**
สัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ติดเชื้อจากการทำงาน

การติดเชื้อต่ำที่สุด

Skin Prep and Drape

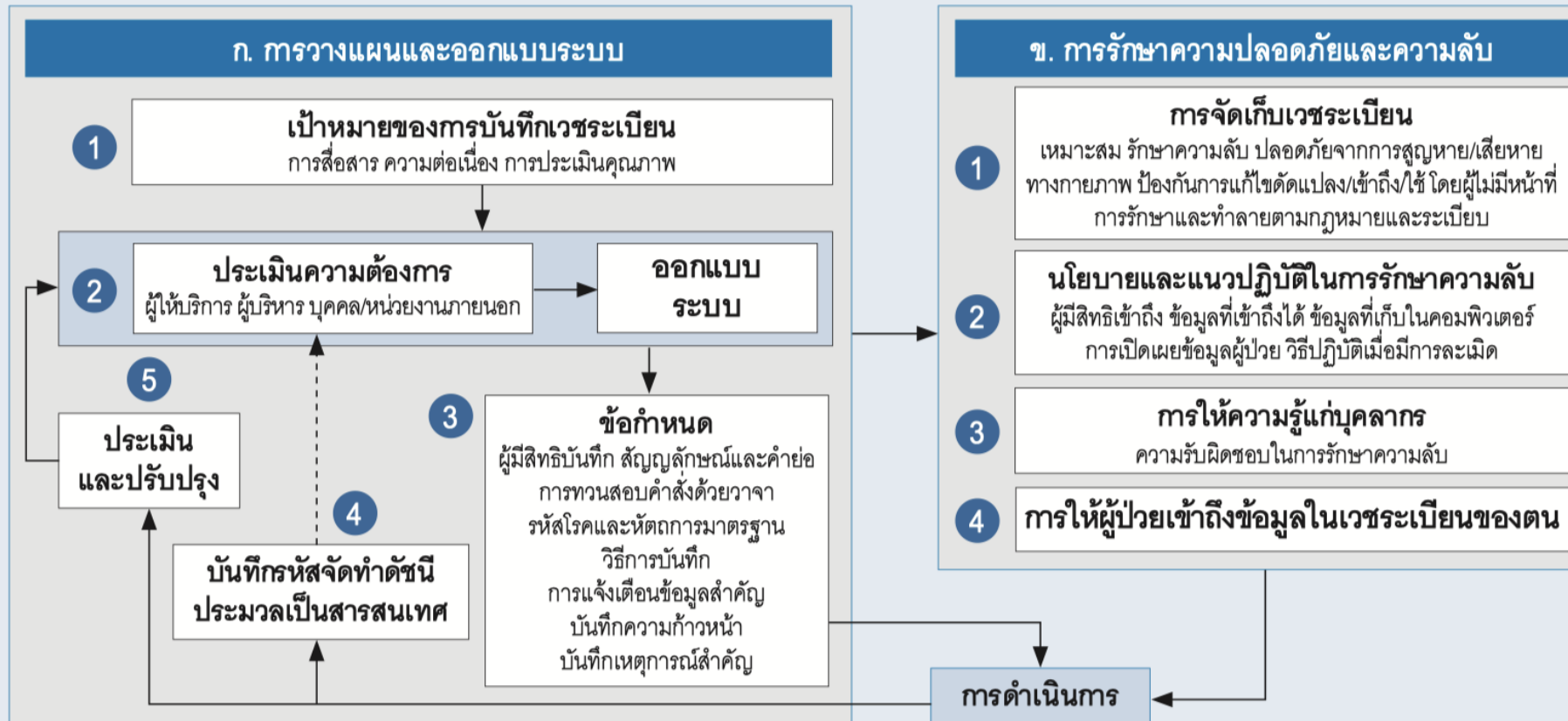


ระบบงานสำคัญ

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS)

II-5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (Medical Record Management System)

องค์กรจัดให้มีระบบบริหารเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย.



Multidisciplinary team Progression note



SIELITE
Siriraj Hip and Knee
Joint replacement Excellent Center

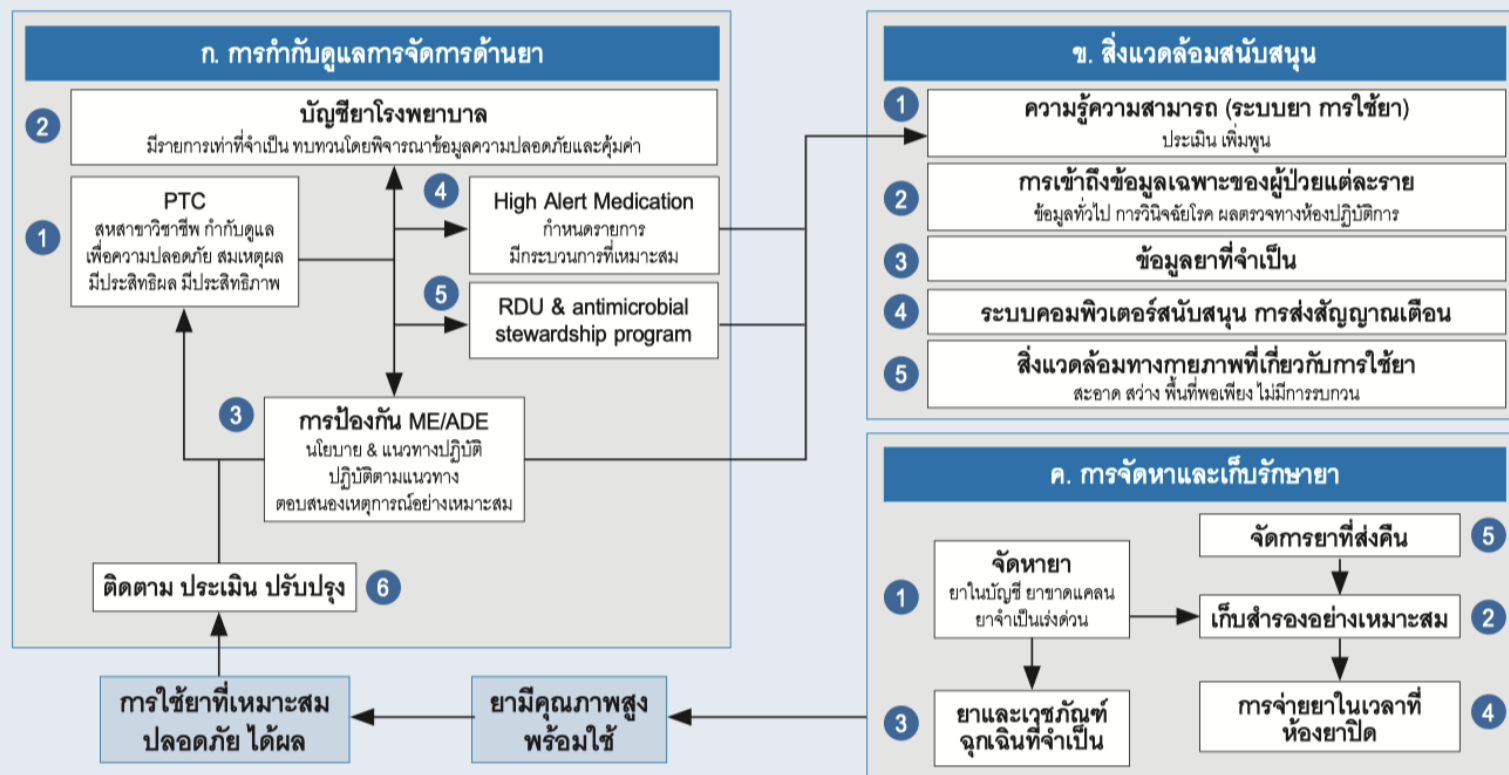
Progress note (Postoperative Knee arthroplasty)		 H.N. A.N. Name Age Physician Ward Print/Name label
Progress note: Postoperative knee arthroplasty Day (Date.....)		
Orthopedist (Time.....) 1. Physical examination Vital sign: ☐ Stable, within normal range ☐ Unstable, describe;..... Wound condition: ☐ Good ☐ Bloody drainage, describe;..... VTE signs: ☐ No ☐ Suspected DVT ☐ Suspected PE, describe;..... 2. Symptoms Pain score = Nausea / Vomiting : ☐ No ☐ Yes ; ☐ Mild (<3 times/day) ☐ Moderate (3-6 times/day) ☐ Severe (>6 times/day) Drain.....ml Hct =% (Time.....) Anemic symptoms: ☐ No ☐ Yes, describe;	4. Fluid in take / out put ☐ Balance ☐ Imbalance, describe; 5. Postoperative radiograph ☐ Satisfied components & placement ☐ Suspected adverse event, describe;..... 6. Plan ☐ Progressive early ambulation ☐ Delayed ambulation due to..... 7. Others..... Patient performance for daily activity Before discharge, Patient can / has ☐ Walk with walker > 10 meters ☐ Up and down stair correctly under supervisor ☐ Flex knee at least 90 degrees (Active/Passive) ☐ Not require IV pain medication within 12 hrs ☐ No sign of surgical site infection ☐ No fever within 24 hrs Physician's signature.....	Physiotherapist (Time.....) Pre-physical therapy pain score = Post-physical therapy pain score = 1. Continue physical therapy program ☐ Can ☐ Cannot;..... 2. Ambulate on level surfaces with walker ☐ <10 meters ☐ >10 meters ☐ Cannot;..... 3. Active ROM when knee flexion $\geq 90^\circ$) ☐ Can ☐ Cannot;..... 4. On CPM when knee flexion $\leq 50^\circ$) ☐ Do ☐ Do not;..... 5. Cryotherapy ☐ Do ☐ Do not;..... 6. Up-down stair correctly with 1 assistant ☐ Can ☐ Cannot;..... 7. Home Program ☐ Do ☐ Do not;..... 8. Other..... Physiotherapist's signature.....

ระบบงานสำคัญ

II-6 ระบบการจัดการด้านยา (MMS)

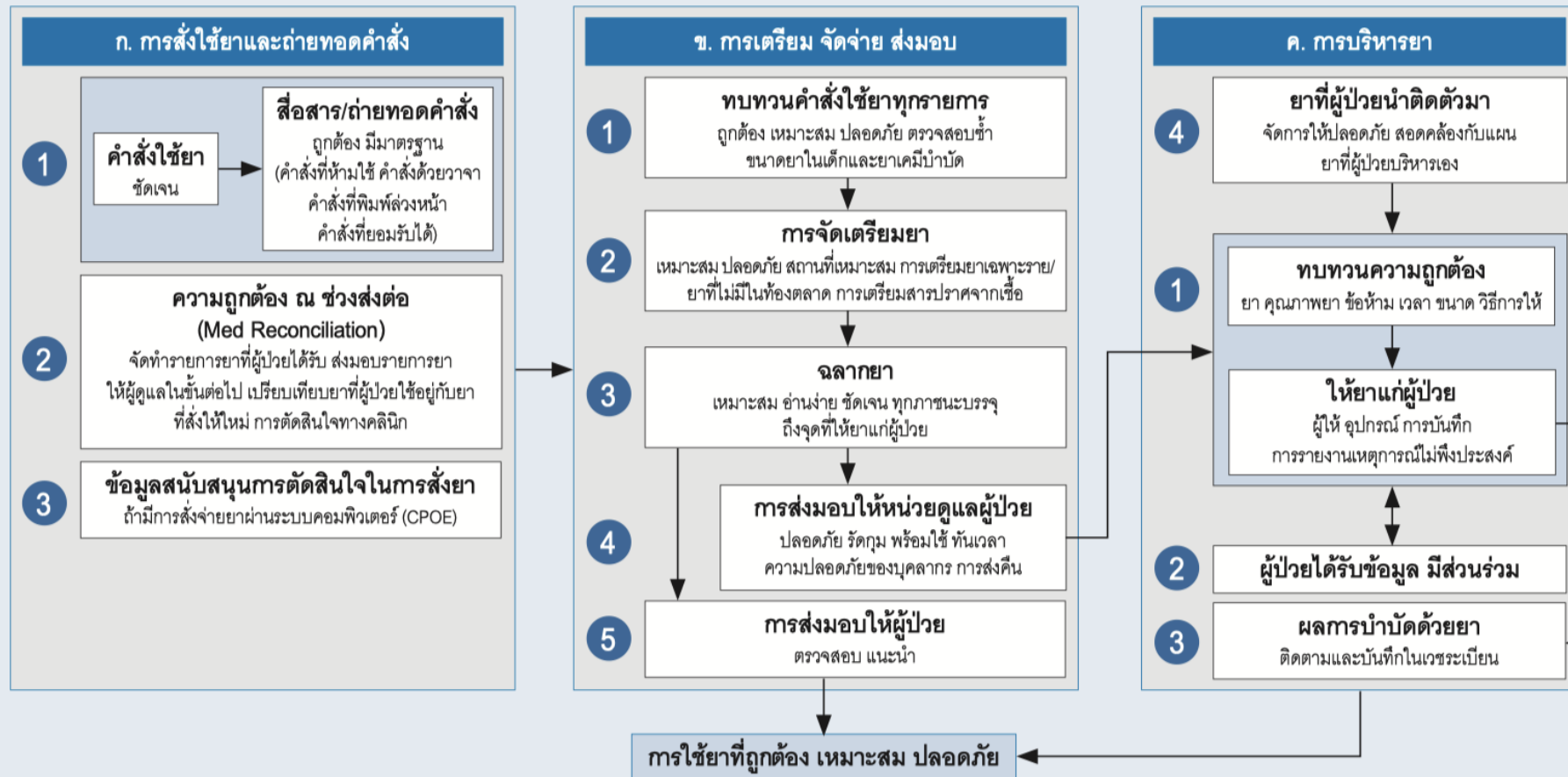
II-6.1 การกำกับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน (Oversight and Supportive Environment)

องค์กรสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล รวมทั้งการมียาที่มีคุณภาพสูง พร้อมใช้สำหรับผู้ป่วย ผ่านกลไกกำกับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน.



II-6.2 การปฏิบัติในการใช้ยา (Medication Use Practices)

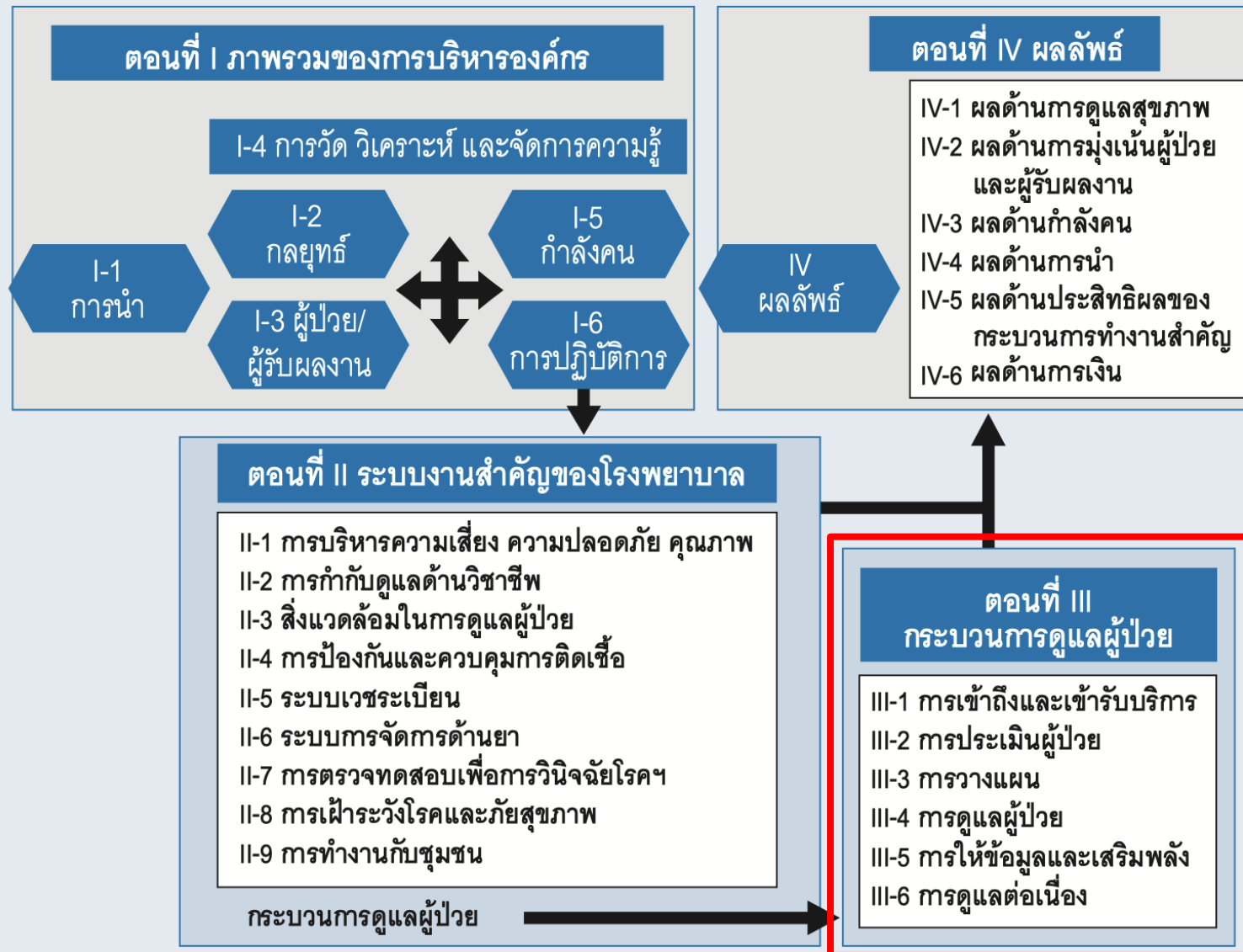
องค์กรทำให้นับใจในความปลอดภัย ความถูกต้อง ความเหมาะสม และประสิทธิผลของกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การสั่งใช้ยาจนถึงการบริหารยา.





Part III

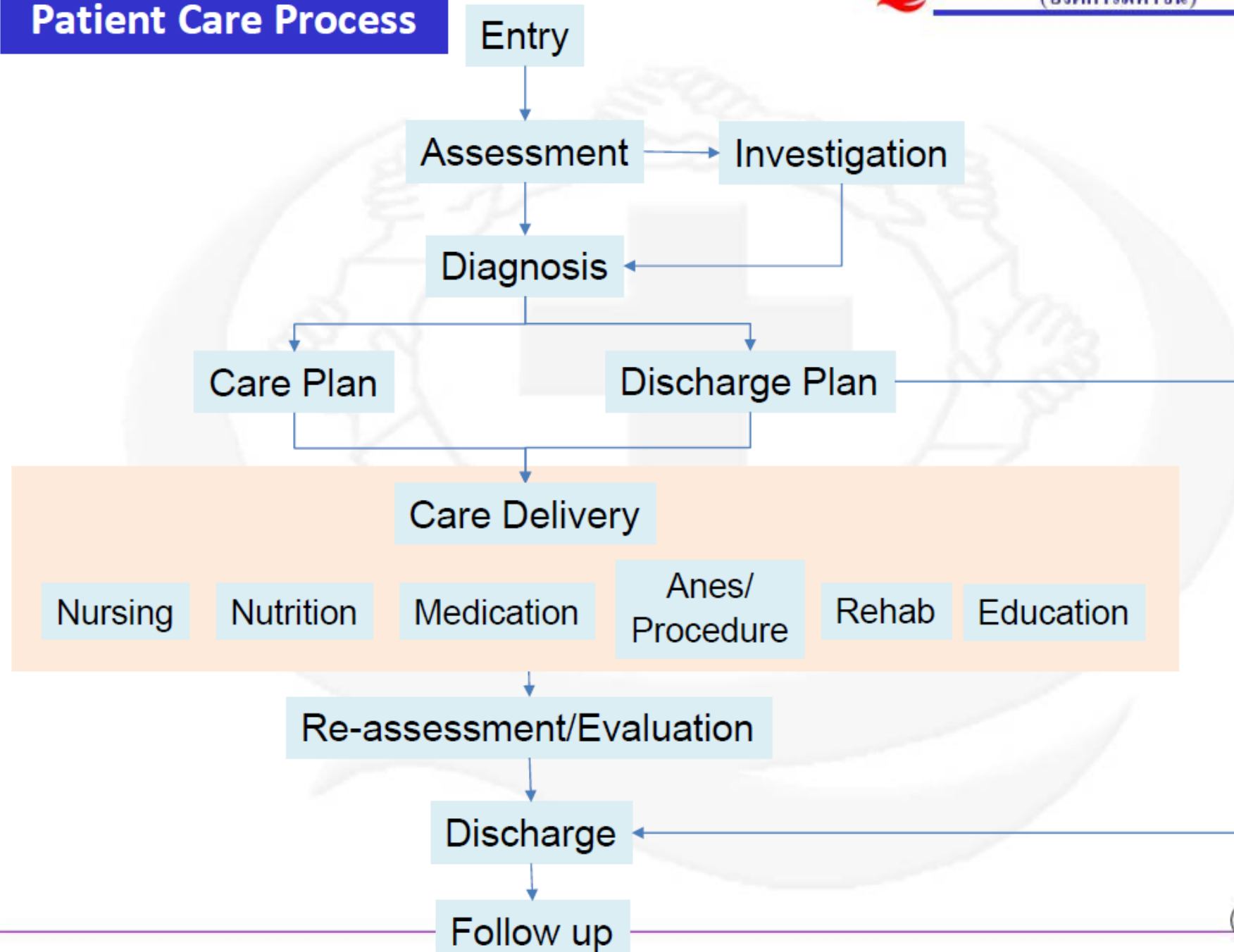
กระบวนการดูแลผู้ป่วย



Patient Care Process



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)





ที่มีมาตรฐาน III-1 ถึง III-6 แต่เพิ่มความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ

III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็น ได้โดยสะดวก มีกระบวนการรับผู้ป่วยที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วย อย่างทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ.

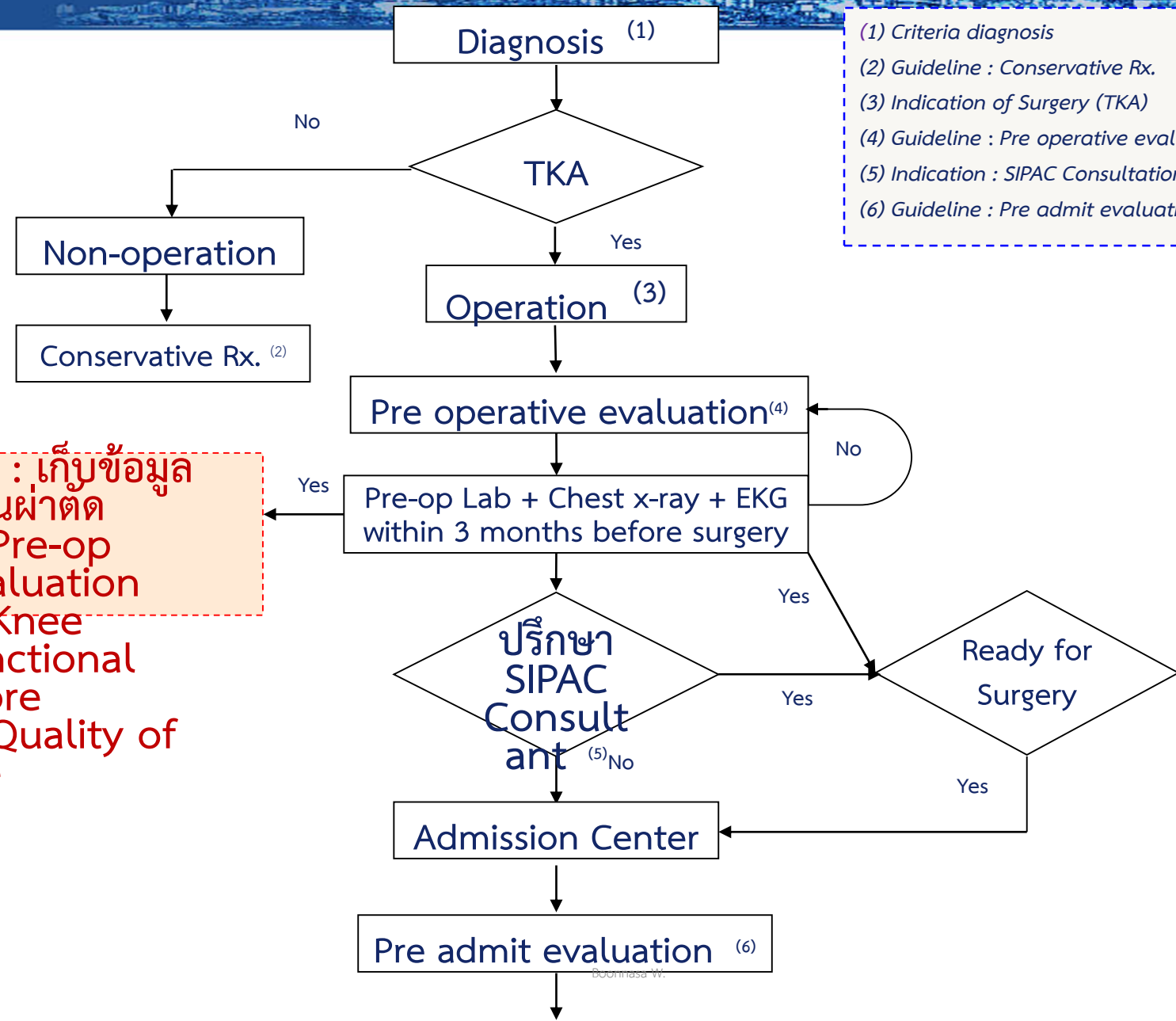
III-2 การประเมินผู้ป่วย

ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม

III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย

ทีมผู้ให้บริการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย.

KPI : เก็บข้อมูล
ก่อนผ่าตัด
1. Pre-op
evaluation
2. Knee
functional
score
3. Quality of
life



- (1) Criteria diagnosis
- (2) Guideline : Conservative Rx.
- (3) Indication of Surgery (TKA)
- (4) Guideline : Pre operative evaluation
- (5) Indication : SIPAC Consultation
- (6) Guideline : Pre admit evaluation

KPI :

1. ATB within 60 min.
Pain score (at rest) $\geq$ 6 ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน < 20%
2. Pain score (at rest) $\geq$ 7 2 ครั้งติดต่อกัน

Nursing Management

1. Vital sign
2. Position
3. Pain score
4. Wound assessment
5. Complication
6. Discharge Planning :
- knowledge - skill

KPI :

1. LOS $\leq$ 7 วัน
2. Symptomatic VTE < 1%
3. Mortality = 0
4. ความพึงพอใจของผู้ป่วย > 80%

KPI : Surgical site

infection, knee score at 1 year post-op 1%

Admit

Pre-op

Surgery

Post
operation

Discharge

Follow up

1. Pre- operation evaluation by surgeon and anesthetist
2. ดูแลผู้ป่วยตาม Care Map *
3. Medication reconciliation
4. Pre-operation knowledge for patients
5. Discharge planning
6. จองเลือดแบบ Type & Screen และ Crossmatch
7. Joint registry

1. ดูแลผู้ป่วยตาม Care Map*
2. Assessment consult: ตรวจสอบเอกสาร lab เลือด, x-ray
3. ตรวจสอบความพร้อมของ Implant และ Loaner Instrument
4. ให้อาา prophylaxis antibiotic 90%
5. Siriraj Surgical Safety Checklist

PT Program

ประเมินและเตรียม
ความพร้อมผู้ป่วยใน
การฝึกเดินเพื่อให้เดิน
ด้วย walker ให้ได้
ภายใน 2 วัน

Health education:
Weight control, Infection

KPI :

1. ผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้
โดยมีผู้ช่วยเหลือ 1 คน ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ ช่วยเดินภายใน
2 วันหลังผ่าตัด $\geq$ 90%
2. Pain score (on movement) $\geq$ 7 เป้าหมาย < 20%
3. ผู้ป่วยสามารถลงเข้าได้ $\geq$ 90
องศา ก่อน discharge

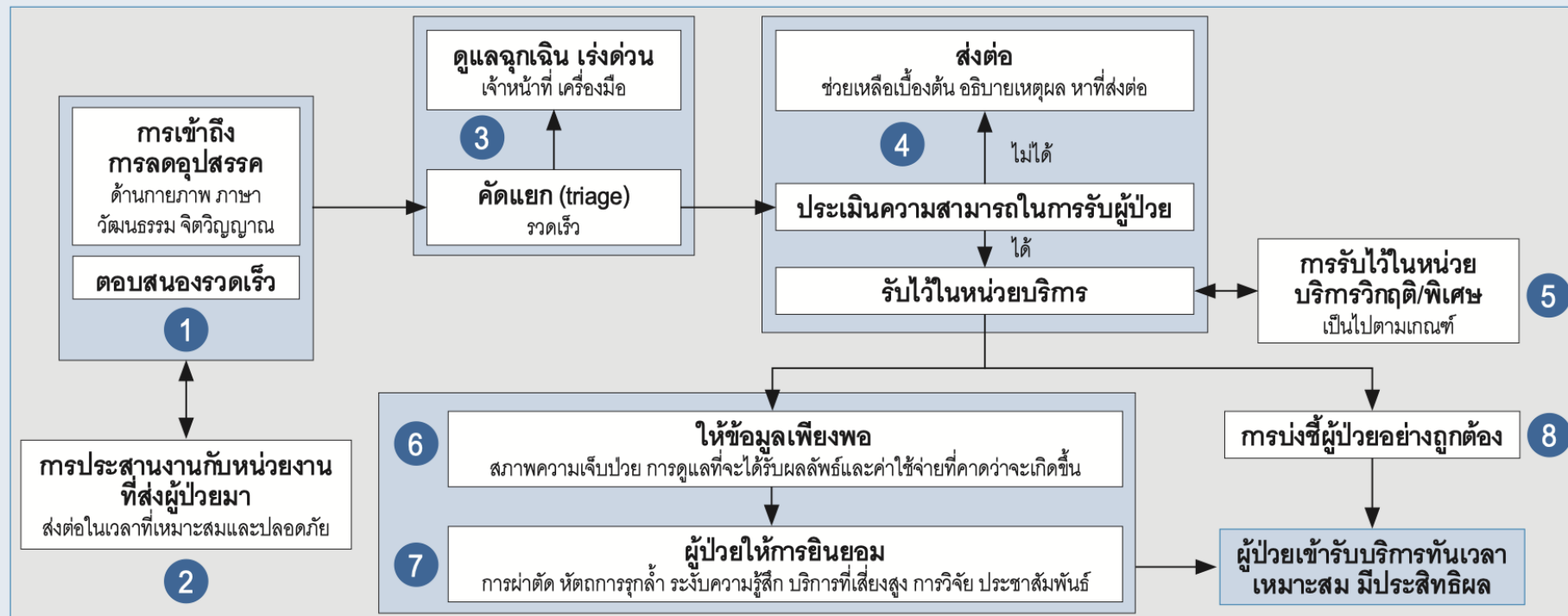
ประเมิน functional outcome โดย Knee Score

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN)

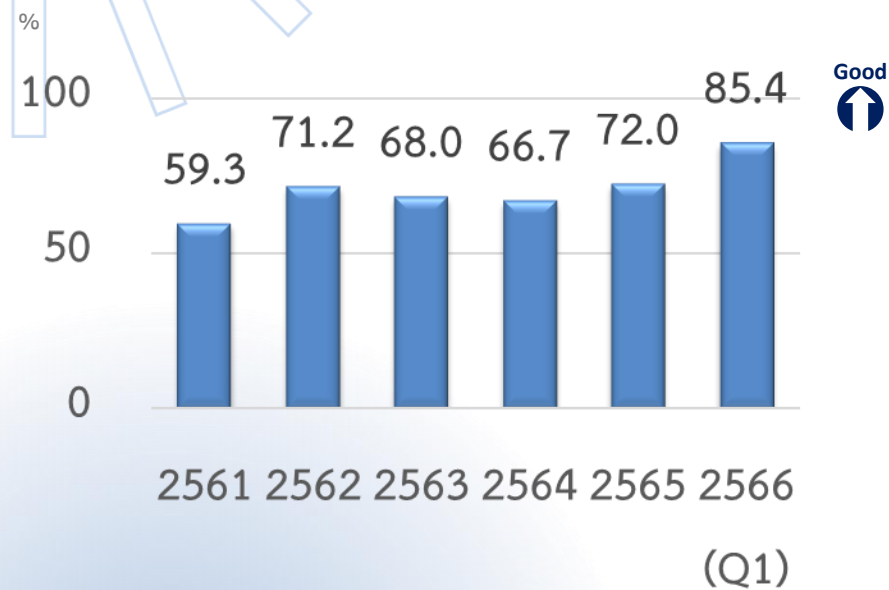
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry)

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้โดยสะดวก มีกระบวนการรับผู้ป่วยที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วย อย่างทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ.

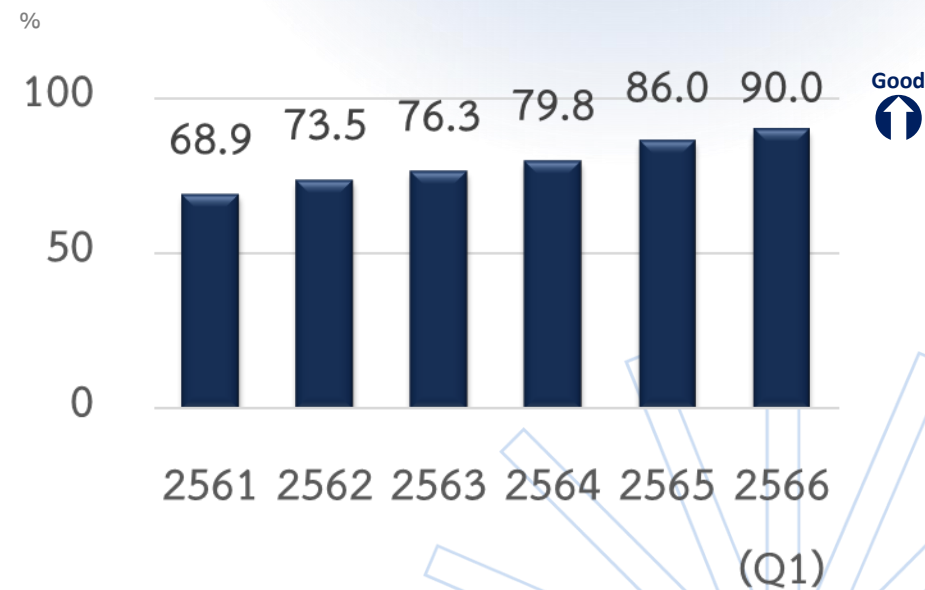


KPI result

อัตราผู้ป่วยได้ผ่านโครงการ Pre-op (%)



อัตราผู้ป่วยได้รับการเก็บข้อมูล Pre-op knee score (%)



* 2566 (Q1) หมายถึง ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565)



ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ควรมีการทบทวนแนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ส่งเสริมให้ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านร่วมกัน นำมาวางแผนเตรียมความพร้อม เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถจัดการกับปัญหา และความ ต้องการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมโดยผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ตอบ

- การทำ Pre op Clinic for Arthroplasty
- รวมทั้งการประเมิน Functional Knee score และ คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
- บันทึกในระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
- หากกรณีหลังผ่าตัดพบปัญหาที่จะต้องดูแลต่อเนื่องในช่วงระยะ Follow up จะมีการส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด และพยาบาล CNC โดยในอนาคตจะมีการนำข้อมูลเหล่านี้ส่งเข้าใน Application เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน

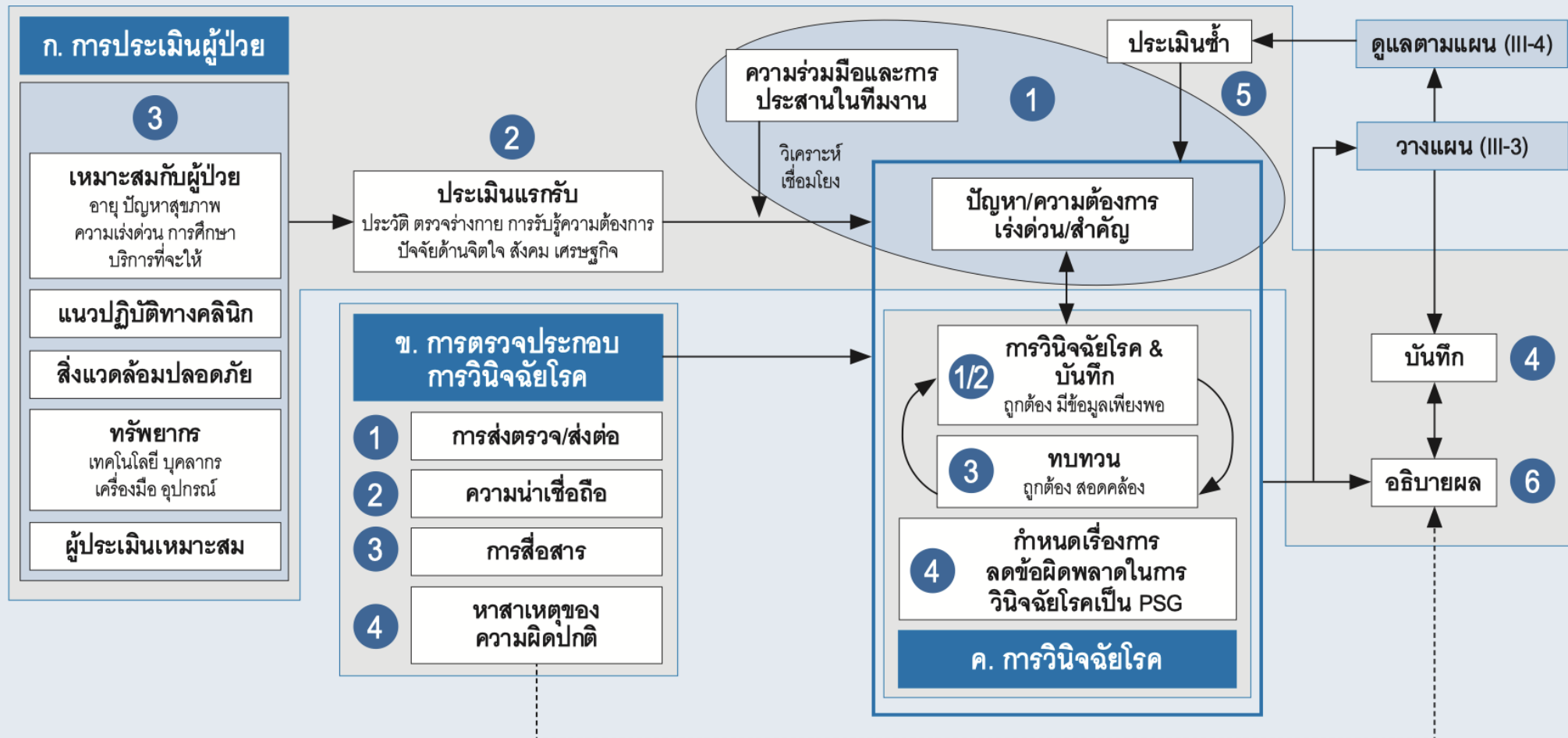
อัตราผู้ป่วยที่เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในการจัดประชุมใหญ่ (เดิม)				Pre-op Clinic (ปัจจุบัน)			
ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
11.6%	22.3%	15.7%	12.5%	67.0%	71.1%	68.0%	66.7%



กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-2 การประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment)

ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม.

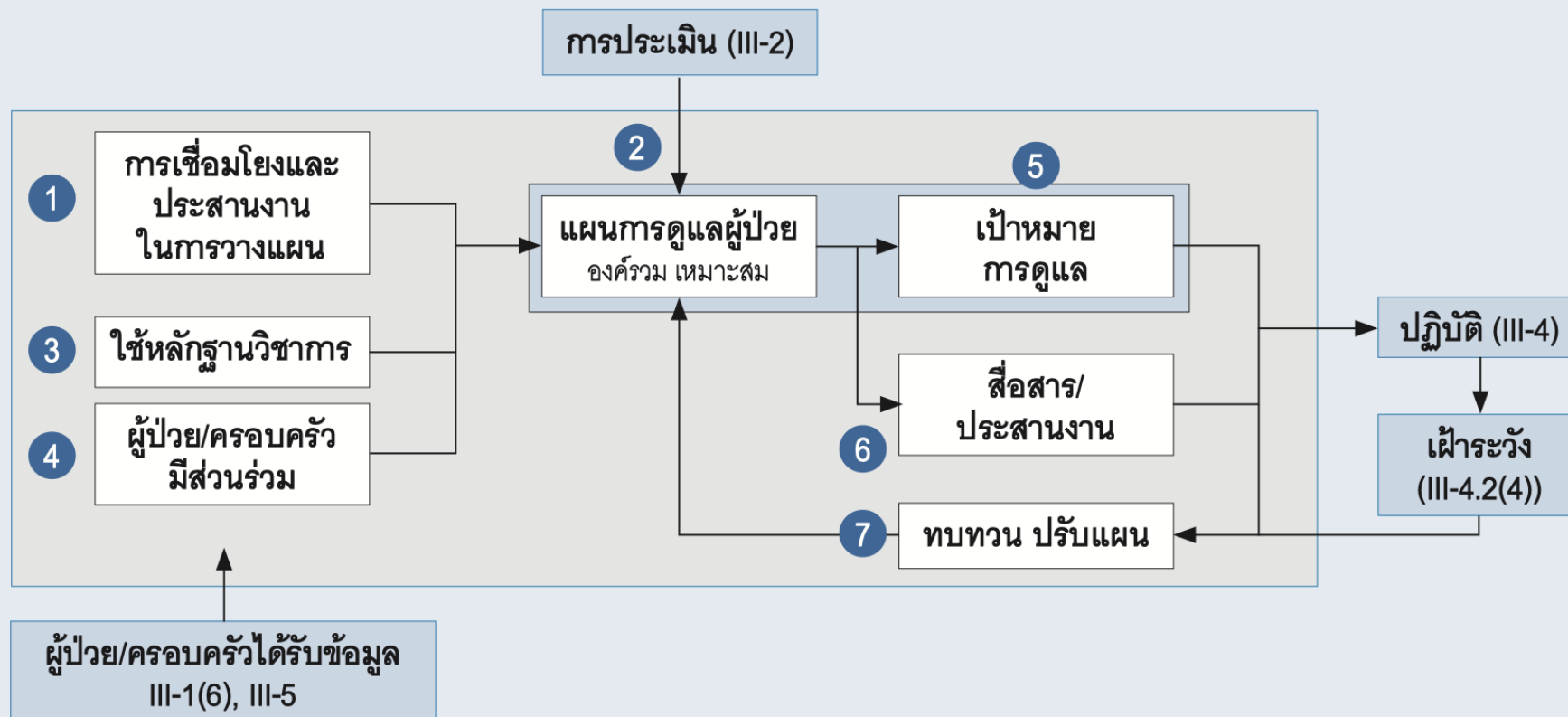


กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-3 การวางแผน (PLN)

III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (Planning of Care)

ทีมผู้ให้บริการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา / ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย.





III-3.2 การวางแผนจำหน่าย

มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ หลังจากจำหน่ายออกจากองค์กร.

III-4.1 การดูแลทั่วไป

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลอย่างทันที่ ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

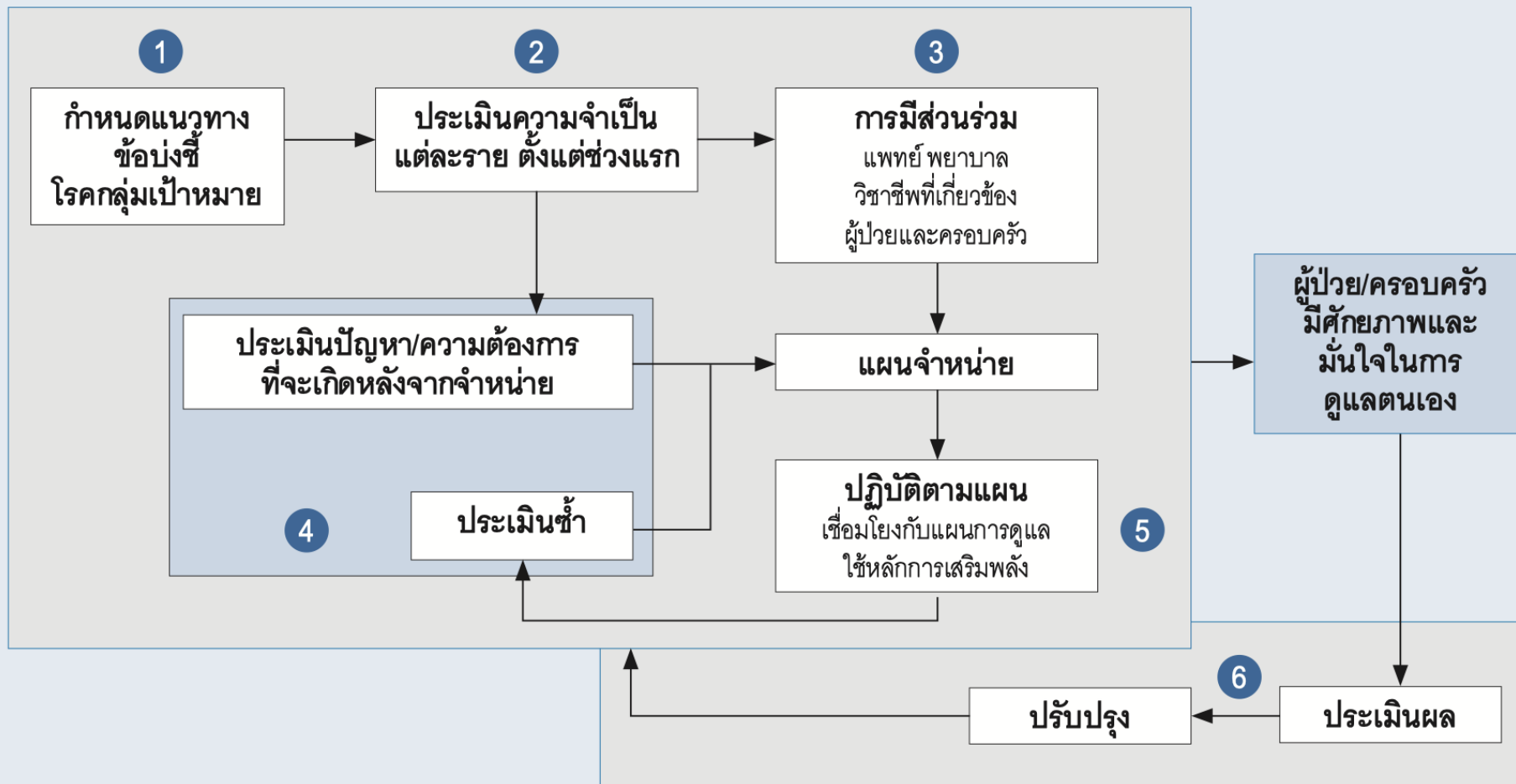
III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างทันที่ ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-3.2 การวางแผนจำหน่าย (Discharge Planning)

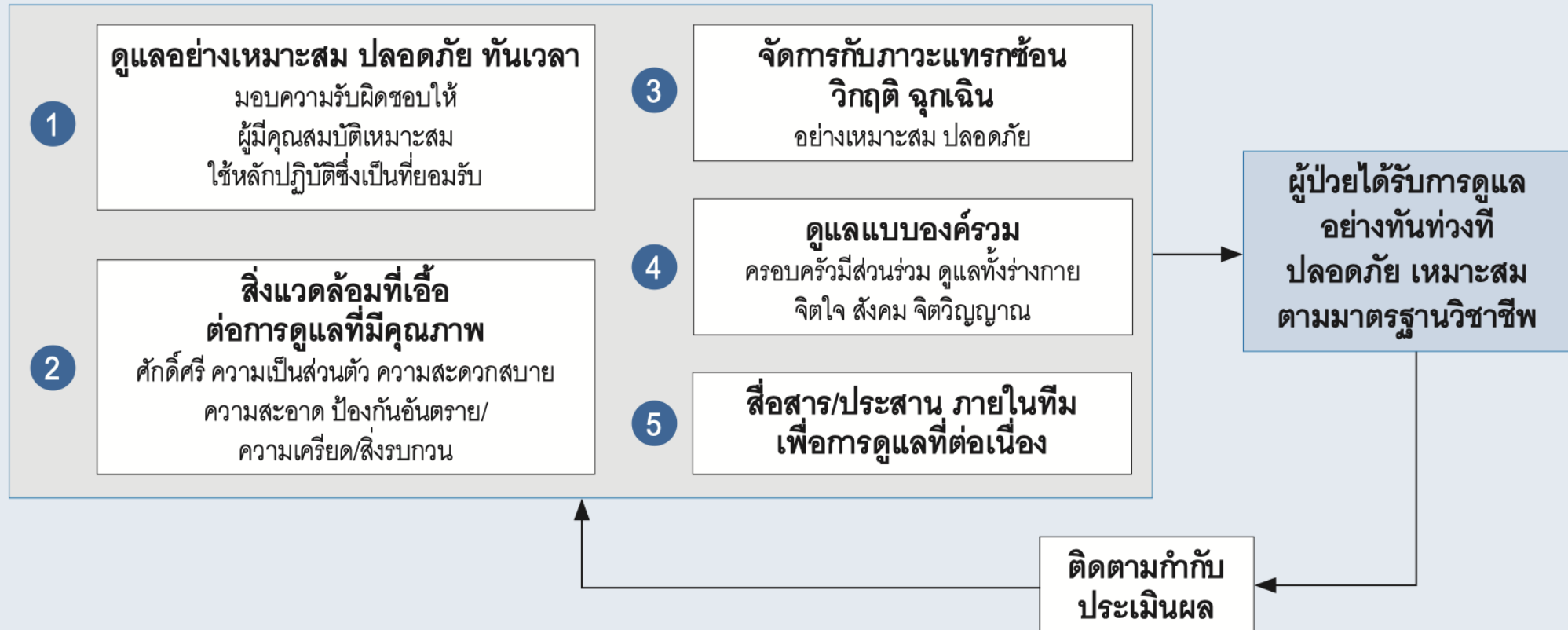
มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ หลังจากจำหน่ายจากโรงพยาบาล.



กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.1 การดูแลทั่วไป (General Care Delivery)

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ.





ตอนที่ 2 ระบบงานสนับสนุน

ควรมีการพิจารณาทบทวนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในหอผู้ป่วยให้เหมาะสมกับ Position ของผู้ป่วยขณะใช้งาน เช่น ระดับความสูงของโถนั่งในห้องน้ำ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยสม่ำเสมอ เพื่อนำมาวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อไป

ตอบ

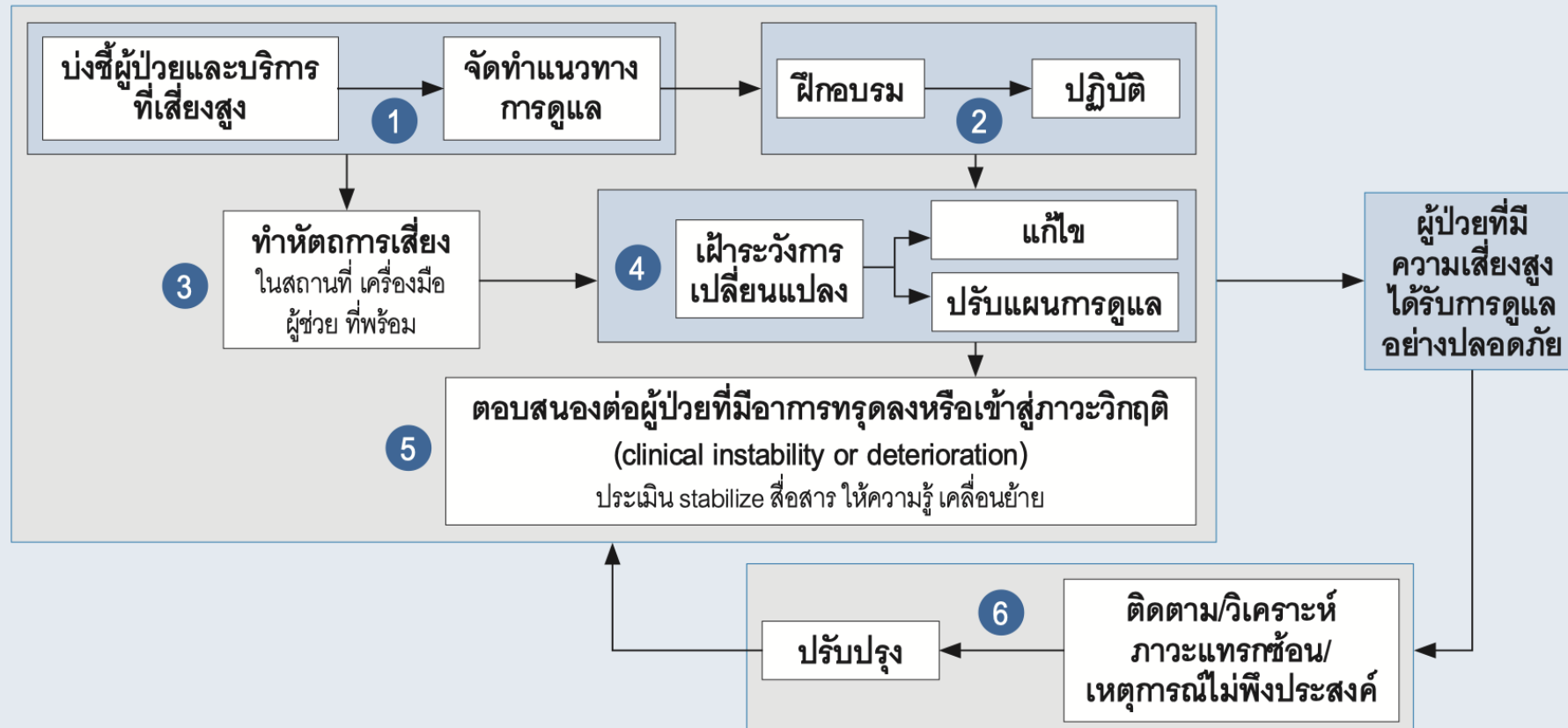
- ในหอผู้ป่วยมีหอผู้ป่วยบางส่วนที่ได้มีการปรับสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมแล้ว ส่งเสริมการมี Early ambulation
- การใช้ MEWs การใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่างๆ การทำ Hourly round
- ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลในอนาคตข้างหน้า คือ การจัดตั้งศูนย์ SiELITE



กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง (Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services)

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.



การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยด้วย SBAR

- * IDENTIFY SELF & SITE/
UNIT PERSON CALLING from
- * IDENTIFYING INDIVIDUAL
(NAME & D.O.B)
- * SYMPTOM ONSET & SEVERITY



- * DATE/TIME of ADMISSION
- * ADMITTING DIAGNOSIS
- * RELEVANT MEDICAL HISTORY
- * LAB/DIAGNOSTIC RESULTS
- * NOTABLE CHANGES



SITUATION



- * SUSPECTED UNDERLYING
CAUSE or CONCERNS

BACKGROUND



- * RECOMMENDATION & EXPECTATIONS
- ~ CLEAR/SPECIFIC about URGENCY of
REQUEST & EXPECTED TIME FRAME

ASSESSMENT



RECOMMENDATION

PURPOSE

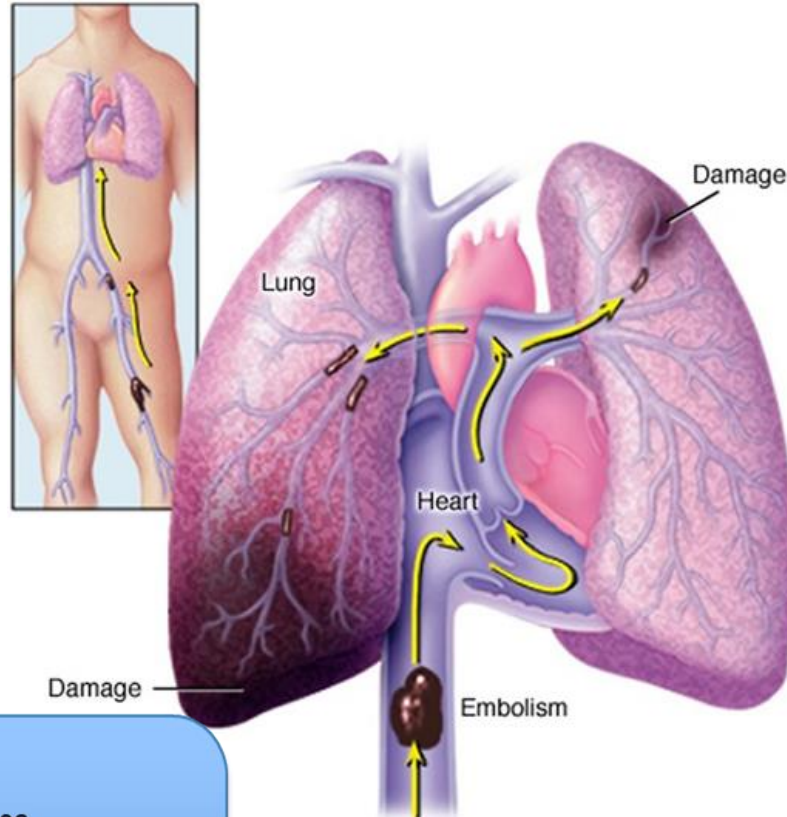
- * COMMUNICATION TOOL to STRUCTURE
CONVERSATION about MEDICAL SITUATIONS
REQUIRING IMMEDIATE ATTENTION & ACTION
- ~ REDUCES ERRORS
- ~ ENCOURAGES ASSESSMENT & DECISION-MAKING SKILLS



ความเสี่ยงหลังผ่าตัด

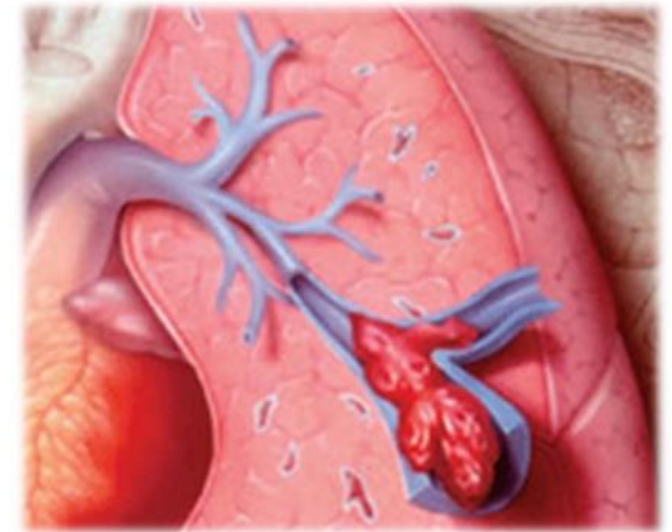
ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
การเคลื่อนย้ายและความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงลดต่ำลงจากการเปลี่ยนท่า	Monitoring การเคลื่อนย้ายด้วยความนุ่มนวล
ภาวะพร่องออกซิเจน จากกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจทำงานไม่ปกติ	การประเมินผู้ป่วยก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด การศึกษาพยาธิสภาพของโรค ความเสี่ยง การให้ข้อมูล การMonitoring การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
การเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิต	
การเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท	
ความสมดุลน้ำ เลคโทรลย์ท์ กรด ต่าง	
การคลื่นไส้อาเจียน	
อาการไม่สุขสบายความวิตกกังวล ความวิตกกังวล	
ภาวะความดันโลหิตลดต่ำลงจากการได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง	การเปลี่ยนท่าอย่างนุ่มนวล
โอกาสเกิดภาวะ Pneumothorax จากการทำ Brachial block	การสังเกตการเปลี่ยนแปลง

Pulmonary Embolism+ DVT = Venous thromboembolism

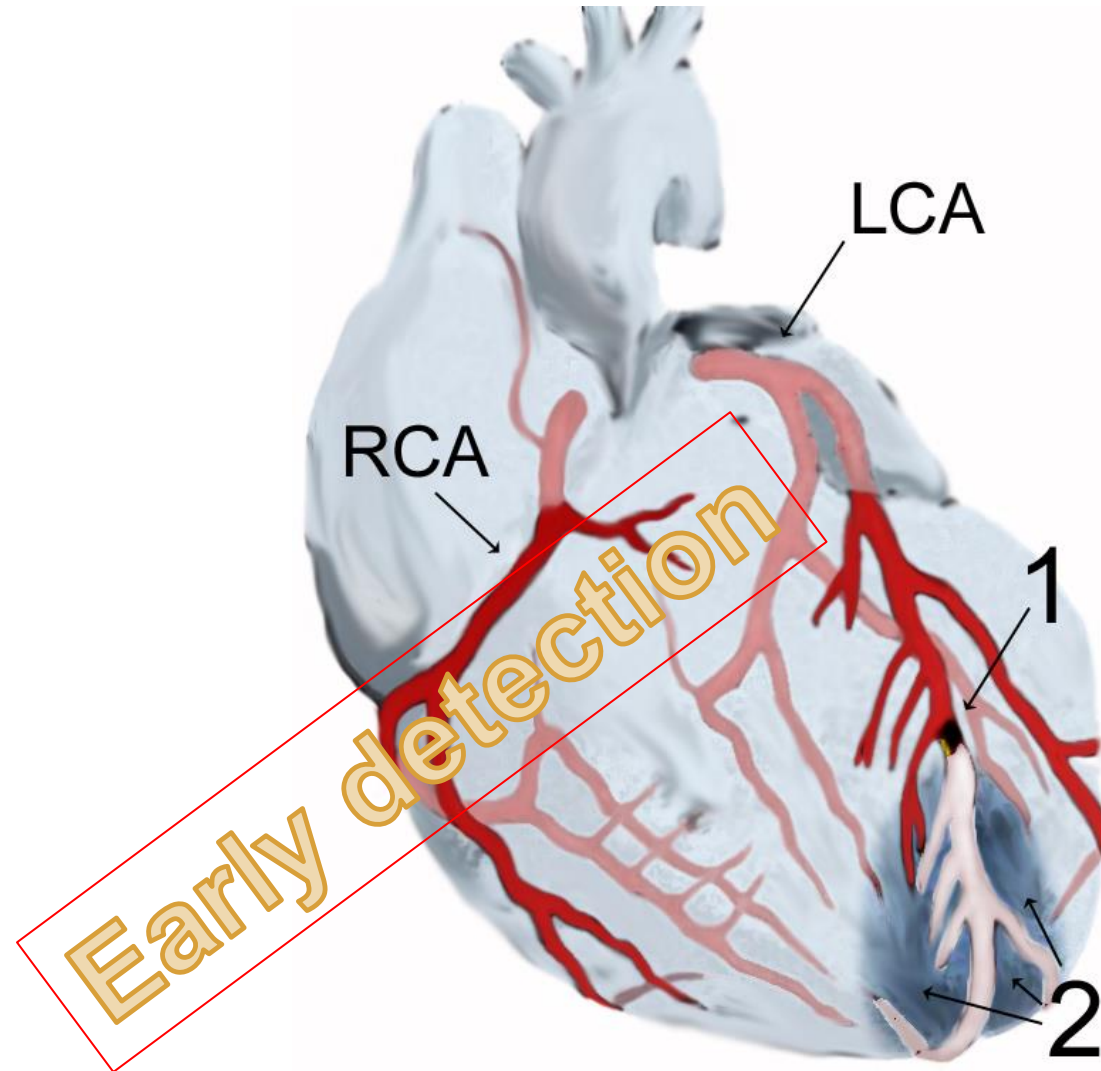


Dyspnea
Chest pain
Hypoxia
Dizziness
Cough (blood)

Pulmonary Embolism

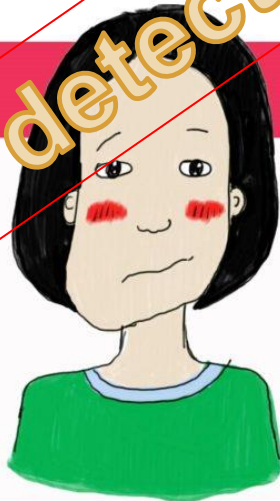


Myocardia infraction



ตรวจเช็คอาการ “โรคหลอดเลือดสมอง” (STROKE)

Early detection



Face

ใบหน้าเบี้ยว



Arm

แขนขาอ่อนแรง



พูดไม่ชัด
Speech



ระยะเวลาที่มีอาการ
ต้องรักษาทันทีใน 3 ชั่วโมง

Time



ปาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน

1669

โทรฟรีทั่วประเทศ



III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2)

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง
ทันทั่วทั้งที่ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

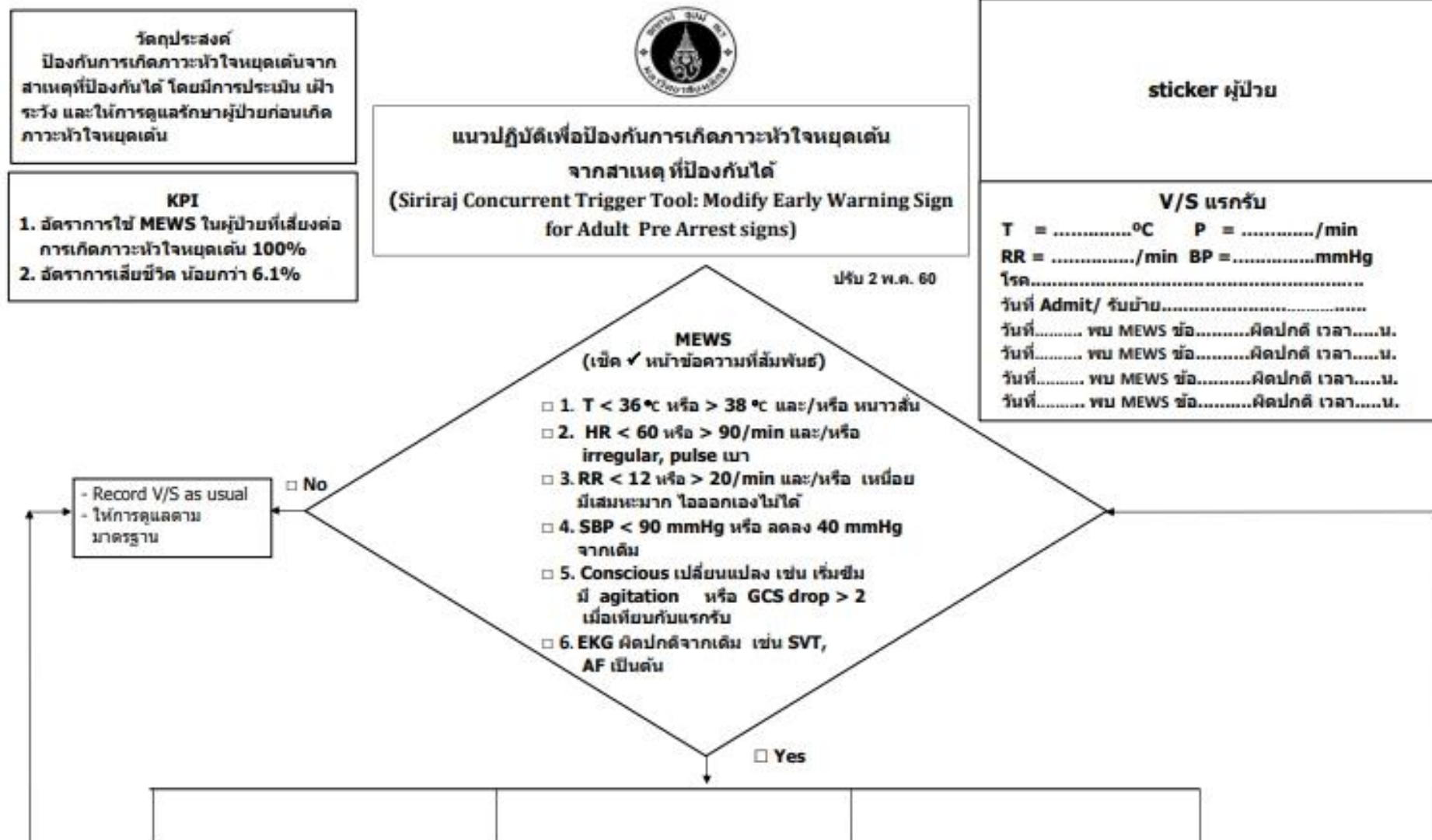
- (1) ทีมผู้ให้บริการวิเคราะห์ผู้ป่วย⁷² และบริการ⁷³ ที่มีความเสี่ยงสูง และร่วมกันจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว.
- (2) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม เพื่อนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาสู่การปฏิบัติ.
- (3) การทำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง ต้องทำในสถานที่ที่เหมาะสม มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและผู้ช่วยที่
จำเป็น.
- (4) มีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่วย⁷⁴ และดำเนินการแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้ทันทั่วทั้งที่.

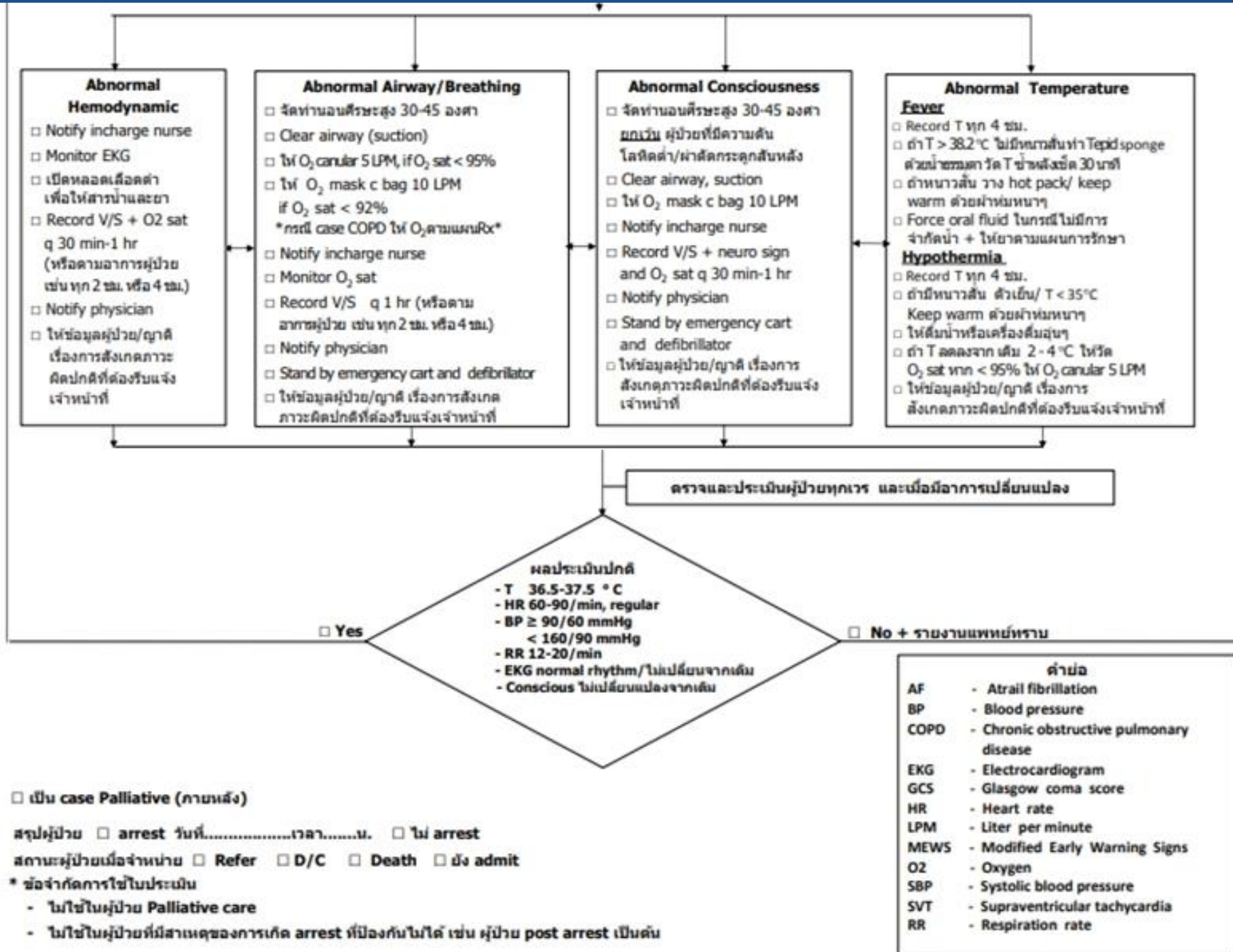
⁷² ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กอายุน้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉุกเฉินที่สับสนหรือไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายอวัยวะ ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง

⁷³ บริการที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะเป็นบริการที่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนเพื่อรักษาภาวะที่คุกคามต่อชีวิต ธรรมชาติของการรักษาที่มีความเสี่ยง
หรือบริการที่มีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เช่น การฟอกเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การใช้เครื่องผูกยึด
การให้ยาเพื่อให้หลับลึก (moderate and deep sedation)

⁷⁴ เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง เช่น กราฟบันทึกสัญญาณชีพที่มีแถบสีแดงถึงระดับสัญญาณชีพที่ต้องมีการพบทวน (แถบสีเหลือง)
หรือมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (แถบสีแดง) ดูตัวอย่าง SAGO (Standard Adult General Observation) chart ของออสเตรเลีย

Modify Early Warning Sign







III-4.3 การดูแลเฉพาะ

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่สำคัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

ก. การระงับความรู้สึกล

ข. การผ่าตัด

ค. อาหารและโภชนบำบัด

ง. การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

จ. การจัดการความปวด

ฉ. การฟื้นฟูสภาพ

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-4.3 การดูแลเฉพาะ (Specific Care)

ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่สำคัญอย่างทันทั่วทั้งที่ปลอดภัย เหมาะสม และตามมาตรฐานวิชาชีพ.

ก. การรับความรู้สึก

1

การประเมินผู้ป่วย

ค้นหาความเสี่ยง วางแผน ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ

2

การเตรียมผู้ป่วย/ญาติ

ได้รับข้อมูล มีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

3

กระบวนการรับความรู้สึก

ราบรื่น ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ

4

กระบวนการเสริม

ติดตามและบันทึกระหว่างระดับความรู้สึกและรอฟื้น
เตรียมพร้อมแก้ไขภาวะฉุกเฉิน
จำหน่ายจากบริเวณรอฟื้นตามเกณฑ์

5

เครื่องมือ วัสดุ ยา

ตามข้อกำหนดวิชาชีพแนะนำ

ข. การผ่าตัด

1

แผนการผ่าตัด

บันทึกแผนและการวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัด
ประเมินความเสี่ยง & ประสานผู้เกี่ยวข้อง

2

ให้ข้อมูลผู้ป่วย/ครอบครัว/ผู้ตัดสินใจแทน

ความจำเป็น ทางเลือก ความเสี่ยง

3

การเตรียมผู้ป่วย

ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดและการติดเชื้อ

4

การป้องกันการผ่าตัดผิด

ผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ

5

สิ่งแวดล้อมในการดูแลและผ่าตัด

มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

6

การบันทึกรายละเอียดการผ่าตัด

ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสาร/ดูแลต่อเนื่อง

7

การดูแลหลังการผ่าตัด

เหมาะสมกับผู้ป่วยและการผ่าตัด

ความเสี่ยงของผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ระยะก่อนผ่าตัด

การเตรียมความพร้อมของร่างกายและเอกสารไม่ครบถ้วน

- การงดน้ำ อาหาร
- การสวนอุจจาระ
- การเตรียมผิวหนัง การทำความสะอาดเฉพาะที่
- การให้ยา Premedication ทั้งชนิด ขนาด และวิธีการบริหารยา
- ผลการตรวจต่างๆทางห้องปฏิบัติการไม่ครบถ้วน
- ของแปลกปลอมที่ติดมากับตัวผู้ป่วย



No Food or Drink

ความเสี่ยงของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ระยะก่อนผ่าตัด

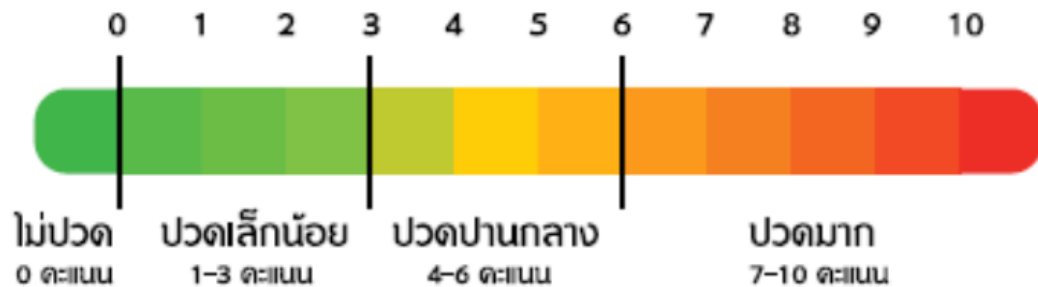
Welcome to the Wong-Baker FACES Foundation

The official home of the

Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale



This tool was originally created with children for children to help them communicate about their pain. Now the scale is used around the world with people ages 3 and older, facilitating communication and improving assessment so pain management can be addressed.



4. การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ

5. การพยาบาลผู้ป่วยใน Waiting room

Preoperative Assessment

- Age/ Height/ Weight/ Body mass index (BMI)
- Nutritional status
- Blood pressure
- Skin integrity
- ROM/ Physical limitations
- Internal/ External devices
- Preexisting conditions
- Medical history
- Psychological/Cultural considerations





Siriraj Surgical Safety Checklist

ดิฉัน(ชื่อ)..... เป็น Circulating Nurse ขอทำ Patient Safety Checklist ก่อนการรับความรูสึก

ก. ในห้องผ่าตัดก่อนเริ่มให้การรักษา

ความรูสึก : Sign in

(ผู้อำนวยการ พยาบาล และวิสัญญีแพทย์พยาบาล)

1. ให้อ่านใบการระบุตัวผู้ป่วย ตำแหน่ง ชนิดของบาดแผล รวมทั้งการขอความยินยอมในการทำการผ่าตัดหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
2. ให้อ่านเครื่องหมายระบุข้างที่จะทำการผ่าตัดหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
3. ได้ตรวจสอบเครื่องมือและยาที่จะใช้ในการผ่าตัด รับความรูสึก แล้วหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
4. ได้ติด pulse oximeter กับตัวผู้ป่วย และตรวจสอบว่า เครื่องทำงานปกติแล้วหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
5. ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาหรือแพ้สารเคมีหรือไม่ และหากมี สิ่งใดแพ้หรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี
6. ผู้ป่วยมีปัญหาในการสูดทางเดินหายใจ หรือมีความเสี่ยงในการสูดล้มหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี ได้เตรียมอุปกรณ์ และผู้ช่วยหรือไม่
7. ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิเมตร หรือ หากเป็นเด็กจะเสียเลือดมากกว่า 7 มิลลิเมตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมหรือไม่ ☐ ไม่ ☐ มี และได้ปรึกษาล่วงหน้าแล้วหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ลงชื่อ (ผู้กรอก)

ข. ก่อนเริ่มทำการผ่าตัด : Time out

(พยาบาล วิสัญญีแพทย์พยาบาล และศัลยแพทย์)

8. ยืนยันว่าสมาชิกทุกคนในห้องผ่าตัดได้มีส่วนร่วมและ
9. ยืนยัน ชื่อ-สกุลของผู้ป่วย... ชื่อโรค... และ ตำแหน่งที่จะผ่าตัด.....
10. ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัดหรือไม่ ภายใน 60 นาทีที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
11. ตำแหน่งบาดแผล : มีขั้นตอนการผ่าตัดที่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติหรือไม่ จะใช้กล้องผ่าตัดหรือไม่ และจะเก็บชิ้นส่วนอย่างไร ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
12. ตำแหน่งที่วิสัญญี : ผู้ป่วยมีประวัติที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
13. ตำแหน่งที่พยาบาล : ยืนยันว่าเครื่องมือปลอดเชื้อ มีประวัติการระวังเกี่ยวกับเครื่องมือหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี
14. มีฟิล์มเอกซเรย์ ที่จำเป็นหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

ลงชื่อ (ผู้กรอก)

ค. ก่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด :

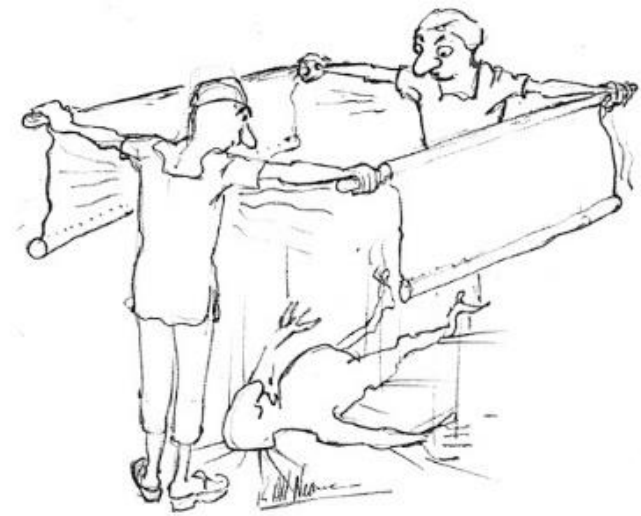
Sign out

(พยาบาล วิสัญญีแพทย์พยาบาล และศัลยแพทย์)

15. ทีมได้ทำการซักถาม... ถูกต้องหรือไม่
16. นับเครื่องมือผ้าพันแผล โลหะ เครื่องมือ ครบถ้วนหรือไม่
17. การเขียนฉลากสิ่งส่งตรวจครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
18. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้มีปัญหหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี
19. ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์พยาบาล และ พยาบาลผ่าตัด ทบทวนประเด็นปัญหาสำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษผ่าตัดว่ามีหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี

ลงชื่อ (ผู้กรอก)

The transfer of patient



- Damage to the cervical spine with unsupported head
- Damage to the limbs
- Patient falls
- Skin damage
- Damage from accidental Traction to infusion line, drainage or catheterization



ความเสี่ยงในห้องผ่าตัด ระยะผ่าตัด

ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง	Siriraj Surgical safety checklist
การเตรียมห้องผ่าตัด อุปกรณ์ สถานที่ ไม่พร้อม การใช้เครื่องมือพิเศษ	การ Care and Maintenance equipment การสื่อสารด้วยศัพท์ที่เข้าใจตรงกัน การบันทึกข้อมูลในระบบ OSS ที่ใช้ สื่อสารร่วมกัน
การได้รับยาระงับความรู้สึกทางวิสัญญี	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 93 การดูแลโรคร่วม ประวัติการเจ็บป่วย

ความเสี่ยงในห้องผ่าตัด ระยะผ่าตัด

ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
การแพ้ยา	การบริหารยา การรายงาน บันทึกใน ADR
การใส่ท่อช่วยหายใจลำบาก	การ Pre anesthesia assessment
การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ผิดชนิด ขนาด และวิธีการใช้	การระบุ การอ่านทบทวน ทำโดยใช้ความรอบคอบ ก่อนการใช้งาน ศึกษาวิธีการใช้งาน





- (4) กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาลโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม²¹²
- (5) ผู้ป่วยได้รับการติดตามและบันทึกข้อมูลการดูแลขณะระงับความรู้สึกและในช่วงรอฟื้น
- (6) ผู้ป่วยได้รับการจำหน่ายจากบริเวณรอฟื้นโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีการส่งต่อข้อมูลไปให้แก่ทีมผู้ดูแลหลังผ่าตัดเพื่อเกิดการดูแลต่อเนื่อง

ข. การผ่าตัด (Surgical Care)

- (1) ทีมผู้ให้บริการวางแผนการดูแลสำหรับผู้ป่วยที่จะรับการผ่าตัดแต่ละราย โดย:
 - (i) นำข้อมูลจากการประเมินผู้ป่วยทั้งหมดมาพิจารณา;
 - (ii) มีการบันทึกแผนการผ่าตัด และการวินิจฉัยโรคก่อนการผ่าตัดไว้ในเวชระเบียน;
 - (iii) มีการประเมินความเสี่ยงและประสานกับผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลที่ปลอดภัย
- (2) ทีมผู้ให้บริการอธิบายความจำเป็น ทางเลือกของวิธีการผ่าตัด²¹³ โอกาสที่จะต้องใช้เลือด ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วย

²¹² บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามมาตรฐานองค์การวิชาชีพด้านวิสัญญี อ้างอิงประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานการระงับความรู้สึก ปัจจุบัน

²¹³ วิธีการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดแบบดั้งเดิม การผ่าตัดแผลเล็ก การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เป็นต้น



- (3) ทีมผู้ให้บริการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อม ลดความเสี่ยง จากการผ่าตัดและการติดเชื้อ ทั้งในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน กรณีผ่าตัดที่มีกำหนดนัดล่วงหน้า รวมถึงการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
- (4) ทีมผู้ให้บริการมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจในการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ
- (5) ผู้ป่วยได้รับการดูแลและผ่าตัดภายใต้สภาวะที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย²¹⁴
- (6) ทีมผู้ให้บริการบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดในเวชระเบียนผู้ป่วยในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงานผู้ให้บริการ และเกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา
- (7) ทีมผู้ให้บริการติดตามดูแลหลังผ่าตัดที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย และลักษณะการทำหัตถการ

ค. อาหารและโภชนาบำบัด (Food and Nutrition Therapy)

- (1) ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย โดยมีระบบบริการอาหารที่ดี มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการอาหารและโภชนาการ²¹⁵ ตลอดจนมีการดำเนินการมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

²¹⁴ การดูแลและการผ่าตัดภายใต้สภาวะที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย หมายถึง การจัดแบ่งพื้นที่ การกำหนดการไหลเวียน และการป้องกันการปนเปื้อนในห้องผ่าตัด การทำความสะอาดบริเวณห้องผ่าตัดและเตียงผ่าตัด การทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ผ่าตัดและทำให้ปราศจากเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์/เจ้าหน้าที่ช่วยผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย การดูแลระหว่างรอผ่าตัด การตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดการกับชิ้นเนื้อที่ออกมาจากผู้ป่วย การเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติกับผู้ป่วย

²¹⁵ ความเสี่ยงจากการให้บริการอาหารและโภชนาการ เช่น ผู้ป่วยไม่ได้รับอาหารในเวลาที่เหมาะสม การจัดอาหารที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้ให้ผู้ป่วย การเตรียมอาหารที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยอาจสำลักได้ เป็นต้น

Prepare Implant/Prosthesis



Checklist for

- ✓ Type / Back up Instrument
- ✓ Size / Side
- ✓ Packaging
- ✓ Expire date

Pneumatic Tourniquet



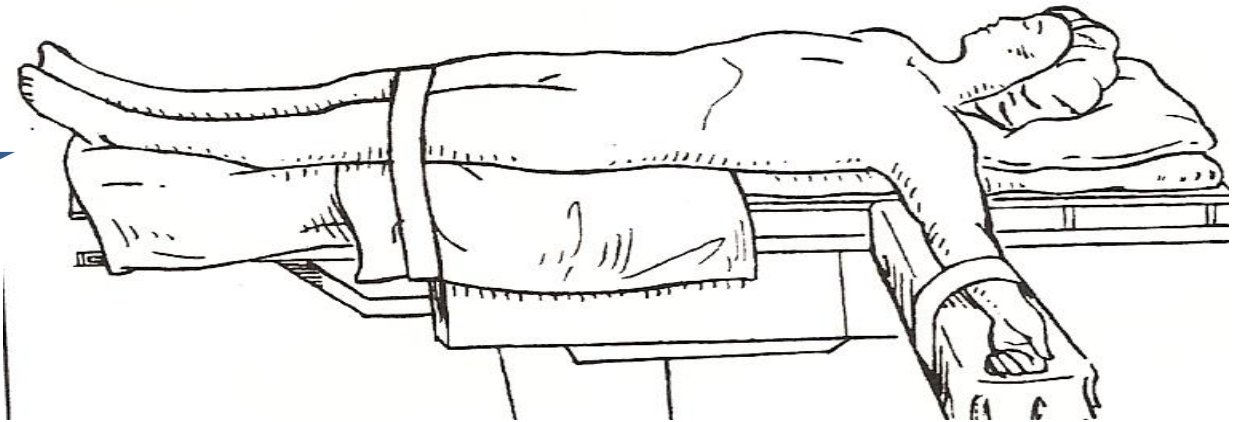


© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

2'' above knee level
with 3 fingers breath

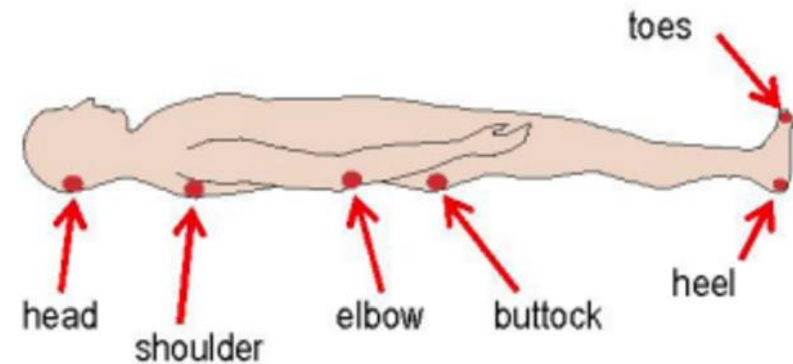
compressed against stirrup bar/Knee strap and
can cause!

- foot drop
- loss of dorsal extension of the toes
- inability to evert the foot
- loss of sensation below the knee



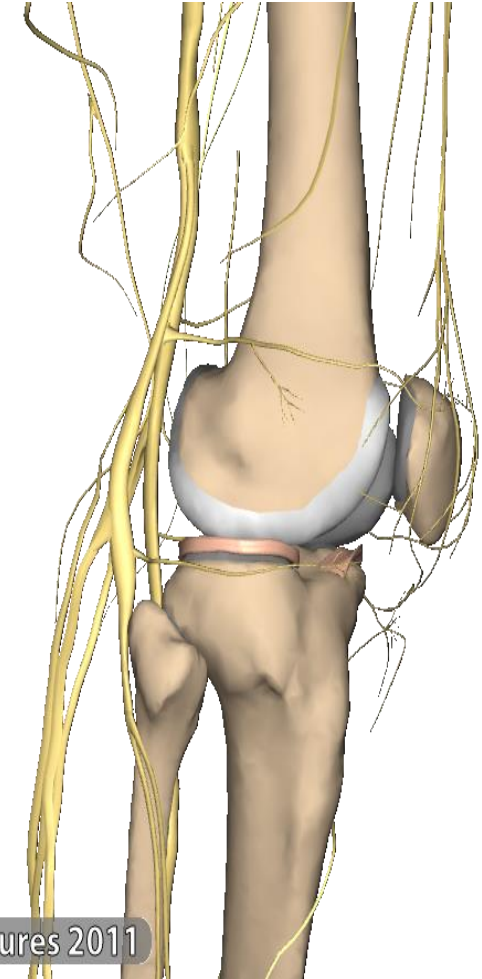
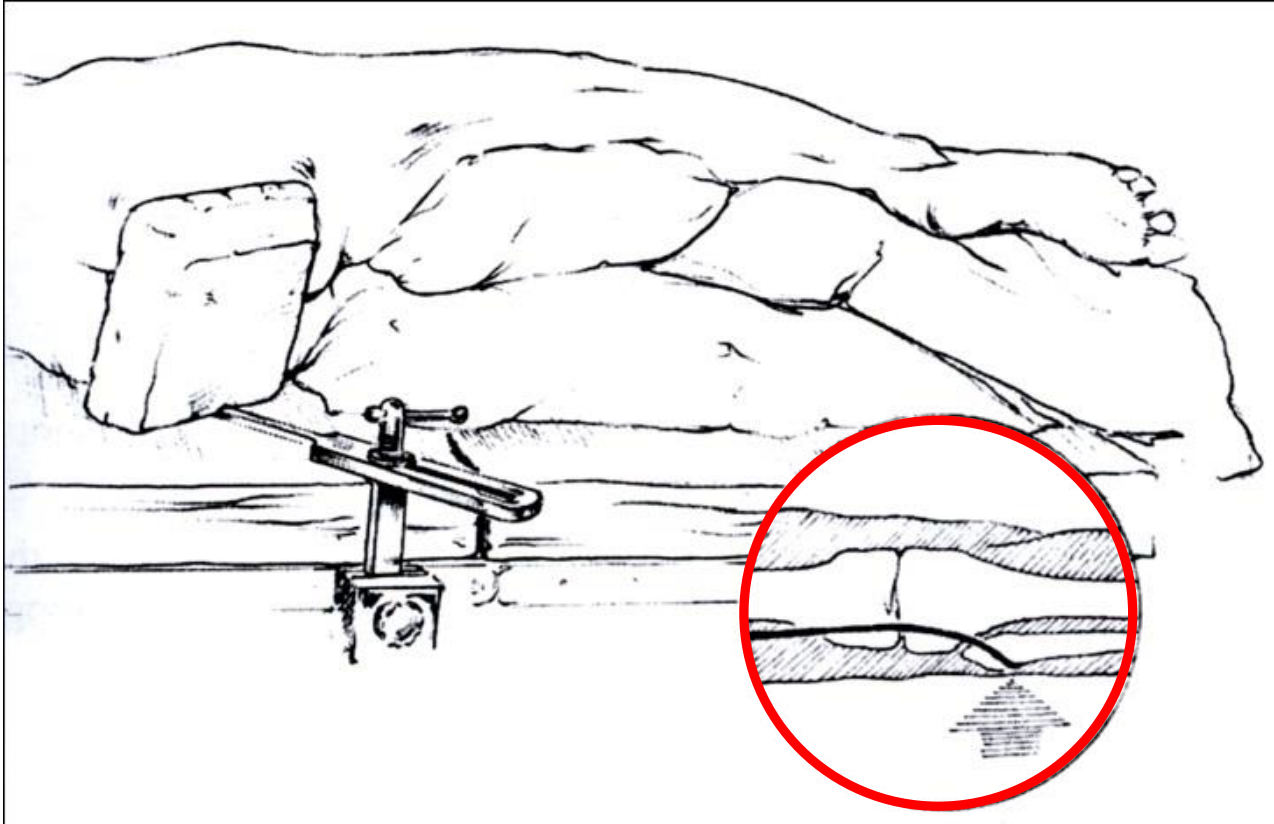
Anatomic Locations of Pressure Ulcers

1. Sacrum	36.9%
2. Heel	30.3%
3. Ischium (sit bone)	8.0%
4. Elbow	6.9%
5. Malleolus (ankle bone)	6.1%
6. Trochanter (hip bone)	5.1%
7. Knee	3.0%
8. Scapula (shoulder blade)	2.4%
9. Occiput (back of head)	1.3%



“Incidents for ORAPU - between
8.5% and 66%”

Injured to Common Peroneal Nerve



© Primal Pictures 2011

PRIM

ความเสี่ยงในห้องผ่าตัด ระยะผ่าตัด



ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
การจัดท่าในการผ่าตัด โอกาสเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือด จากแรงกดทับ เสียดลี การใช้เครื่องมือรัดห้ามเลือด(Pneumatic tourniquet)	การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ MEWS Reassessment KM Device
การติดเชื้อจากการผ่าตัด SSI	SSI Bundles
การมีสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด , ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ	WI, Sign out
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการผ่าตัด น้ำยาที่มีแอลกอฮอล์	การเลือกใช้ชนิดน้ำยา อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบดูแล
การเกิดอันตรายจากการใช้รังสี	การใช้ Protection device การตรวจสอบ
การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อผิวหนังบริเวณรอบๆ จากการดึงรั้ง การกดทับ	การประเมิน และ การสื่อสารภายในทีม การส่งต่อ ข้อมูล
การเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ	การยืนยันความถูกต้อง การส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด WI

Prepare Implant/Prosthesis

PFC SIGMA: JOHNSON&JOHNSON			
	☐ Rt. ☐ Lt.	SIZE	EXP. time out
Femur	☐ Femoral Posterior Stabilized Lugged Cemented		☐ Yes
	☐ Femoral Posterior Stabilized Cemented		
	☐ Femoral Cruciated Retaining Cemented		
	☐ Femoral CR150 Cemented		☐ Yes
	☐ Femoral Posterior Stabilized Cemented TC 3		
Fluted Femoral Stem	กรณีที่ไม่ใส่ sleeve		
	Cementless		
	☐ 5 degree ☐ ยาว 125 ☐ ยาว 175		
	☐ 7 degree ☐ ยาว 125 ☐ ยาว 175		☐ Yes
	Cemented		
	☐ 5 degree, 7 degree มีเฉพาะ Ø 13x90 mm.		
	กรณีที่ไม่ใส่ sleeve		
	☐ Cementless ☐ ยาว 75 ☐ ยาว 115		
	☐ ยาว 150		
	☐ Cemented มีเฉพาะ Ø 13x30 mm. และ Ø 13x60 mm.		☐ Yes
Augment	☐ Distal นาน..... ☐ Lt. ☐ Rt.		☐ Yes
	☐ Posterior นาน.....		☐ Yes
	กรณีที่ไม่ใส่ sleeve		
	☐ Femoral Stem Bolt มี Neutral, +2/-2		
	☐ Off Stem Femoral Bolt มี Neutral, +2/-2		☐ Yes
	กรณีที่ไม่ใส่ sleeve		
	☐ Universal femoral sleeve distal porous (มี 31, 34, 40 mm.)		☐ Yes
	☐ Femoral Adapter มี 5 degree, 7 degree		
	☐ Femoral Adapter Bolt มี Neutral, +2/-2		
	Tibia	☐ tibial tray fixed bearing modular TITANIUM	
☐ tibial tray fixed bearing modular COCR			
☐ tibial tray fixed bearing modular plus			☐ Yes
☐ tibial tray fixed bearing off-set			
☐ tibial tray rotating platform M.B.T. revision			
Rod	☐ Cementless ☐ ยาว 75 ☐ ยาว 115		
	☐ ยาว 150		☐ Yes
Wedge	☐ Cemented มีเฉพาะ Ø 13x30 mm. และ Ø 13x60 mm.		
	☐ Hemi wedge มี 10 degree, 20 degree นาน.....		
Sleeve	☐ Step wedge (fixed tibial tray) มี 10 mm., 15 mm.		☐ Yes
	☐ Step wedge (M.B.T) มี 10 mm., 15 mm.		
Articular	☐ Metaphyseal Sleeve Porous (M.B.T. Revision) (มี 29, 37, 45, 53 mm.)		☐ Yes
	☐ Fixed bearing curved (CVD) นาน.....		
	☐ Fixed bearing stabilize (STB) นาน.....		
	☐ Fixed bearing posterior-lipped (PLI) นาน.....		
	☐ Fixed bearing Stabilize Plus (STB+) นาน.....		☐ Yes
	☐ Fixed bearing TC3 (TC3) นาน.....		
	☐ RP tibial insert นาน.....		
	☐ TC3 RP Tibial insert นาน.....		
Patella	☐ 32, 35, 38		☐ Yes



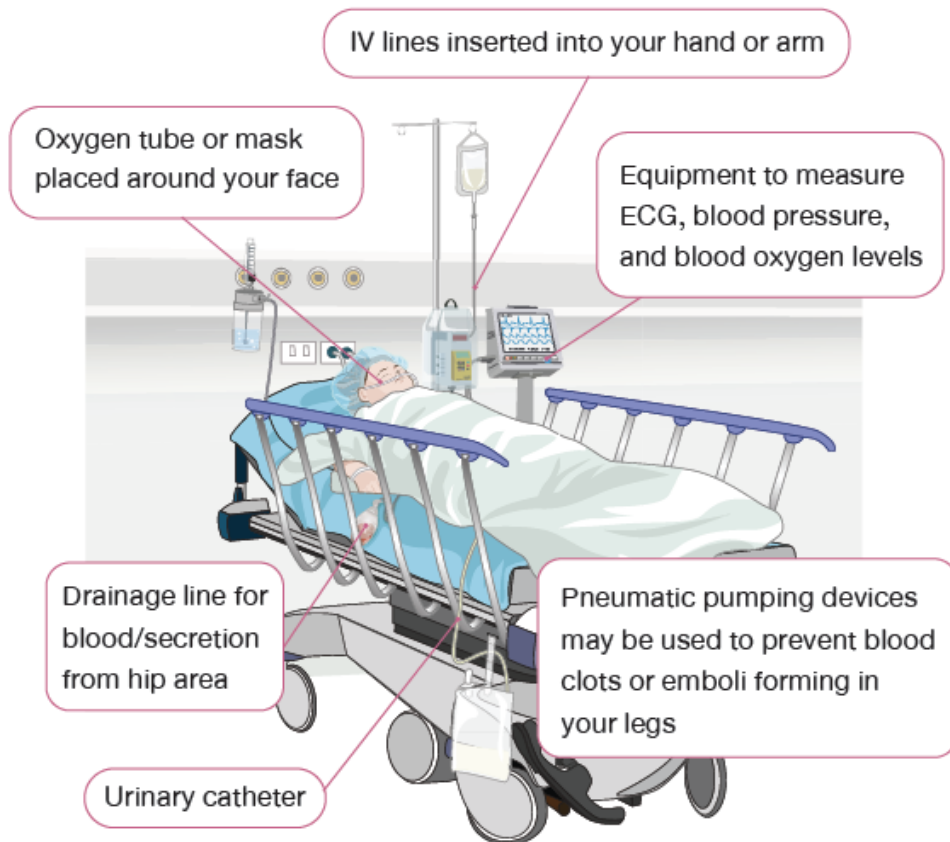
Confirm Type /Side /Exp.



- Type
- Back up Instrument
- Size / Side
- Packaging
- Expire date



Work Instruction



	วิธีปฏิบัติงาน	หน้า : 1 / 4
	เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัด ในห้องพักฟื้น	รหัสเอกสาร : NS-04-3-002-03 บททวนครั้งที่ : 3 วันที่อนุมัติ : 4/3/2559
	ชื่อหน่วยงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด	วันที่หมดอายุ : 4/3/2562
	ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด	ผู้อนุมัติ : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ

7.13 ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น ประเมินการกลับฟื้นคืนสภาพจากการได้รับยา
ระงับความรู้สึกโดยใช้ Post Anesthetic Recovery Score ให้อยู่ในเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ
9 คะแนนขึ้นไป และสภาวะทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติและ / หรือ คงที่ นานเกิน 30 นาที รายงานให้วิสัญญี
แพทย์ทราบเพื่อพิจารณาจำหน่ายผู้ป่วยเฉพาะในรายที่ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลพิเศษจากวิสัญญี
แพทย์ และ Post Anesthetic Recovery Score น้อยกว่า 9 คะแนน

7.14 กรณีส่งผู้ป่วยไปหอผู้ป่วย

7.14.1 ติดต่อหอผู้ป่วยที่รับย้าย พร้อมทั้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย และความ
ต้องการอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยมีสภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับหลังการผ่าตัด

7.14.2 รวบรวมเอกสาร รายงาน फिल्मเอ็กซเรย์ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ส่งต่อให้ครบถ้วน

7.14.3 โทรศัพท์แจ้งพนักงานเคลื่อนย้าย เพื่อจัดเตรียมเปลหรือรถนั่งไปส่งผู้ป่วยตาม

ความเหมาะสม

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว

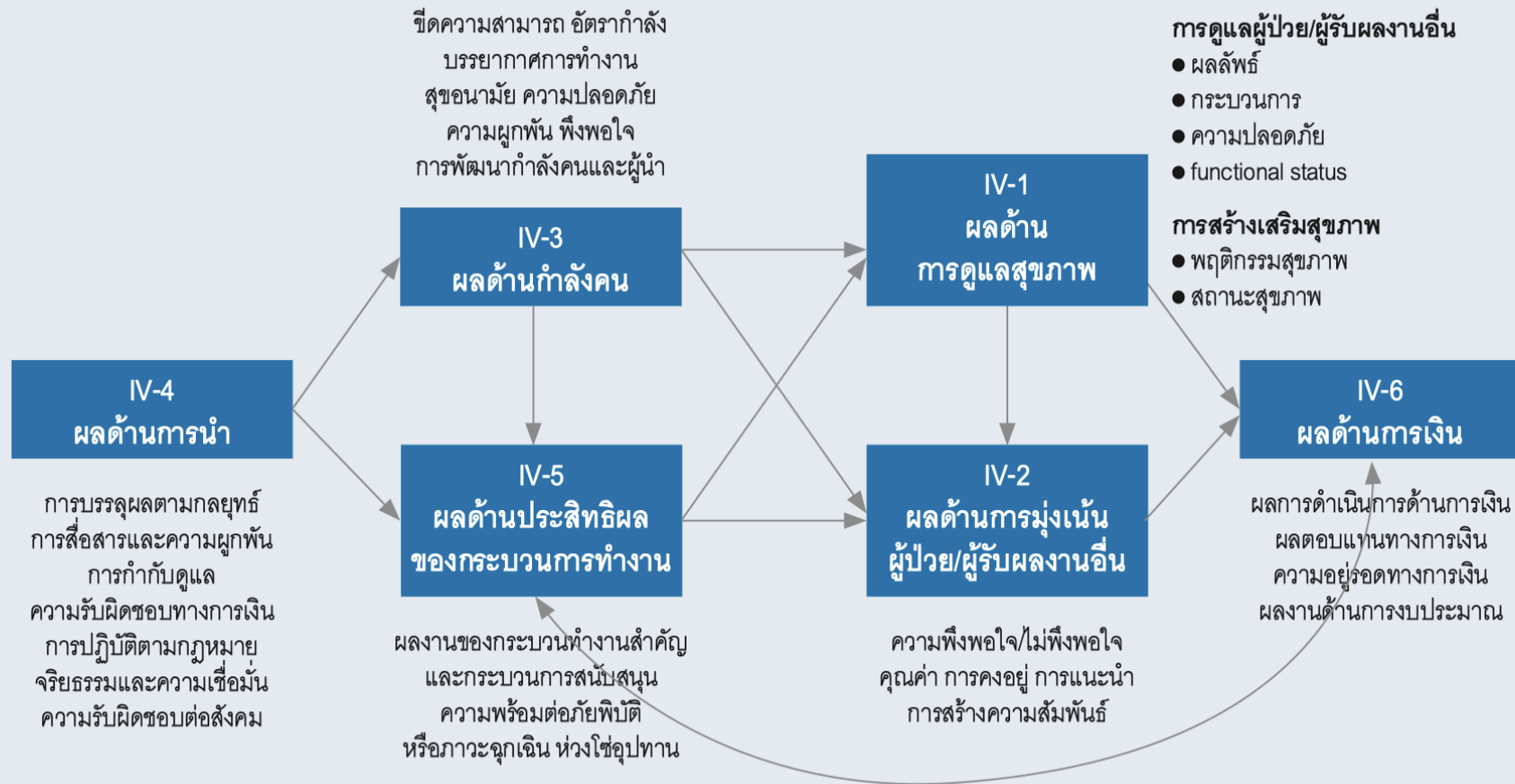
ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว และกิจกรรมที่วางแผนไว้เพื่อเสริมพลังผู้ป่วย/ครอบครัวให้มีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขั้นตอนของการดูแล.

III-6 การดูแลต่อเนื่อง

ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ให้ผลดี.

ตอนที่ IV พลัฟร์

องค์กรแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ผลด้านการดูแลสุขภาพ (รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ) ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น ผลด้านกำลังคน ผลด้านการนำ ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน และผลด้านการเงิน.





SiELITE

Siriraj Hip and Knee
Joint replacement Excellent Center

- ผลลัพธ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ทั้งด้านผลลัพธ์ กระบวนการ และเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่แข่งที่เหมาะสม
 - ผลลัพธ์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณค่าจาก มุมมองของผู้รับบริการ และเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่แข่งที่เหมาะสม (ถ้ามี)
 - ผลลัพธ์เกี่ยวกับความผูกพัน ความพึงพอใจ ซีดความสามารถและทักษะของบุคลากร และเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่แข่งที่เหมาะสม (ถ้ามี)
 - ผลลัพธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่แข่งที่เหมาะสม (ถ้ามี)
 - ผลลัพธ์เกี่ยวกับการบรรลุผลตามแผน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่แข่งที่เหมาะสม (ถ้ามี)
- ** มีคู่แข่งที่เหมาะสมและส่งเสริมให้มีคู่แข่งระดับสากล ซึ่งจะยกคุณค่าและระดับของการบริการที่เป็นเลิศ**

ข้อมูล	คำนิยาม
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด (คน)	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเดือน หรือทุก 3 เดือน
Compliance ทั้งหมด (%)	ร้อยละที่ผู้ป่วยปฏิบัติตาม Protocol Checklist ได้ครบถ้วน ในช่วงต่างๆ - Pre-operative at OPD - Pre-operative at ward - Intra-operative at OR - Post-operative at ward
Mortality (%)	อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล (in-hospital mortality)
Complications (%)	ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล แบ่งเป็นประเภท minor และ major complications โดยนิยามระดับความรุนแรงตาม Clavien-Dindo classification
Length of stay -mean (days)	จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล จำนวนวันโดยเฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน 1 คน ที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลจนจำหน่ายในระยะ เวลาที่กำหนด โดยเฉลี่ยจากวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน ต่อจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่าย ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
Length of stay-median (days)	ค่ามัธยฐานของจำนวนวันนอน เนื่องจากวันนอนอาจจะมีการแจกแจงแบบไม่เป็นมาตรฐาน (non-normal distribution)
ร้อยละของผู้ป่วยที่ LOS ได้ตามเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่จำนวนวันนอนทำได้ตามเป้าหมาย
Re-operation (%)	การผ่าตัดซ้ำ (กรณีผู้ป่วยใน) หมายถึง การผ่าตัดซ้ำด้วยโรคเดียวกันตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ในการรับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในครั้งเดียวกันโดยไม่ได้อำนาจแผน หรือเป็นการผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดครั้งแรกซึ่งเป็นการผ่าตัดฉุกเฉิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการผ่าตัดที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการผ่าตัดแยกเป็นหลายครั้งเป็นการผ่าตัดทีละส่วน
Re-admission (%)	ร้อยละการรับกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดครั้งก่อนภายใน 28 วันภายหลังการจำหน่ายโดยไม่ได้อำนาจแผนไว้ล่วงหน้า
Ambulation KPI	การฝึกเคลื่อนที่ไปมา, ลุกจากเตียง, การให้ลุกจากเตียง โดยมีข้อกำหนดต่างๆ โดยมีแบบประเมินการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น บริหารปอด, บริหารข้อเท้า, นั่งศีรษะสูง ≥ 2 ชม. และเดินระยะ 20 m
Quality of life (optional)	เป็นการเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย Pre-ERAS และ Post-ERAS
Patient satisfaction	แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการโปรแกรมการฟื้นตัวเร็วหลังผ่าตัด (ERAS) ทางทีมกลางจะ provide ข้อมูลให้
Others	



- Train** คือการเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบกับการนำไปปฏิบัติ
- Monitor** คือการติดตาม compliance ในระบบที่วางหรือความก้าวหน้าของการพัฒนา (เรื่องที่ปฏิบัติจนเข้าฝักแล้ว อาจจะมีความจำเป็นน้อยลง)
- Trace** ทำให้เห็นปัญหาในการปฏิบัติงาน และค้นพบปัญหาใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป

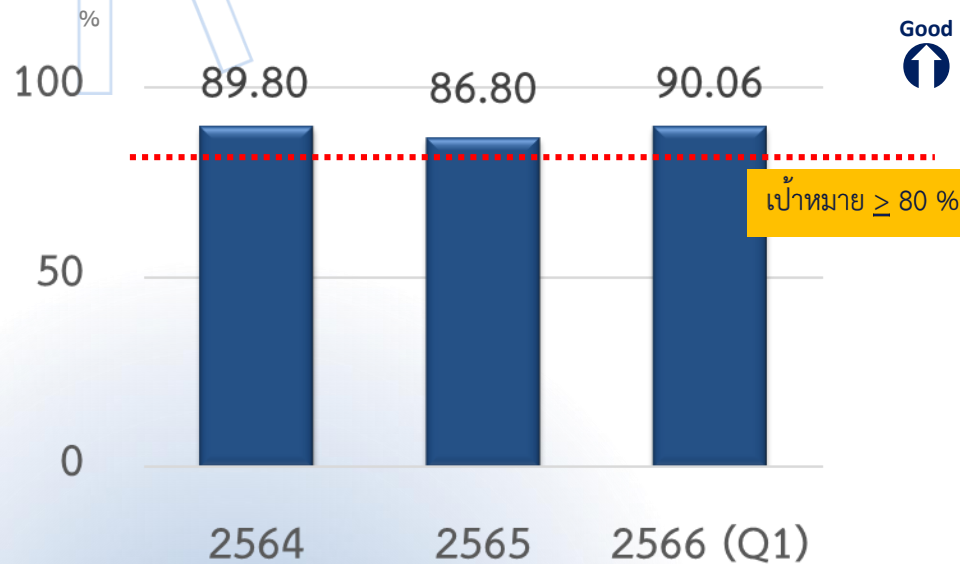


SPA คือ อะไร

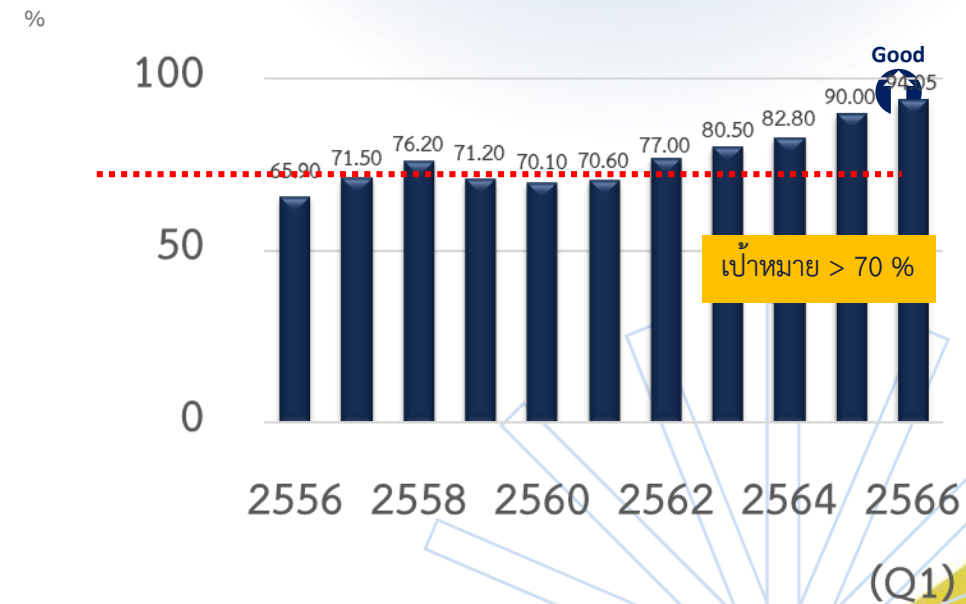
SPA		3P
Standards	นำมาตรฐาน	Purpose
Practice	มาสู่การปฏิบัติ	Process
Assessment	ประเมินให้เห็นชัด	Performance

KPI result

อัตราผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ ร่วมกับการใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินภายใน 1 วันหลังผ่าตัด (%)



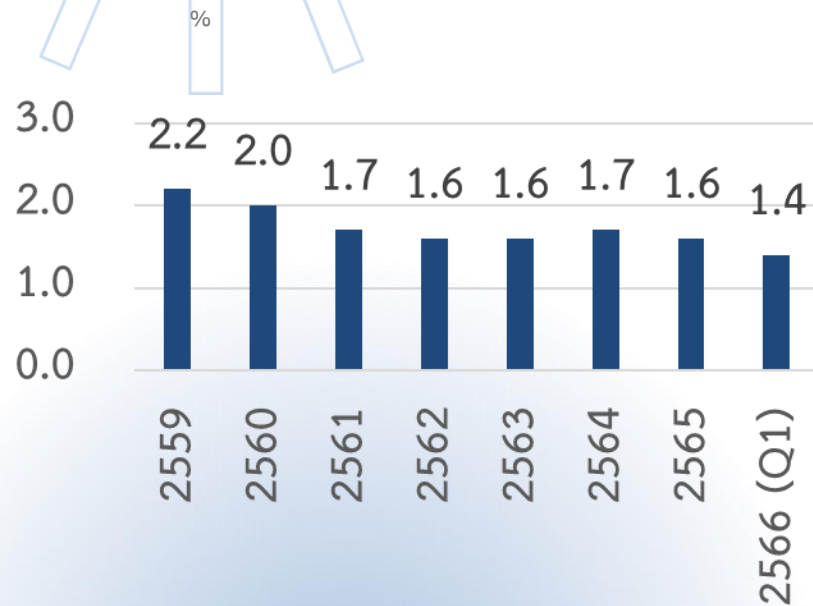
อัตราผู้ป่วยสามารถลงเขาได้ ≥ 90 องศา before discharge (%)



* 2566 (Q1) หมายถึง ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565)

KPI result

ค่าเฉลี่ยวันที่ผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้ ≥ 10 เมตร โดยมีผู้ช่วยเหลือร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน หลังผ่าตัด (วัน)



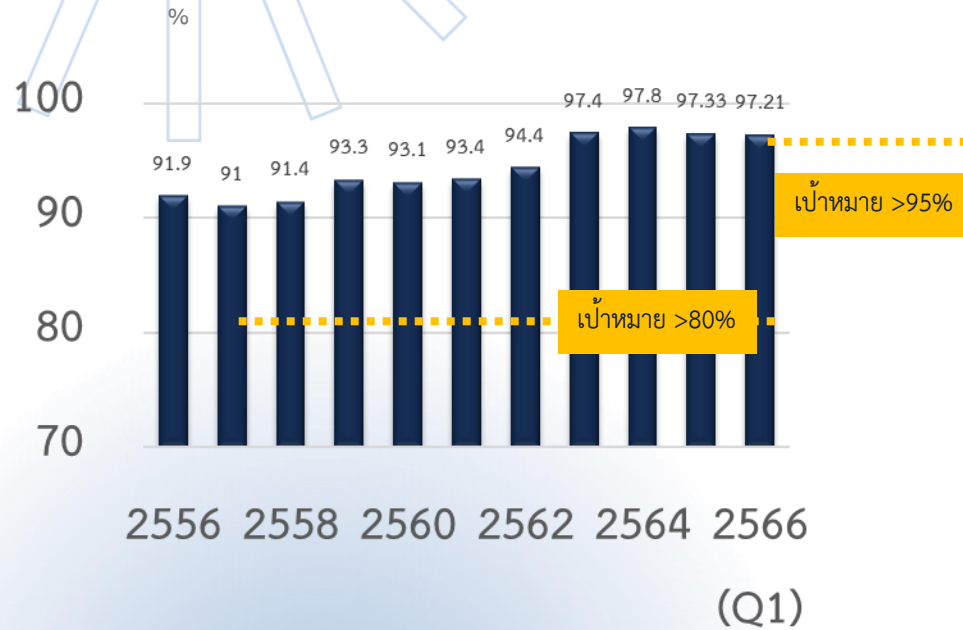
อัตราผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้ ≥ 10 เมตร โดยมีผู้ช่วยเหลือร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินหลังผ่าตัดในแต่ละวัน (%)

Good
↓

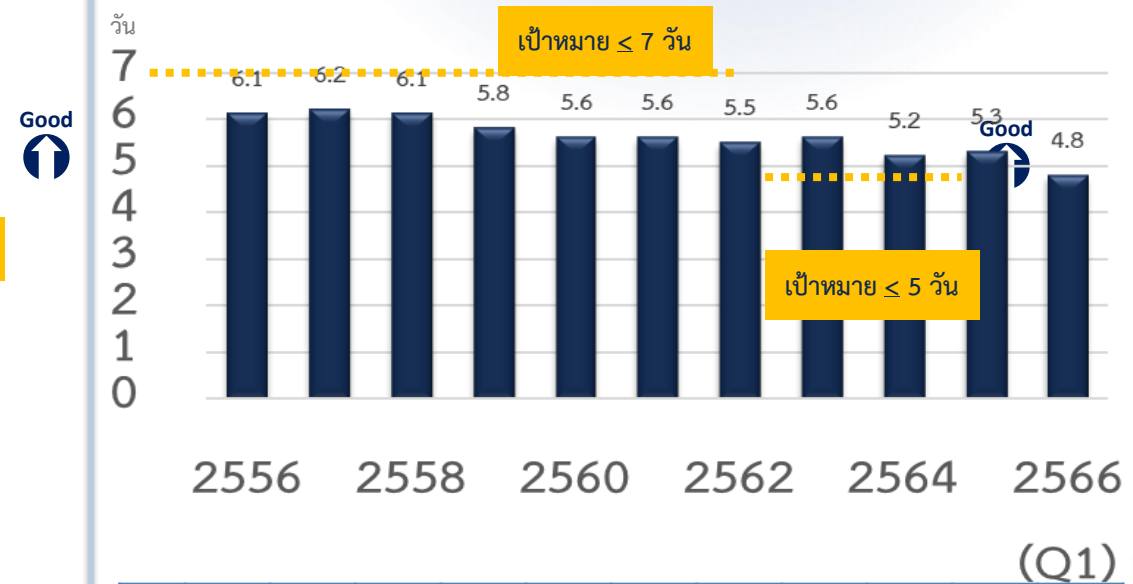
	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566 (Q1)
D1	19.80	26.63	45.71	52.17	51.22	46.36	52.31	63.74
D2	47.44	46.05	33.87	33.18	28.63	35.85	30.71	23.98
D3	14.51	14.43	11.51	8.37	8.29	7.28	7.49	6.43
D4	7.34	3.26	2.59	1.94	1.69	3.23	2.12	1.17
D5	1.54	1.37	0.49	0.45	0.75	0.81	1.00	0.00
>D5	0.85	0.34	0.16	0.45	0.19	0.54	0.12	0.00
unable ambulate	0.51	0.00	0.00	0.00	0.19	0.27	0.25	0.58

KPI result

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย (%)



จำนวนวันนอนของผู้ป่วย (วัน)



min	2	3	3	3	1	3	1	2	1	2	3
max	30	40	41	38	25	70	27	24	24	46	15
mode	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4

* 2566 (Q1) หมายถึง ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565)



บริการที่มีคุณภาพในทุกมิติ

มี	
ดี	Effective
เข้าถึง	Access
พึงพอใจ	Accept/Responsive
ด้วยหัวใจ	Humanize
เหมาะสม	Appropriate
คุ้มค่า	Efficient
เวลาเหมาะสม	Timeliness
สามารถ	Competency
ปลอดภัย	Safety
ต่อเนื่อง	Continuity
ทั่วถึง	Coverage
เป็นธรรม	Equity

Accept
Access
Appropriate
Competency
Continuity
Coverage
Effective
Efficient
Equity
Humanize
Responsive
Safety
Timeliness



Multidisciplinary team



SiHIP

Siriraj Hip Fracture Professional



ศูนย์บูรณาการกระดูกสะโพกหักศิริราช

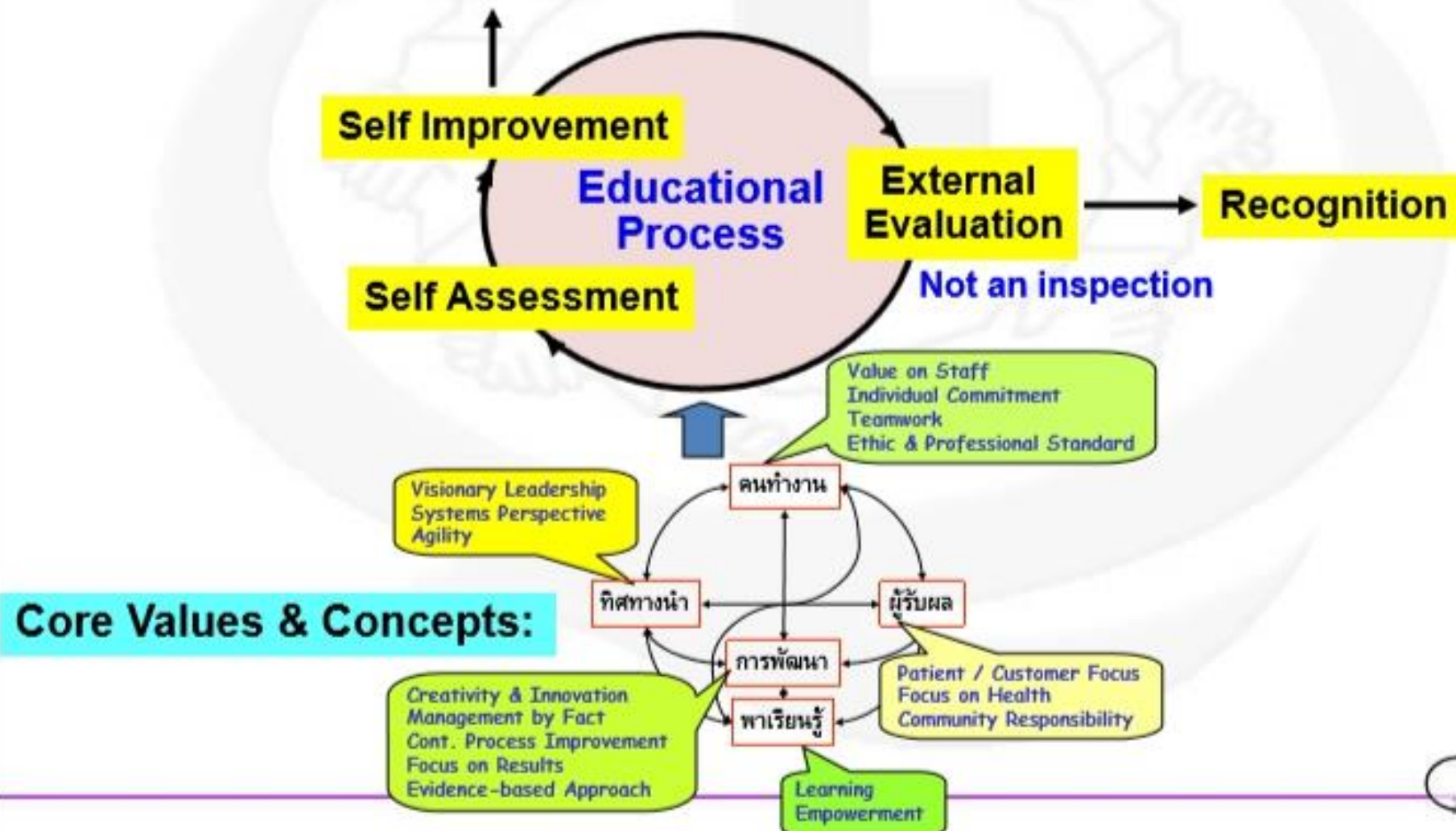


Basic Concepts of Hospital Accreditation



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

Safety & Quality of Patient Care





“...ผู้ที่สมัครใจเลือกวิชาชีพพยาบาล
เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง
เพราะเป็นผู้ที่มีใช้เพียงแต่ประกอบอาชีพ
โดยใช้กำลังแรงและกำลังกายเท่านั้น
แต่ต้องใช้กำลังใจอย่างแรงกล้า
ในการปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ อดทน
พร้อมทั้งรักษาความซื่อสัตย์ สุจริตและมีเมตตากรุณา
คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับพยาบาล...”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์
องค์อุปถัมภ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในพิธีทรงเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาสันติธรรม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓